



*"La piel
también cuenta
historias"*



BADBEAR.MED

Aprende Medicina. Comprende la Ciencia. Domina la Clínica.

CIENCIA
DISCIPLINA
HUMANIDAD



WAJOMEA.GROUP

M E D I C I N A

DERMATOLOGÍA

CLÍNICA | DIAGNÓSTICO | PATOLOGÍA | TERAPÉUTICA | PROCEDIMIENTOS

EDICIÓN ACADÉMICA 2026



LESIONES
ELEMENTALES



DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL



DERMATOSCOPIA



ENFERMEDADES
FRECUENTES



TRATAMIENTO
ACTUALIZADO

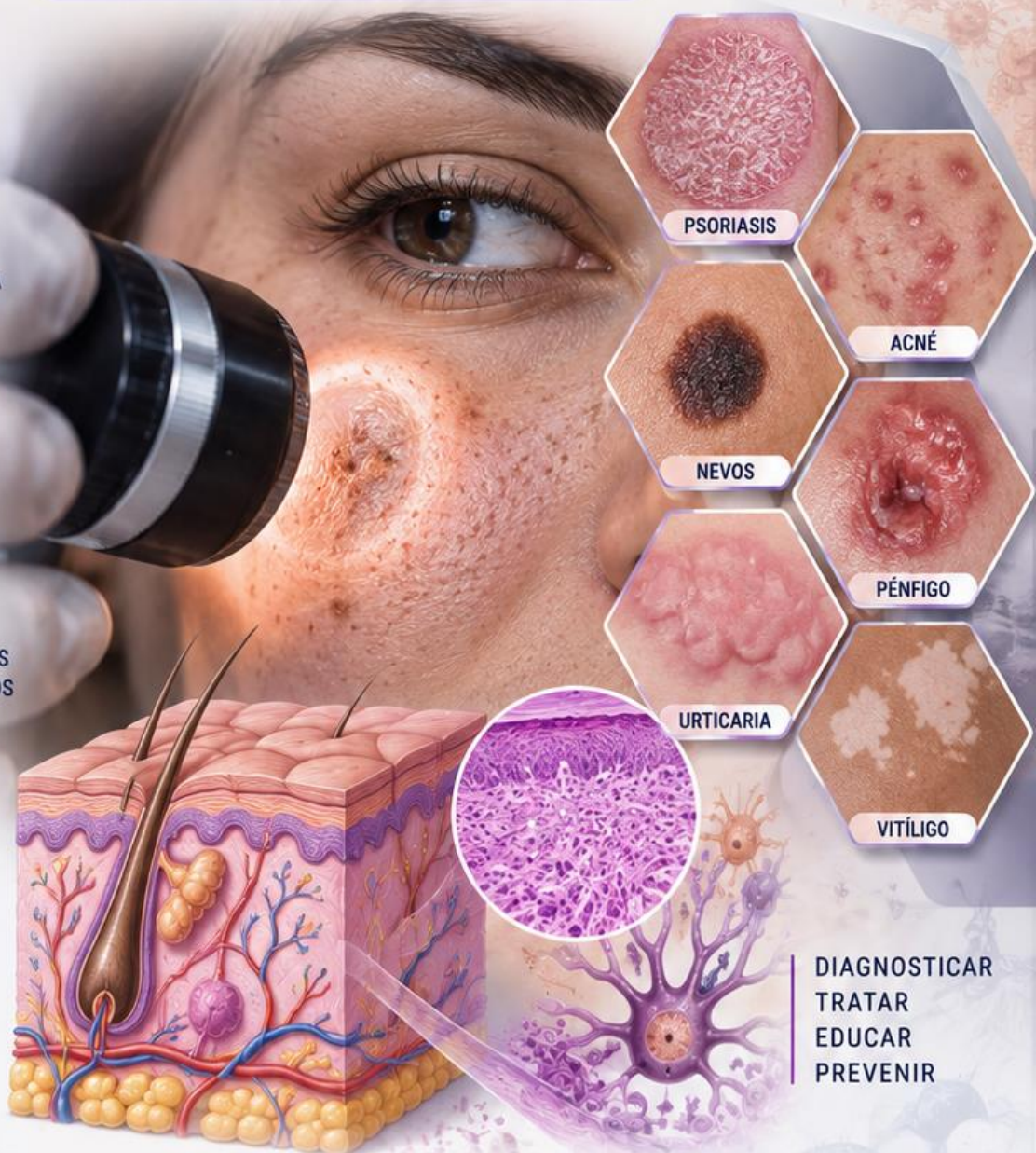


PROCEDIMIENTOS
DERMATOLÓGICOS



DERMATOLOGÍA
EN CONTEXTOS
ESPECIALES

*"Más que piel,
personas" ♥*



DIAGNOSTICAR
TRATAR
EDUCAR
PREVENIR

CONOCIMIENTO QUE TRASCIENDE



@badbear.med



@badbear.med



BADBEAR.MED



t.me/badbear_med



vk.com/badbear_med



facebook.com/badbear.med

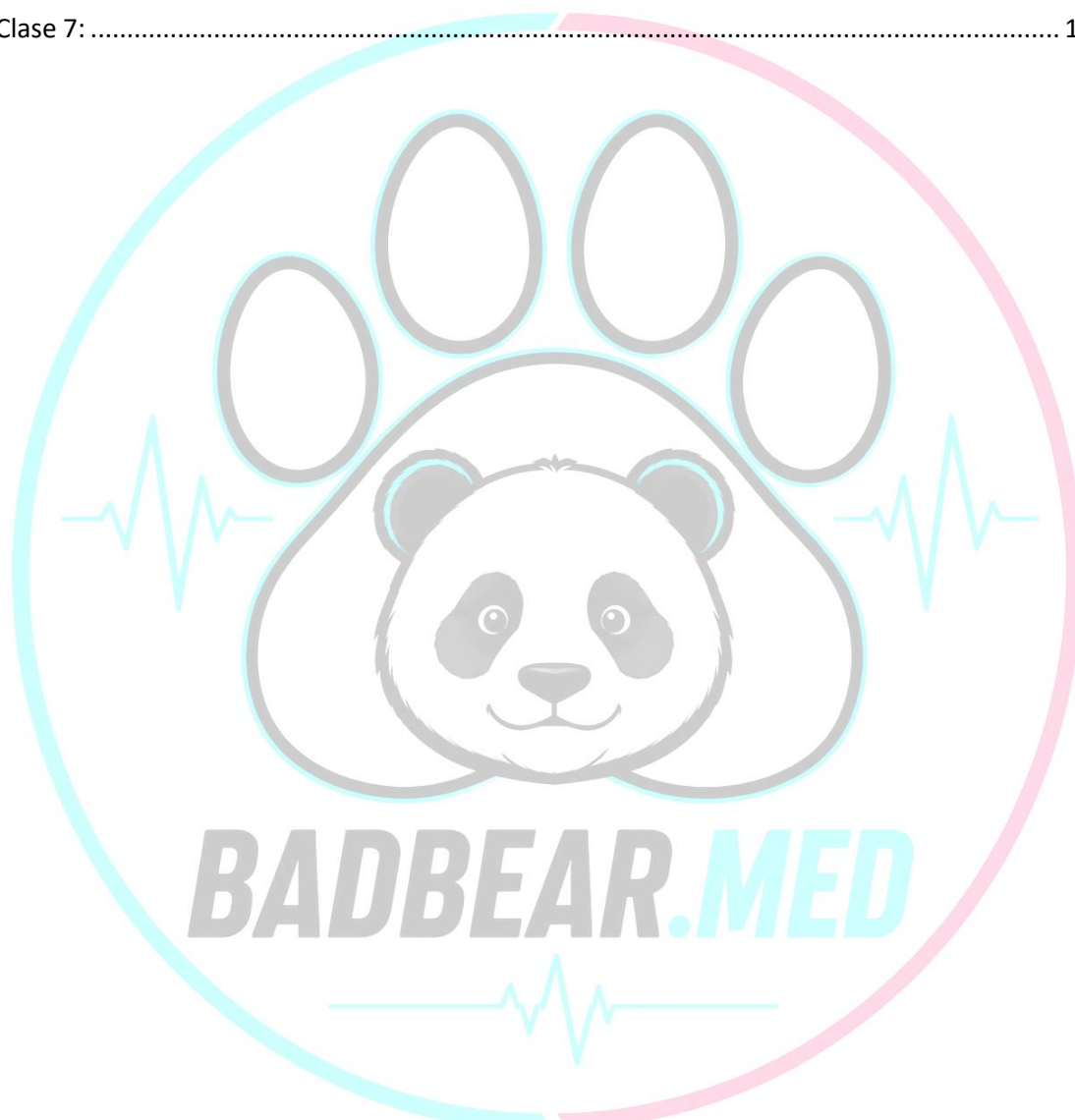


onlyfans.com/badbear.med



BADBEAR.MED CONTENIDOS

Clase 1: anatomía de la piel.....	1
Clase 2:	24
Clase 3	48
Clase 4:	66
Clase 5:	94
Clase 6:	119
Clase 7:	150



Clase 1: anatomía de la piel

Enlace del video original: [Clase 1 Anato y fisio de la piel Lesiones elementales](#)

Material audiovisual en el canal de [badbear.med](#)

ANATOMÍA GENERAL DE LA PIEL Y EPIDERMIS

1. Introducción

La piel es una estructura compleja que recubre la superficie corporal y establece una relación permanente entre el organismo y el medio externo. Aunque a simple vista puede parecer una cubierta uniforme, su superficie presenta pliegues, relieves, surcos y numerosos orificios relacionados con los anexos cutáneos.

Desde el punto de vista estructural, la piel se organiza fundamentalmente en tres niveles:

epidermis → dermis → hipodermis.

Cada uno posee una composición celular y una función diferente. La epidermis constituye la capa más externa; la dermis proporciona soporte estructural y nutricional; y la hipodermis representa un plano profundo rico en tejido adiposo que relaciona la piel con las estructuras subyacentes.

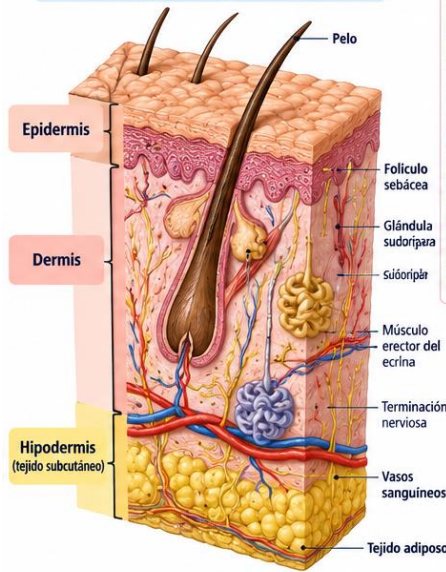
Comprender esta organización es indispensable para estudiar Dermatología porque muchas manifestaciones clínicas dependen directamente de la estructura cutánea que se encuentre alterada.



LA PIEL

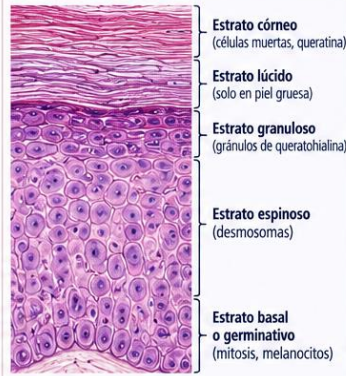
ESTRUCTURA Y CAPAS

Órgano más grande del cuerpo humano
Barrera, protección y homeostasis



EPIDERMIS

Epitelio plano estratificado queratinizado (Avascular)



Estrato córneo
(células muertas, queratina)

Estrato lúcido
(solo en piel gruesa)

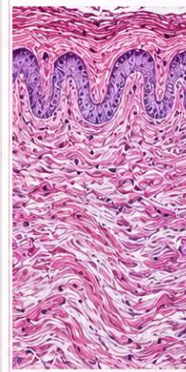
Estrato granuloso
(gránulos de queratohialina)

Estrato espinoso
(desmosomas)

Estrato basal o germinativo
(mitosis, melanocitos)

DERMIS

Tejido conectivo (Vascular, con nervios y anexos cutáneos)

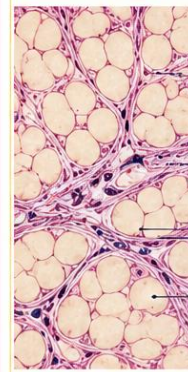


Capa papilar
(tejido conectivo laxo, papilas dérmicas)

Capa reticular
(tejido conectivo denso irregular, colágeno y elastina)

HIPODERMIS

Tejido subcutáneo (Conectivo laxo y adiposo)



Lóbulos de tejido adiposo

Septo conectivo

Vasos de mayor calibre

Nervios

EPIDERMIS (5 estratos)

Estrato córneo	Células muertas anucleadas ricas en queratina. Función de barrera.
Estrato lúcido	Solo en piel gruesa (palmas y plantas). Células claras, sin núcleos.
Estrato granuloso	Células con gránulos de queratohialina y filagrina.
Estrato espinoso	Células unidas por desmosomas ("aspecto espinoso").
Estrato basal o germinativo	Células madre, melanocitos, células de Merkel. Mitosis.

Células principales de la epidermis

Queratinocitos	> 90 % (producen queratina)
Melanocitos	(producen melanina)
Células de Langerhans	(presentación de antígenos)
Células de Merkel	(mecanorreceptores)

DERMIS (2 capas)

Capa papilar	Tejido conectivo laxo. Papilas dérmicas. Capilares, terminaciones nerviosas. Corpúsculos de Meissner (tacto fino).
Capa reticular	Tejido conectivo denso irregular. Fibras de colágeno y elastina. Folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas. Corpúsculos de Pacini (presión profunda).

Componentes de la dermis

Fibras de colágeno	Resistencia
Fibras de elastina	Elasticidad
Sustancia fundamental	Hidratación y soporte
Vasos sanguíneos	Nutrición
Nervios	Sensibilidad
Anexos cutáneos	Folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas, músculo piloerector

HIPODERMIS (tejido subcutáneo)

Tejido adiposo	Lóbulos de adipocitos. Reserva energética, aislamiento térmico.
Tejido conectivo laxo	Une la piel a planos profundos.
Vasos de mayor calibre	Arterias y venas.
Nervios	Ramas nerviosas.
Funciones	Amortiguación, reserva de energía, termorregulación, unión a estructuras profundas.

Funciones generales de la piel

	Barrera de protección (física, química, inmunológica)
	Termorregulación
	Homeostasis de líquidos y electrolitos
	Función sensitiva
	Síntesis de vitamina D
	Función inmunológica
	Función estética y social

"Conocer la estructura de la piel es la base para entender sus enfermedades."

2. MORFOLOGÍA DE LA SUPERFICIE CUTÁNEA

La superficie de la piel no es completamente lisa. Presenta pequeños relieves y depresiones cuya disposición varía de una zona del cuerpo a otra.

Entre las estructuras superficiales más características se encuentran:

- pliegues cutáneos;
- pliegues articulares;
- dermatoglifos;
- orificios de glándulas cutáneas;
- aberturas relacionadas con los folículos pilosos.

Estas estructuras forman parte de la anatomía normal y participan en diferentes funciones.

2.1. Pliegues cutáneos

La piel necesita adaptarse continuamente al movimiento corporal.

En zonas sometidas a flexión y extensión existen pliegues especialmente notorios, como ocurre alrededor de las articulaciones.

Estos pliegues permiten que la cubierta cutánea pueda acompañar los movimientos corporales sin comportarse como una superficie completamente rígida.

Además de los grandes pliegues articulares existen innumerables pliegues microscópicos y pequeños surcos distribuidos sobre la superficie.

3. DERMATOGLIFOS

Los **dermatoglifos** corresponden a los pequeños relieves y surcos presentes principalmente en los pulpejos o yemas de los dedos.

Su disposición origina las conocidas **huellas dactilares**.

Una característica especialmente importante es que estos patrones son individuales, razón por la cual pueden utilizarse para identificar a una persona.

Por tanto:

dermatoglifo → patrón superficial → huella dactilar → identificación individual.

Desde el punto de vista dermatológico, constituyen un ejemplo sencillo de cómo la superficie cutánea posee una arquitectura propia y organizada.

BADBEAR.MED FIJA:

Dermatoglifos = relieves de los pulpejos que forman las huellas dactilares.

4. ORIFICIOS DE LA SUPERFICIE CUTÁNEA

La piel también presenta múltiples orificios que comunican determinadas estructuras profundas con el exterior.

Entre ellos se encuentran los relacionados con:

- glándulas sebáceas;
- glándulas sudoríparas ecrinas;
- glándulas sudoríparas apocrinas.

Las glándulas sudoríparas ecrinas poseen conductos que llegan a la superficie cutánea.

Las glándulas apocrinas, en cambio, se localizan especialmente en grandes pliegues y habitualmente desembocan en el folículo piloso, aunque algunas pueden presentar una abertura directa hacia la superficie.

Estos orificios son importantes porque **funcionan como** puntos de comunicación entre el interior de la piel y el ambiente.

5. LA PIEL COMO BARRERA DE ENTRADA

La piel constituye una barrera protectora, pero esta barrera no es absolutamente impermeable.

Una sustancia aplicada sobre la superficie puede penetrar parcialmente utilizando diferentes rutas.

La clase menciona tres posibilidades fundamentales:

1. Paso entre células superficiales

El principio activo puede desplazarse **entre los corneocitos**.

2. Paso a través de las células

Algunas sustancias pueden atravesar directamente el corneocito.

3. Paso mediante los orificios cutáneos

Los conductos correspondientes a determinadas glándulas y anexos pueden actuar como vías complementarias de penetración.

Esto tiene gran importancia clínica porque constituye una de las bases de la administración de **medicamentos tópicos**.

Más adelante estudiaremos con profundidad la permeabilidad cutánea, los vehículos grasos, la humedad, la oclusión y los factores que aumentan la absorción.

Por ahora debemos retener el concepto fundamental:

La piel protege al organismo, pero determinadas sustancias pueden atravesar su barrera.

6. MATERIAL LIPÍDICO ENTRE LOS CORNEOCITOS

Entre las células más superficiales de la epidermis existe material de naturaleza lipídica.

Este componente participa en la organización de la barrera cutánea.

La presencia de lípidos entre los corneocitos es importante porque modifica la capacidad de distintas sustancias para atravesar la superficie de la piel.

Puede imaginarse de manera sencilla:

CORNEOCITO — LÍPIDOS — CORNEOCITO — LÍPIDOS — CORNEOCITO

Esta organización será especialmente importante cuando estudiemos posteriormente el estrato córneo y el manto hidrolipídico.

7. LA PIEL COMO VÍA DE SALIDA

La superficie cutánea no solamente permite una entrada limitada de algunas sustancias.

También permite la salida de determinados productos desde el organismo hacia el exterior.

Entre ellos pueden encontrarse algunas sustancias presentes en el sudor, incluidos determinados fármacos, tóxicos y otros productos.

Esta función se relaciona principalmente con las **glándulas sudoríparas ecrinas**, que presentan una amplia distribución corporal.

Sin embargo, la eliminación cutánea no reemplaza a las principales vías de eliminación del organismo.

La vía renal y la vía hepática mantienen un papel fundamental.

Concepto importante

La piel puede participar en la excreción, pero **no constituye la única ni necesariamente la principal vía de eliminación de sustancias.**

8. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA PIEL

Una vez comprendida la superficie cutánea, debemos estudiar cómo se organiza la piel desde el exterior hacia la profundidad.

Las tres regiones principales son:

Epidermis

Capa superficial.

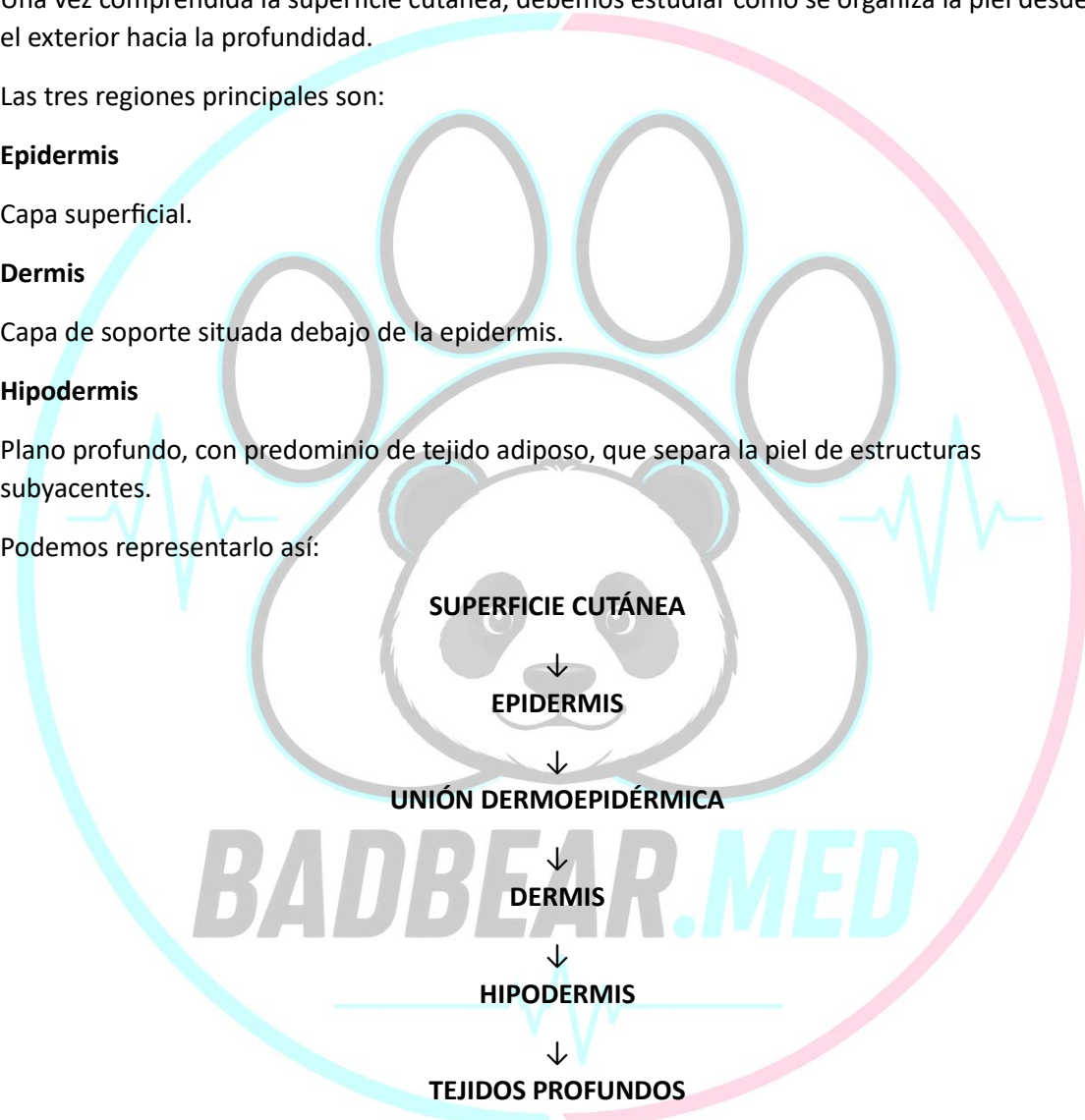
Dermis

Capa de soporte situada debajo de la epidermis.

Hipodermis

Plano profundo, con predominio de tejido adiposo, que separa la piel de estructuras subyacentes.

Podemos representarlo así:



En este primer tema nos concentraremos principalmente en la **epidermis**.

9. EPIDERMIS

La epidermis constituye la capa más externa de la piel.

Histológicamente se describe como un:

epitelio plano estratificado queratinizado o cornificado.

Para comprender esta definición debemos separar cada término.

9.1. Epitelio

La epidermis pertenece al grupo de los tejidos epiteliales.

Su función está estrechamente relacionada con la cobertura y protección de la superficie corporal.

9.2. Estratificado

Significa que no está constituida por una sola capa celular.

Los queratinocitos se organizan en varias capas superpuestas.

Las células más profundas son diferentes de las células que finalmente llegan a la superficie.

9.3. Plano

La denominación hace referencia particularmente al aspecto aplanado que adquieren las células conforme avanzan hacia la superficie.

Durante su ascenso, el queratinocito experimenta una transformación progresiva.

9.4. Queratinizado o cornificado

La epidermis produce grandes cantidades de **queratina**.

A medida que los queratinocitos ascienden, acumulan esta proteína y progresivamente pierden sus estructuras celulares hasta transformarse en células superficiales altamente queratinizadas.

Este fenómeno constituye la base de la **queratinización**.

10. GROSOR DE LA EPIDERMIS

El espesor de la epidermis no es igual en todo el organismo.

Existen regiones donde es particularmente delgada y otras donde es considerablemente más gruesa.

La clase menciona como ejemplos de piel fina:

- párpados;
- genitales masculinos;
- genitales femeninos.

Por otro lado, la región plantar posee una epidermis considerablemente más gruesa.

Esta variación tiene sentido funcional.

Las zonas sometidas a mayor presión y fricción necesitan una superficie resistente.

Comparación sencilla

Párpado → epidermis fina

Planta del pie → epidermis gruesa

Esta diferencia también será importante cuando estudiemos la penetración de medicamentos tópicos, porque una sustancia no atraviesa con la misma facilidad todas las regiones corporales.

11. LA EPIDERMIS ES AVASCULAR

Una característica fundamental de la epidermis es que **no posee vasos sanguíneos propios**.

Por esta razón se considera un tejido avascular.

Sin embargo, sus células siguen necesitando:

- oxígeno;
- nutrientes;
- sustancias necesarias para su metabolismo.

Entonces surge una pregunta importante:

¿Cómo se nutre la epidermis?

Los nutrientes llegan mediante **difusión desde la dermis** situada inmediatamente debajo.

Esto establece una relación funcional muy estrecha entre ambas capas.

La dermis contiene vasos sanguíneos.

La epidermis no.

Por tanto:

VASOS DÉRMICOS

↓ difusión

UNIÓN DERMOEPIDÉRMICA

↓ difusión

CÉLULAS EPIDÉRMICAS

12. INERVACIÓN DE LA EPIDERMIS

Aunque la epidermis es avascular, esto no significa que esté completamente aislada del sistema nervioso.

La transcripción señala que fibras nerviosas pueden alcanzar la epidermis y que existen terminaciones nerviosas relacionadas con la sensibilidad cutánea.

Sin embargo, una parte importante de la organización sensitiva se encuentra en la dermis.

Este concepto será ampliado posteriormente cuando estudiemos la **inervación cutánea**.

13. QUERATINOCITO: CÉLULA PRINCIPAL DE LA EPIDERMIS

El **queratinocito** constituye la célula predominante de la epidermis.

Aproximadamente el **90 % de las células epidérmicas** corresponde a queratinocitos.

Por ello podemos considerar al queratinocito como la célula estructural fundamental de esta capa.

Su función característica

Una de sus principales funciones es producir **queratina**.

La queratina es descrita como una proteína fibrilar perteneciente a la familia de los **filamentos intermedios**.

Su acumulación proporciona resistencia y rigidez a la superficie cutánea.

14. LA EPIDERMIS ES UN TEJIDO EN RENOVACIÓN CONTINUA

La epidermis no permanece estática.

Los queratinocitos se forman en las capas profundas, ascienden progresivamente y finalmente llegan a la superficie.

Posteriormente son eliminados mediante descamación.

La transcripción establece un tiempo aproximado de renovación epidérmica de **30 días**.

Este período puede modificarse en diferentes enfermedades.

Por eso podemos hablar de la epidermis como un tejido en renovación constante.

Secuencia básica

PROLIFERACIÓN



DIFERENCIACIÓN



ASCENSO



QUERATINIZACIÓN



CORNEOCITO



DESCAMACIÓN

Posteriormente este proceso será estudiado bajo los conceptos de:

epidermopoyesis y queratogénesis.

15. ESTRATOS DE LA EPIDERMIS

La epidermis no es una estructura uniforme.

Se organiza en diferentes estratos que representan distintas etapas de maduración del queratinocito.

Desde la profundidad hacia la superficie:

1. **estrato basal;**
2. **estrato espinoso;**
3. **estrato granuloso;**
4. **estrato lúcido;**
5. **estrato córneo.**

El estrato lúcido solamente se identifica claramente en determinadas regiones de piel gruesa.

16. ESTRATO BASAL

El **estrato basal** también recibe los nombres de:

- estrato germinativo;
- estrato proliferativo.

Representa la capa más profunda de la epidermis.

Está constituido fundamentalmente por **una hilera de células.**

Estas células pueden presentar una morfología:

- poligonal;
- cúbica;
- ligeramente cilíndrica.

Su característica fundamental es su capacidad proliferativa.

16.1. Función proliferativa

En este estrato se encuentran las células responsables de mantener la renovación epidérmica.

Cuando una célula se divide, las nuevas células pueden seguir destinos diferentes.

Una permanece relacionada con la capa basal mientras otra inicia su desplazamiento hacia capas superiores.

De esta manera, la epidermis mantiene continuamente su población celular.



17. DESMOSOMAS

Las células basales no se encuentran simplemente apoyadas unas junto a otras.

Están firmemente conectadas mediante diferentes sistemas de unión.

Entre ellos destacan los **desmosomas**.

Los desmosomas permiten mantener la cohesión entre las células epidérmicas.

En otras palabras:

desmosoma = unión célula-célula.

Este concepto será especialmente importante en Dermatología porque la estabilidad de la epidermis depende de una adecuada adhesión entre queratinocitos.

18. HEMIDESMOSOMAS

Las células del estrato basal también deben mantenerse unidas a la región situada por debajo de ellas.

Esta relación ocurre mediante los **hemidesmosomas**.

Los hemidesmosomas participan en la fijación de las células basales a la membrana basal y, por extensión, en la unión dermoepidérmica.

Una forma sencilla de diferenciarlos es:

Estructura	Función
Desmosoma	Une queratinocito con queratinocito

Hemidesmosoma Une queratinocito basal con membrana basal

BADBEAR.MED FIJA:

Desmosoma = célula con célula.

Hemidesmosoma = célula basal con membrana basal.

19. ESTRATO ESPINOSO O DE MALPIGHI

Por encima del estrato basal se encuentra el **estrato espinoso**, también denominado **estrato de Malpighi**.

Está constituido aproximadamente por **5 a 10 capas de queratinocitos poligonales**.

En esta zona los queratinocitos mantienen numerosas conexiones mediante desmosomas.

Por esta razón, la cohesión celular sigue siendo muy importante.

19.1. Producción de sustancias lipídicas

Durante su tránsito por el estrato espinoso, los queratinocitos comienzan a producir estructuras relacionadas con el material que posteriormente será liberado entre las células superficiales.

La transcripción las denomina **cuerpos o corpúsculos de Odland**.

Estas estructuras se relacionan con el material lipídico que posteriormente se encuentra entre los corneocitos.

Este punto permite relacionar dos conceptos que inicialmente parecían separados:



20. ESTRATO GRANULOSO

El siguiente nivel es el **estrato granuloso**.

Está constituido aproximadamente por **2 a 5 capas de células progresivamente aplanadas**.

Su nombre se relaciona con la presencia de gránulos visibles en el citoplasma.

Durante esta etapa ocurre una transformación profunda del queratinocito.

20.1. Aumento de queratina

Las células comienzan a acumular abundante queratina en el citoplasma.

A medida que esto ocurre, los componentes celulares habituales empiezan a desaparecer.

La transcripción menciona particularmente:

- retículo endoplasmático;
- mitocondrias;
- posteriormente el núcleo.

Esto muestra que el queratinocito está acercándose progresivamente a su forma final: el **corneocito**.

21. ESTRATO LÚCIDO

El **estrato lúcido** constituye una capa particular.

No se observa claramente en toda la superficie corporal.

Se encuentra fundamentalmente en regiones de **piel gruesa**, especialmente:

palmas y plantas.

Por ello, cuando comparemos piel fina y piel gruesa, este estrato constituye una diferencia importante.

Piel gruesa

Basal



Espinoso



Granuloso



Lúcido



Córneo

Piel fina

Basal



Espinoso



Granuloso



Córneo

22. ESTRATO CÓRNEO

El **estrato córneo** representa la región más superficial de la epidermis.

En esta etapa las células han experimentado una transformación muy avanzada.

Los corneocitos:

- carecen de núcleo;
- han perdido prácticamente sus organelos;
- contienen abundante queratina.

El estrato córneo puede reconocerse funcionalmente en una región más profunda y compacta y otra más superficial relacionada con la descamación.

22.1. Estrato córneo compacto

Corresponde a una región más profunda donde los corneocitos permanecen estrechamente organizados.

Contribuye significativamente a la función de barrera.

22.2. Estrato córneo descamativo

Conforme los corneocitos alcanzan la superficie, progresivamente se desprenden.

Este proceso permite que la piel elimine continuamente células superficiales mientras otras procedentes de zonas profundas las reemplazan.

El ciclo completo





ESTRATO CÓRNEO

corneocitos



DESCAMACIÓN

23. PIEL GRUESA: EJEMPLO DE LA REGIÓN PLANTAR

La región plantar constituye un buen modelo para visualizar los diferentes estratos epidérmicos.

En ella pueden distinguirse con claridad:

- estrato basal;
- estrato espinoso;
- estrato granuloso;
- estrato lúcido;
- estrato córneo.

La presencia del estrato lúcido y el desarrollo marcado del estrato córneo son características relevantes de la piel gruesa.

24. RESUMEN COMPARATIVO DE LOS ESTRATOS

Estrato	Característica principal
Basal	Proliferación celular
Espinoso	Queratinocitos unidos por numerosos desmosomas
Granuloso	Aplanamiento, gránulos y pérdida progresiva de organelos
Lúcido	Presente principalmente en palmas y plantas
Córneo	Corneocitos sin núcleo, ricos en queratina

25. COLOR DE LA PIEL

El color cutáneo no depende de un único elemento.

La clase menciona principalmente:

- melanina;
- vasos sanguíneos;

- acumulación de pigmentos carotenoides.

Sin embargo, el elemento pigmentario fundamental es la **melanina**.

La melanina es producida por unas células especializadas denominadas **melanocitos**.

26. MELANOCITOS

Los melanocitos se localizan principalmente en el **estrato basal de la epidermis**.

Presentan una forma estrellada y poseen **múltiples** prolongaciones.

Estas prolongaciones ascienden entre los queratinocitos y permiten distribuir pigmento hacia células vecinas.

La imagen mental es importante:

MELANOCITO

cuerpo celular en estrato basal

↗ ↑ ↖
prolongaciones

↗ ↑ ↖
queratinocitos vecinos

27. FUNCIÓN DE LA MELANINA

La melanina participa en la coloración cutánea, pero su función no es solamente estética.

También interviene en la protección frente a la **radiación ultravioleta**.

La melanina ayuda a reducir el daño producido por la exposición solar sobre estructuras profundas de la epidermis y la dermis.

Posteriormente estudiaremos este proceso de manera mucho más profunda bajo el nombre de **melanogénesis**.

28. TRANSFERENCIA DE MELANINA

El melanocito produce pigmento y **posteriormente lo distribuye** mediante sus prolongaciones hacia diferentes queratinocitos.

Por tanto, existe una relación funcional estrecha entre:

melanocito → melanina → queratinocito.

Esta interacción contribuye tanto a la pigmentación como a la protección frente a radiación ultravioleta.

29. CÉLULAS DE LANGERHANS

Otra población celular presente en la epidermis son las **células de Langerhans**.

Se localizan especialmente en regiones altas del estrato espinoso.

Presentan una configuración estrellada y, a diferencia de los queratinocitos, no mantienen el mismo tipo de unión mediante desmosomas.

Su función se relaciona principalmente con la **respuesta inmunológica cutánea**.

29.1. Función inmunológica

La piel constituye una primera zona de contacto con:

- sustancias externas;
- microorganismos;
- productos químicos;
- potenciales alérgenos.

Las células de Langerhans forman parte de la respuesta inmunológica que se desarrolla en este nivel.

La clase destaca específicamente su participación en la **dermatitis alérgica de contacto**.

Esto permite comprender que la epidermis no es una barrera puramente física.

También constituye una estructura inmunológicamente activa.

BADBEAR.MED FIJA:

Langerhans = inmunidad epidérmica.

30. CÉLULAS DE MERKEL

Las **células de Merkel** constituyen otra población celular minoritaria.

Se localizan en las regiones basales de la epidermis y se encuentran estrechamente relacionadas con el sistema nervioso.

Su importancia radica en su relación con la **recepción del tacto**.

Por tanto:

Merkel = sensibilidad táctil.

31. LAS CUATRO POBLACIONES CELULARES FUNDAMENTALES DE LA EPIDERMIS

Podemos organizar lo estudiado de la siguiente manera:

Célula	Localización predominante	Función destacada
Queratinocito	Toda la epidermis	Producción de queratina y formación de barrera
Melanocito	Estrato basal	Producción y distribución de melanina
Langerhans	Principalmente estrato espinoso	Función inmunológica
Merkel	Región basal	Recepción sensitiva relacionada con tacto

El queratinocito representa la población mayoritaria.

Las demás células son menos numerosas pero cumplen funciones especializadas fundamentales.

32. INTEGRACIÓN FUNCIONAL DE LA EPIDERMIS

Después de estudiar cada estructura por separado, podemos comprender la epidermis como un sistema integrado.

Queratinocitos

Construyen la mayor parte de la estructura epidérmica.

Estrato basal

Mantiene la capacidad proliferativa.

Estrato espinoso

Favorece la cohesión mediante numerosos desmosomas.

Estrato granuloso

Marca una fase avanzada de queratinización.

Estrato lúcido

Caracteriza principalmente a la piel gruesa.

Estrato córneo

Constituye la barrera superficial.

Melanocitos

Producen melanina y participan en la protección frente a radiación ultravioleta.

Langerhans

Participan en la vigilancia inmunológica.

Merkel

Participan en la percepción táctil.

Así, la epidermis no debe entenderse simplemente como una acumulación de capas.

Es un **tejido dinámico, en renovación permanente, pigmentado, inmunológicamente activo y sensorialmente relacionado con el sistema nervioso.**

33. ESQUEMA MAESTRO DE LA EPIDERMIS

SUPERFICIE

Estrato córneo

Corneocitos
Sin núcleo
Abundante queratina
Barrera



Estrato lúcido

Solo claramente presente en piel gruesa
Palmas y plantas



Estrato granuloso

Células aplanadas
Gránulos
Aumento de queratina
Pérdida progresiva de organelos



Estrato espinoso

5–10 capas
Queratinocitos poligonales
Numerosos desmosomas
Cuerpos de Odland



Estrato basal

Una hilera celular
Actividad proliferativa
Melanocitos
Células de Merkel
Unión mediante hemidesmosomas



Membrana basal





DERMIS

34. RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

La organización de la epidermis permite explicar varias de sus propiedades.

Resistencia

Depende de la queratina y de las uniones entre queratinocitos.

Renovación

Depende de la proliferación de las células de la capa basal.

Barrera

Depende principalmente de la organización del estrato córneo y del material lipídico intercelular.

Pigmentación

Depende de la melanina producida por los melanocitos.

Protección frente a radiación UV

Se relaciona con la melanina.

Inmunidad

Participan las células de Langerhans.

Sensibilidad

Participan terminaciones nerviosas y células de Merkel.

35. CORRELACIÓN CON LA DERMATOLOGÍA CLÍNICA

Comprender esta organización facilitará posteriormente el estudio de las enfermedades cutáneas.

Cuando una enfermedad altera la proliferación epidérmica, pueden modificarse el grosor y la descamación.

Cuando existe alteración de la pigmentación, debemos pensar en procesos relacionados con melanina y melanocitos.

Cuando se altera la cohesión entre las células, la integridad de la epidermis puede verse comprometida.

Cuando existe una respuesta frente a una sustancia externa, las células inmunológicas epidérmicas pueden participar.

Por eso la anatomía microscópica no debe memorizarse como una lista aislada: constituye la base para interpretar posteriormente las lesiones dermatológicas.

BADBEAR.MED FIJA — TEMA 1

Estructura

Piel = epidermis + dermis + hipodermis.

Epidermis

Epitelio plano estratificado queratinizado.

Es avascular.

Se nutre por difusión desde la dermis.

Queratinocito

Representa aproximadamente el 90 % de las células epidérmicas.

Produce queratina.

Renovación

La epidermis se encuentra en renovación continua.

La clase establece aproximadamente 30 días para el recambio epidérmico normal.

Estratos

Basal → Espinoso → Granuloso → Lúcido → Córneo.

El estrato lúcido aparece principalmente en palmas y plantas.

Uniones

Desmosomas → unión entre queratinocitos.

Hemidesmosomas → unión de las células basales con la membrana basal.

Estrato basal

Es germinativo y proliferativo.

Estrato espinoso

Posee numerosos desmosomas.

Estrato granuloso

Aumenta la queratina y comienzan a desaparecer organelos y núcleo.

Estrato córneo

Corneocitos sin núcleo y ricos en queratina.

Melanocito

Se localiza en el estrato basal.

Produce y distribuye melanina.

La melanina participa en la protección frente a radiación ultravioleta.

Langerhans

Función inmunológica.

Participan en dermatitis alérgica de contacto.

Merkel

Localización basal.

Relacionadas con recepción del tacto.

Superficie cutánea

Dermatoglifos → huellas dactilares.

Existen orificios de glándulas sebáceas, ecrinas y algunas apocrinas.

Penetración tópica

Puede ocurrir:

**entre corneocitos,
a través de corneocitos,
por estructuras anexas.**

REPASO FINAL EN UNA SOLA IMAGEN MENTAL

Piensa en la epidermis como una **escalera de maduración celular**.

Abajo nace el queratinocito.

BASAL

nace y prolifera.

↓

ESPINOSO

se mantiene fuertemente unido.

↓

GRANULOSO

acumula queratina y comienza a perder su maquinaria celular.

↓

LÚCIDO

aparece en piel gruesa.

↓

CÓRNEO

ya es un corneocito queratinizado que forma la barrera superficial.

↓

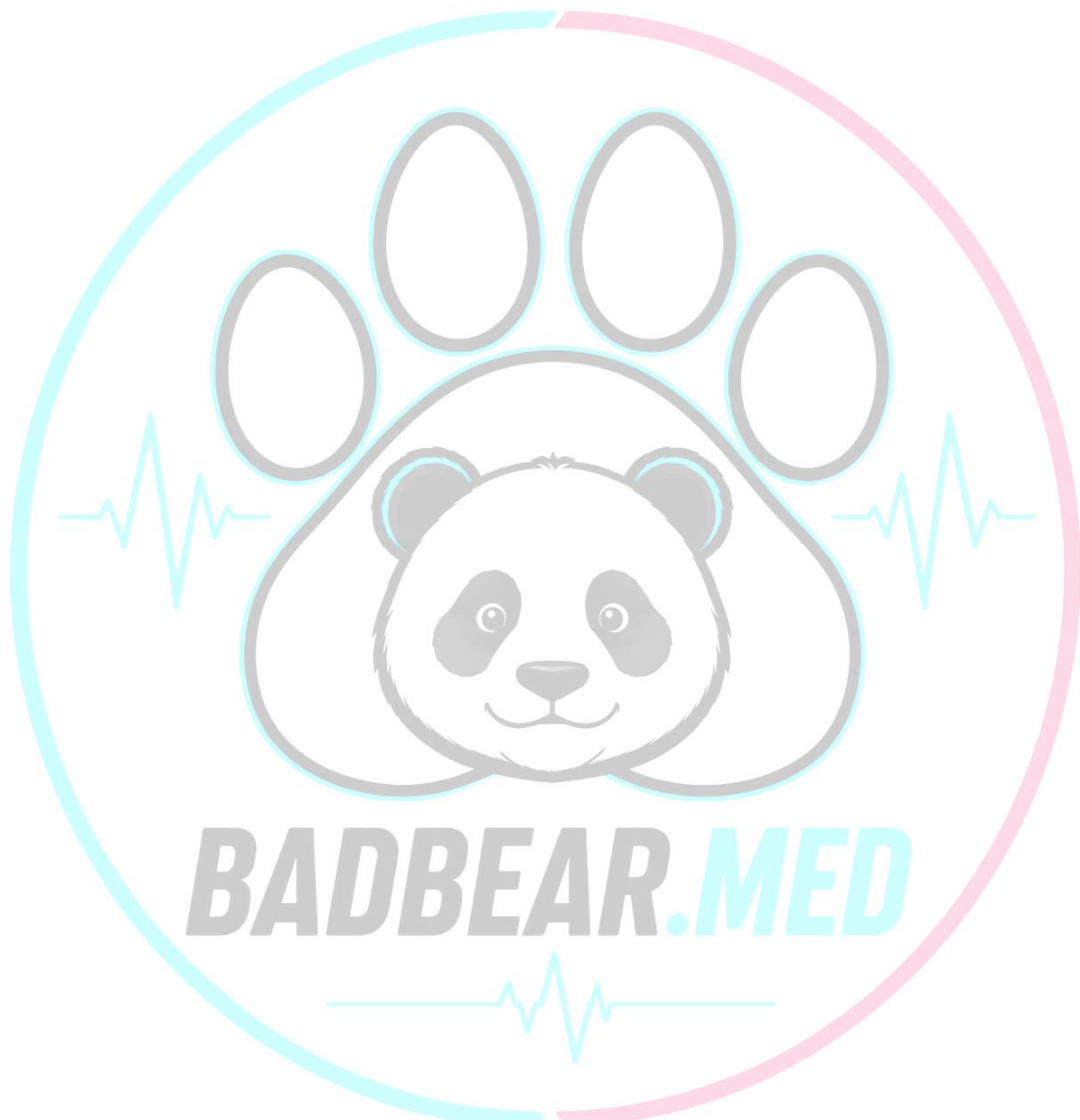
BADBEAR.MED

finalmente se desprende.

Mientras ocurre este proceso:

**el melanocito aporta pigmento,
Langerhans vigila inmunológicamente,
Merkel participa en el tacto,
y los queratinocitos construyen la mayor parte de la epidermis.**

Ese es el concepto central que debe quedar claro antes de avanzar hacia la dermis.



Salida

- sudor
- sebo
- determinadas sustancias

Resultado funcional

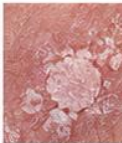
- comunicación controlada entre el organismo y el exterior.

Semiología de las lesiones dermatológicas

Lesiones primarias (cambios iniciales en la piel)

Mácula	Mancha	Pápula	Placa	Nódulo	Habón	Vesícula	Ampolla	Pústula	Quiste
									
Cambio de color sin relieve (no palpable) < 1 cm	Cambio de color sin relieve > 1 cm	Lesión sólida, elevada < 1 cm	Lesión elevada, plana, > 1 cm (generalmente por confluencia de pápulas)	Lesión sólida, más profunda > 1 cm (dermis/subcutis)	Elevación edematosa, transitoria (p. ej. urticaria)	Contenido líquido seroso ≤ 1 cm	Contenido líquido seroso > 1 cm	Contenido purulento	Cavidad con contenido líquido o semisólido

Lesiones secundarias (modificaciones de las primarias)

Escama	Costra	Erosión	Excoriación	Fisura	Úlcera	Atrofia	Cicatriz	Liquenificación
								
Láminas de queratina en la superficie	Exudado seco (seroso, hemático o purulento)	Pérdida superficial de la epidermis (no deja cicatriz)	Lesión lineal por rascado	Hendidura lineal profunda	Pérdida de sustancia que compromete dermis o más (deja cicatriz)	Adelgazamiento de la piel	Reparación fibrosa	Engrosamiento de la piel con acentuación de pliegues (por rascado crónico)

Características a describir

Tipo de lesión	Primaria o secundaria (mácula, pápula, etc.)
Número	Única, múltiples, numerosas
Tamaño	En mm o cm (o estimado: pequeña, mediana, extensa)
Forma	Redondeada, ovalada, anular, lineal, irregular, etc.
Color	Eritematosa, violácea, hiperpigmentada, hipopigmentada, acrómica, parduzca, etc.
Bordes y límites	Bien o mal delimitados, regulares o irregulares, netos o difusos
Superficie	Lisa, rugosa, descamativa, costrosa, ulcerada, etc.
Contenido	Seroso, hemorrágico, purulento (si corresponde)
Configuración	Aisladas, confluentes, agrupadas, anulares, en diana, etc.
Distribución	Localizada o generalizada, simétrica o asimétrica, por regiones (facial, troncal, acral, flexora/extensora, etc.)

Colores más frecuentes

-  Eritematosa (roja)
-  Violácea
-  Parduzca
-  Hiperpigmentada (marrón)
-  Hipopigmentada (más clara)
-  Acrómica (blanca)
-  Amarillenta
-  Negruzca

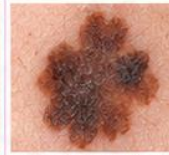
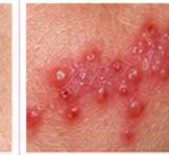
Formas comunes

-  Redondeada
-  Ovalada
-  Anular
-  Arciforme
-  Policíclica
-  Lineal
-  Serpiginosa
-  Irregular

Configuración

-  Aisladas
-  Múltiples
-  Confluentes
-  Agrupadas
-  Herpetiformes
-  En diana
-  Reticulares
-  Zosteriformes

Ejemplos con diagnóstico presuntivo

Psoriasis en placas	Tiña corporis	Acné	Herpes simple	Impétigo	Urticaria	Melanoma	Herpes zóster
							
Placas eritematosas, bien delimitadas, con escamas blanquecinas. Distribución simétrica en extensores. Dx: Psoriasis en placas.	Placa eritematosa anular con borde descamativo y aclaramiento central. Dx: Tiña corporis.	Múltiples pápulas y pústulas eritematosas en cara. Dx: Acné vulgar.	Vesículas agrupadas sobre base eritematosa. Dx: Herpes simple.	Placas con costras melicéricas. Dx: Impétigo.	Habones eritematosos, edematosos, transitorios. Dx: Urticaria.	Mácula hiperpigmentada, asimétrica, de bordes irregulares y coloración heterogénea. Dx: Lesión melanocítica sospechosa (melanoma).	Vesículas agrupadas en distribución dermatomérica. Dx: Herpes zóster.

Clase 2:

Enlace del video original: [Clase 2 Micosis Superficial](#)

Material audiovisual en el canal de [badbear.med](#)

DERMATOFITOSIS (TIÑAS)

Micosis superficiales de piel, cabello y uñas



BADBEAR.MED FIJA: Los dermatofitos invaden tejidos queratinizados: piel, pelo y uñas.

TEMA 1. ANATOMÍA GENERAL DE LA PIEL Y EPIDERMIS

1. Introducción general a la piel

La piel constituye la cubierta externa del organismo y representa la primera estructura que establece contacto directo con el medio ambiente. No se trata simplemente de una capa protectora pasiva, sino de un órgano dinámico que participa continuamente en la protección, sensibilidad, regulación térmica, homeostasis, defensa inmunológica, pigmentación y relación del organismo con su entorno.

Desde el punto de vista anatómico, la piel puede comprenderse como una estructura organizada en diferentes niveles. Cada uno de estos niveles posee características celulares y funcionales propias, pero todos trabajan de manera integrada.

Las tres grandes regiones son:

epidermis, dermis e hipodermis.

La epidermis constituye la capa más superficial y está formada fundamentalmente por queratinocitos.

La dermis se localiza inmediatamente por debajo, tiene naturaleza conjuntiva y proporciona soporte mecánico, vascular y nutricional.

La hipodermis representa la región más profunda y posee abundante tejido adiposo.

Para entender las enfermedades dermatológicas no basta con memorizar estos nombres. Es necesario comprender qué ocurre normalmente en cada nivel. Solo así será posible interpretar después por qué una enfermedad produce descamación, ampollas, alteraciones de pigmentación, nódulos, alopecia o alteraciones de las uñas.

2. LA SUPERFICIE CUTÁNEA

A simple vista la piel puede parecer lisa, pero cuando se observa con detalle presenta numerosos accidentes anatómicos.

En ella encontramos:

- pliegues;
- surcos;
- relieves;
- orificios;
- aperturas relacionadas con glándulas;
- aperturas relacionadas con folículos pilosos.

Estas estructuras no aparecen de manera casual. Forman parte de la arquitectura normal de la piel.

2.1. Pliegues cutáneos

La piel debe acompañar continuamente los movimientos del cuerpo.

Por esta razón, en diferentes regiones existen pliegues que permiten que la superficie cutánea se adapte a movimientos de flexión, extensión y desplazamiento.

Son especialmente notorios en las zonas articulares.

Los pliegues también modifican la apariencia de la piel y generan regiones anatómicas particulares donde pueden acumularse humedad, sudor y secreciones.

Por eso, desde el punto de vista dermatológico, una región de pliegue no se comporta exactamente igual que una superficie seca y expuesta.

3. DERMATOGLIFOS

Dentro de los pequeños relieves de la superficie cutánea se encuentran los **dermatoglifos**.

Los dermatoglifos son patrones formados por crestas y surcos presentes principalmente en los pulpejos de los dedos.

La disposición particular de estas estructuras da origen a las **huellas dactilares**.

La característica fundamental de las huellas dactilares es que son propias de cada individuo, razón por la cual han sido utilizadas como método de identificación personal.

Por tanto, la secuencia conceptual es:

dermatoglifos → crestas y surcos → huella dactilar → identificación individual.

Este punto aparentemente sencillo permite comprender algo importante: la superficie cutánea presenta una organización anatómica específica y reproducible.

4. ORIFICIOS DE LA SUPERFICIE CUTÁNEA

La piel contiene numerosos orificios microscópicos.

Estos orificios corresponden principalmente a conductos relacionados con los diferentes anexos cutáneos.

Entre ellos se encuentran:

- glándulas sudoríparas ecrinas;
- unidades pilosebáceas;
- glándulas sudoríparas apocrinas.

La clase señala que las glándulas apocrinas, localizadas principalmente en grandes pliegues, suelen desembocar en el folículo piloso, aunque algunas pueden hacerlo directamente sobre la superficie cutánea.

Estos orificios representan puntos de comunicación entre estructuras profundas y el exterior.

5. IMPORTANCIA FUNCIONAL DE LOS ORIFICIOS CUTÁNEOS

Los orificios cutáneos permiten fundamentalmente dos procesos:

Salida de sustancias

A través de ellos pueden alcanzar la superficie:

- sudor;
- sebo;
- determinadas sustancias presentes en las secreciones cutáneas.

Entrada de sustancias

Algunas sustancias aplicadas externamente también pueden aprovechar estas vías para penetrar hacia capas más profundas.

Esto tiene particular importancia en Dermatología porque muchos tratamientos se administran directamente sobre la piel.

6. LA PIEL COMO BARRERA

Una de las funciones fundamentales de la piel es actuar como barrera entre el medio externo y el medio interno.

Sin embargo, esta barrera no es completamente impermeable.

Algunas sustancias pueden atravesarla.

La transcripción señala diferentes posibilidades de penetración:

1. entre las células superficiales;
2. atravesando directamente las células;
3. utilizando los orificios de los anexos cutáneos.

Esta propiedad es fundamental para comprender la administración de medicamentos tópicos.

7. VÍA INTERCELULAR

En la vía intercelular, una sustancia se desplaza **entre los corneocitos**.

Los corneocitos son las células más superficiales de la epidermis.

Entre ellas existe material de naturaleza lipídica.

Podemos representarlo de manera esquemática:

CORNEOCITO

↓ lípidos intercelulares

CORNEOCITO

↓ lípidos intercelulares

CORNEOCITO

Una sustancia que atraviesa la superficie puede desplazarse a través de estos espacios.

Esta organización contribuye al funcionamiento de la barrera epidérmica.

8. VÍA TRANSCELULAR

En esta ruta, el principio activo atraviesa directamente el corneocito.

Es decir, no solamente utiliza los espacios existentes entre las células.

Debe atravesar la propia estructura celular.

La transcripción menciona ambas posibilidades: paso intercelular y paso a través del corneocito.

Por tanto:

vía intercelular = entre células

vía transcelular = atravesando células

9. VÍA ANEXIAL

Existe además una ruta relacionada con los anexos cutáneos.

Los folículos pilosos y conductos glandulares pueden constituir caminos complementarios para el ingreso de determinadas sustancias.

De manera general:

SUPERFICIE CUTÁNEA

- ↓ vía intercelular
- ↓ vía transcelular
- ↓ vía anexial

CAPAS PROFUNDAS

Este concepto será retomado posteriormente cuando se estudien el manto hidrolipídico, los medicamentos tópicos y la absorción percutánea.

10. LA PIEL COMO VÍA DE SALIDA DE SUSTANCIAS

La piel también puede participar en la eliminación de determinadas sustancias.

La transcripción señala que algunos fármacos, tóxicos y productos relacionados con sustancias consumidas pueden eliminarse parcialmente por la secreción sudoral.

La estructura especialmente relacionada con esta función es la **glándula sudorípara ecrina**.

Sin embargo, es importante comprender que la piel no reemplaza a los órganos responsables de la eliminación sistémica.

Las vías renal y hepática continúan desempeñando un papel central.

Concepto esencial

La piel participa en la excreción, pero no constituye la principal vía general de eliminación del organismo.

11. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA PIEL

Desde la superficie hacia la profundidad podemos representar la piel de la siguiente manera:

SUPERFICIE

↓

EPIDERMIS

↓

UNIÓN DERMOEPIDÉRMICA

↓

DERMIS



HIPODERMIS



TEJIDOS PROFUNDOS

Cada una de estas regiones posee una organización completamente diferente.

En este tema nos centraremos en la **epidermis**.

12. EPIDERMIS: DEFINICIÓN

La epidermis es la capa más superficial de la piel.

Histológicamente corresponde a un:

epitelio plano estratificado queratinizado o cornificado.

Esta definición debe comprenderse palabra por palabra.

13. ¿POR QUÉ SE DENOMINA EPITELIO?

La epidermis es un tejido epitelial porque forma una cubierta continua.

Sus células se encuentran estrechamente relacionadas unas con otras y forman una superficie organizada.

No posee la abundante matriz extracelular característica del tejido conjuntivo dérmico.

14. ¿POR QUÉ SE DENOMINA ESTRATIFICADO?

Porque la epidermis no está constituida por una sola capa de células.

Presenta múltiples capas superpuestas.

Los queratinocitos más profundos son diferentes de los superficiales.

Estas diferencias no representan tipos celulares completamente independientes, sino diferentes etapas de maduración del mismo queratinocito.

15. ¿POR QUÉ SE DENOMINA PLANO?

La denominación se relaciona fundamentalmente con el aspecto aplanado de las células superficiales.

El queratinocito cambia progresivamente de forma durante su desplazamiento hacia la superficie.

En regiones profundas puede ser cúbico o poligonal.

En regiones superficiales se vuelve progresivamente más aplanado.

16. ¿POR QUÉ SE DENOMINA QUERATINIZADO?

Porque los queratinocitos producen y acumulan **queratina**.

La queratina es una proteína fibrilar relacionada con los filamentos intermedios.

Su presencia proporciona resistencia mecánica a la epidermis.

El proceso mediante el cual un queratinocito va acumulando queratina y transformándose progresivamente recibe el nombre de **queratinización**.

17. EL GROSOR DE LA EPIDERMIS NO ES UNIFORME

La epidermis cambia de espesor dependiendo de la región del cuerpo.

La clase menciona como ejemplos de piel delgada:

- párpados;
- genitales masculinos;
- genitales femeninos.

Mientras que la región plantar presenta un espesor significativamente mayor.

Esto tiene una explicación funcional.

Las zonas sometidas a presión y fricción constantes necesitan una barrera más gruesa.

18. PIEL FINA Y PIEL GRUESA

Podemos diferenciar dos modelos generales.

Piel fina

Presenta una epidermis relativamente delgada.

Ejemplos:

- párpados;
- algunas regiones genitales.

Piel gruesa

Presenta una epidermis muy desarrollada.

Ejemplos:

- palmas;
- plantas.

En estas regiones también aparece de manera característica el **estrato lúcido**, que veremos más adelante.

19. EPIDERMIS AVASCULAR

Una de las características más importantes de la epidermis es que **no contiene vasos sanguíneos**.

Por eso se denomina avascular.

Pero sus células necesitan nutrientes y oxígeno.

Entonces:

¿Cómo se alimentan las células epidérmicas?

Mediante difusión desde la dermis.

La dermis contiene vasos.

El oxígeno y los nutrientes difunden desde esos vasos hacia la epidermis.

20. RELACIÓN ENTRE EPIDERMIS Y DERMIS

La epidermis depende metabólicamente de la dermis.

Esta relación puede representarse así:

CAPILARES DE LA DERMIS



oxígeno + nutrientes



DIFUSIÓN



EPIDERMIS

Esta relación explica por qué alteraciones profundas de la dermis pueden afectar indirectamente la viabilidad de la epidermis.

21. INERVACIÓN DE LA EPIDERMIS

La ausencia de vasos sanguíneos no significa ausencia de estructuras nerviosas.

La transcripción menciona que fibras nerviosas pueden alcanzar la epidermis.

La piel, por tanto, constituye una estructura sensorial activa.

Más adelante estudiaremos receptores y terminaciones nerviosas específicos.

22. EL QUERATINOCITO

El **queratinocito** es la célula predominante de la epidermis.

Constituye aproximadamente el **90 % de sus células**.

Esto significa que cuando hablamos de la arquitectura epidérmica, en realidad estamos hablando principalmente del ciclo de vida del queratinocito.

23. FUNCIÓN DEL QUERATINOCITO

Su función característica es producir **queratina**.

La queratina:

- es una proteína fibrilar;
- forma parte de los filamentos intermedios;
- proporciona resistencia;
- contribuye a la rigidez de la superficie cutánea.

Pero el queratinocito cumple un proceso más complejo que simplemente producir queratina.

Debe:

1. proliferar;
 2. diferenciarse;
 3. ascender;
 4. modificar su forma;
 5. acumular queratina;
 6. perder progresivamente sus organelos;
 7. transformarse en corneocito;
 8. desprenderse.
-

24. RENOVACIÓN CONTINUA DE LA EPIDERMIS

La epidermis es un tejido en renovación permanente.

Las células superficiales se pierden continuamente.

Si no existiera una fuente constante de nuevas células, la epidermis desaparecería.

Por ello, las células profundas proliferan continuamente.

La clase señala un recambio aproximado de **30 días**.

Este período puede modificarse en diferentes patologías.

25. CONCEPTO DE EPIDERMOPOYESIS

La **epidermopoyesis** corresponde al proceso de formación y renovación de las células epidérmicas.

Empieza fundamentalmente en la región basal.

De manera simplificada:

célula basal

↓

división

↓

queratinocito joven

↓

ascenso

↓

diferenciación

↓

corneocito

↓

descamación

26. CONCEPTO DE QUERATINIZACIÓN

La queratinización es el proceso mediante el cual el queratinocito cambia progresivamente durante su ascenso.

Entre los cambios más importantes encontramos:

- aplanamiento progresivo;
- producción de queratina;
- acumulación de queratina;
- pérdida de organelos;
- pérdida del núcleo;
- transformación en corneocito.

Este proceso permite formar la barrera superficial.

27. ESTRATOS DE LA EPIDERMIS

Desde la profundidad hacia la superficie encontramos:

estrato basal



estrato espinoso



estrato granuloso



estrato lúcido



estrato córneo

No todos están presentes con el mismo desarrollo en todas las regiones del cuerpo.

28. ESTRATO BASAL

El estrato basal es la capa más profunda de la epidermis.

También recibe los nombres de:

- estrato germinativo;
- estrato proliferativo.

Está formado fundamentalmente por una sola hilera de células.

29. MORFOLOGÍA DE LAS CÉLULAS BASALES

Las células basales pueden presentar una forma:

- cúbica;
- poligonal;
- ligeramente cilíndrica.

Su característica fundamental no es solamente su forma, sino su capacidad proliferativa.

30. FUNCIÓN PROLIFERATIVA DEL ESTRATO BASAL

Las células de esta capa generan nuevas células.

Una de las células hijas puede permanecer en el estrato basal.

Otra puede iniciar su ascenso.

Así se mantiene el equilibrio entre producción y pérdida celular.

Esquema

CÉLULA BASAL



mitosis



CÉLULAS HIJAS



permanece asciende

31. UNIONES ENTRE LOS QUERATINOCITOS

Las células epidérmicas necesitan mantenerse fuertemente unidas.

De lo contrario, la epidermis perdería cohesión.

Uno de los principales sistemas de unión mencionado en la clase es el **desmosoma**.

32. DESMOSOMAS

Los desmosomas son estructuras que permiten la unión entre queratinocitos vecinos.

Su función es mantener la cohesión celular.

Puede resumirse así:

DESMOSOMA = unión célula-célula.

Cuando los queratinocitos están sometidos a fuerzas mecánicas, estas uniones ayudan a evitar que se separen fácilmente.

33. HEMIDESMOSOMAS

Los queratinocitos basales también deben mantenerse unidos a la membrana basal.

Para ello existen los **hemidesmosomas**.

La diferencia debe quedar perfectamente clara:

Estructura

Une

Desmosoma

Queratinocito con queratinocito

Hemidesmosoma Queratinocito basal con membrana basal

BADBEAR.MED FIJA:

Desmosoma = célula con célula.

Hemidesmosoma = célula basal con membrana basal.

34. ESTRATO ESPINOSO

Por encima del estrato basal se encuentra el **estrato espinoso** o **estrato de Malpighi**.

Está formado aproximadamente por **5 a 10 capas de queratinocitos poligonales**.

35. ¿POR QUÉ SE DENOMINA ESPINOSO?

Las células se encuentran unidas mediante numerosos desmosomas.

Estas conexiones generan el aspecto característico que históricamente dio origen al nombre de estrato espinoso.

La gran cantidad de uniones contribuye a mantener la resistencia mecánica de la epidermis.

36. CUERPOS DE ODLAND

En el estrato espinoso comienzan a aparecer estructuras relacionadas con la producción de material lipídico.

La clase las denomina **cuerpos o corpúsculos de Odland**.

Estos componentes tienen relación con el material que posteriormente se encontrará entre los corneocitos.

Por ello existe una continuidad funcional:

estrato espinoso

↓

producción de componentes

↓

material lipídico intercelular

↓

barrera superficial

37. ESTRATO GRANULOSO

El estrato granuloso se encuentra por encima del estrato espinoso.

Está constituido por aproximadamente **2 a 5 capas de células progresivamente aplanadas**.

38. CAMBIOS DEL QUERATINOCITO EN EL ESTRATO GRANULOSO

En este nivel comienza a ser muy evidente la transformación del queratinocito.

Aumenta la acumulación de queratina.

Paralelamente comienzan a desaparecer componentes celulares.

La transcripción menciona:

- retículo endoplasmático;
- mitocondrias;
- finalmente el núcleo.

Por tanto, el queratinocito está perdiendo progresivamente sus características de célula metabólicamente activa.

39. SIGNIFICADO FUNCIONAL DEL ESTRATO GRANULOSO

Este estrato representa una etapa avanzada de diferenciación.

La célula ya no está dedicada principalmente a proliferar.

Su destino final es convertirse en una estructura altamente queratinizada.

Esto marca el paso hacia los estratos más superficiales.

40. ESTRATO LÚCIDO

El estrato lúcido se observa fundamentalmente en la **piel gruesa**.

La clase destaca especialmente:

- palmas;
- plantas.

En otras regiones puede no distinguirse claramente.

Por eso constituye una característica importante cuando se compara histológicamente piel gruesa y piel fina.

41. PIEL GRUESA Y ESTRATO LÚCIDO

En una región como la planta del pie podemos encontrar:

basal

↓

espinoso



granuloso



lúcido



córneo

Mientras que en piel fina:

basal



espinoso



granuloso



córneo

42. ESTRATO CÓRNEO

El estrato córneo representa la porción más superficial de la epidermis.

Aquí encontramos células altamente transformadas conocidas como **corneocitos**.

Estas células:

- carecen de núcleo;
- presentan pocos o ningún organelo funcional;
- contienen abundante queratina.

43. ¿QUÉ ES UN CORNEOCITO?

Un corneocito representa la etapa final de diferenciación del queratinocito.

Puede comprenderse como una célula que ha sacrificado progresivamente su maquinaria metabólica para transformarse en una unidad estructural resistente.

La secuencia es:

queratinocito basal



queratinocito espinoso



queratinocito granuloso



corneocito

44. ESTRATO CÓRNEO COMPACTO

La parte profunda del estrato córneo está formada por células fuertemente organizadas.

Esta región constituye una barrera mecánica importante.

45. ESTRATO CÓRNEO DESCAMATIVO

En la porción más superficial, los corneocitos comienzan a separarse y desprenderse.

Este fenómeno forma parte del recambio normal.

La descamación normal ocurre continuamente, aunque normalmente no la percibimos de manera evidente.

46. CICLO COMPLETO DEL QUERATINOCITO

Todo lo estudiado puede resumirse como un viaje celular:

1. Nacimiento

El queratinocito se origina en el estrato basal.

2. Ascenso

Se desplaza hacia capas superiores.

3. Cohesión

En el estrato espinoso mantiene numerosas uniones mediante desmosomas.

4. Diferenciación

En el estrato granuloso aumenta la queratina y pierde organelos.

5. Queratinización avanzada

En piel gruesa atraviesa el estrato lúcido.

6. Transformación final

Se convierte en corneocito.

7. Eliminación

Finalmente se desprende mediante descamación.

47. CUADRO COMPARATIVO DE LOS ESTRATOS EPIDÉRMICOS

Estrato	Característica dominante	Estado celular
Basal	Proliferación	Queratinocitos jóvenes
Espinoso	Cohesión	Numerosos desmosomas
Granuloso	Queratinización	Pérdida progresiva de organelos
Lúcido	Piel gruesa	Transición
Córneo	Barrera	Corneocitos

48. COLOR DE LA PIEL

El color cutáneo depende de diferentes componentes.

La transcripción menciona principalmente:

- melanina;
- vascularización;
- pigmentos carotenoides.

Sin embargo, el principal pigmento señalado es la **melanina**.

49. MELANOCITO

El **melanocito** es la célula encargada de producir melanina.

Se encuentra principalmente en el **estrato basal**.

Presenta una forma estrellada o dendrítica.

Sus prolongaciones se extienden entre los queratinocitos.

50. MORFOLOGÍA DENDRÍTICA DEL MELANOCITO

La morfología del melanocito es fundamental para comprender su función.

No produce pigmento únicamente para sí mismo.

Sus prolongaciones permiten distribuirlo hacia células vecinas.

Podemos representarlo de manera sencilla:

MELANOCITO

↗ ↑ ↖

QUERATINOCITOS

51. MELANINA

La melanina constituye el pigmento fundamental de la piel.

Participa en:

- coloración cutánea;
 - respuesta frente a exposición solar;
 - protección parcial frente a radiación ultravioleta.
-

52. FUNCIÓN FOTOPROTECTORA DE LA MELANINA

La radiación ultravioleta puede producir daño sobre estructuras celulares.

La melanina absorbe parte de esta radiación y contribuye a limitar el daño sobre capas profundas.

Esto no significa protección absoluta.

Significa que forma parte de los mecanismos naturales de defensa frente a la exposición solar.

53. TRANSFERENCIA DE MELANINA

La melanina producida por el melanocito es distribuida hacia queratinocitos.

Por ello, pigmentación y queratinocitos están estrechamente relacionados.

Secuencia

melanocito



producción de melanina



prolongaciones dendríticas



queratinocitos



pigmentación y protección

54. CÉLULAS DE LANGERHANS

Las células de Langerhans representan una población especializada relacionada con la inmunidad cutánea.

Se localizan fundamentalmente en regiones altas del estrato espinoso.

Presentan morfología estrellada.

55. RELACIÓN DE LANGERHANS CON LOS DESMOSOMAS

A diferencia de los queratinocitos, estas células no se encuentran unidas a las células vecinas mediante los mismos sistemas de desmosomas.

Esto permite diferenciarlas conceptualmente de la arquitectura típica de los queratinocitos.

56. FUNCIÓN INMUNOLÓGICA DE LANGERHANS

Estas células participan en los mecanismos de defensa cutánea.

La clase destaca particularmente su participación en la **dermatitis alérgica de contacto**.

Este concepto demuestra que la epidermis no solamente es una barrera física.

También forma parte activa del sistema inmunológico.

57. LA EPIDERMIS COMO ÓRGANO INMUNOLÓGICO

La piel está constantemente expuesta a:

- microorganismos;
 - productos químicos;
 - sustancias ambientales;
 - potenciales alérgenos.
-

Por esta razón necesita mecanismos capaces de detectar y responder a esos estímulos.

Las células de Langerhans forman parte de esa vigilancia inmunológica.

58. CÉLULAS DE MERKEL

Las células de Merkel constituyen otra población especializada.

Se localizan en las zonas basales de la epidermis.

Son escasas y se encuentran relacionadas con estructuras nerviosas.

59. FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS DE MERKEL

Su principal relación funcional es con la **sensibilidad táctil**.

Por tanto:

Merkel = tacto.

Esto demuestra nuevamente que la epidermis no constituye únicamente una barrera física.

También participa en la recepción sensorial.

60. CUATRO POBLACIONES CELULARES IMPORTANTES

Célula	Localización	Función
Queratinocito	Toda la epidermis	Queratinización y barrera
Melanocito	Estrato basal	Pigmentación
Langerhans	Principalmente estrato espinoso	Inmunidad
Merkel	Estrato basal	Sensibilidad táctil

61. INTEGRACIÓN FUNCIONAL DE LA EPIDERMIS

La epidermis puede comprenderse como un sistema formado por varias funciones simultáneas.

Renovación

Las células basales generan nuevas células.

Diferenciación

Los queratinocitos cambian progresivamente.

Barrera

El estrato córneo limita la pérdida de agua y la entrada de sustancias.

Resistencia

La queratina y las uniones celulares aportan integridad estructural.

Pigmentación

Los melanocitos producen melanina.

Fotoprotección

La melanina absorbe parte de la radiación ultravioleta.

Inmunidad

Participan las células de Langerhans.

Sensibilidad

Participan estructuras nerviosas y células de Merkel.

62. LA EPIDERMIS COMO SISTEMA DINÁMICO

Por todo lo anterior, la epidermis no debe memorizarse como una simple lista de cinco capas.

Es un tejido que se encuentra en movimiento permanente.

Mientras unas células nacen en profundidad, otras ascienden, se diferencian y finalmente son eliminadas.

Al mismo tiempo:

- se produce pigmento;
 - se mantienen uniones celulares;
 - se detectan estímulos externos;
 - se reciben señales táctiles;
 - se conserva la función de barrera.
-

63. RELACIÓN ENTRE HISTOLOGÍA Y ENFERMEDAD

La utilidad clínica de estudiar la epidermis aparece cuando entendemos que una alteración en cada componente producirá manifestaciones diferentes.

Si se altera la proliferación celular, puede modificarse el grosor epidérmico.

Si se altera la queratinización, puede aparecer descamación o hiperqueratosis.

Si se altera la pigmentación, pueden producirse cambios de color.

Si se altera la cohesión entre células, puede perderse la integridad epidérmica.

Si se activa una respuesta inmunológica, pueden aparecer procesos inflamatorios.

La anatomía normal constituye, por tanto, la base para comprender la patología.

64. ESQUEMA MAESTRO DE LA EPIDERMIS

SUPERFICIE



ESTRATO CÓRNEO

Corneocitos

Abundante queratina

Sin núcleo

Barrera



ESTRATO LÚCIDO

Especialmente piel gruesa



ESTRATO GRANULOSO

Células aplanadas

Aumento de queratina

Pérdida de organelos



ESTRATO ESPINOSO

5–10 capas

Desmosomas

Cuerpos de Odland



ESTRATO BASAL

Una hilera celular

Proliferación

Melanocitos

Merkel

Hemidesmosomas



MEMBRANA BASAL



DERMIS

65. BADBEAR.MED FIJA

Organización de la piel

Piel = epidermis + dermis + hipodermis.

Epidermis

Epitelio plano estratificado queratinizado.

Es avascular.

Se nutre mediante difusión desde la dermis.

Queratinocito

Es la célula predominante de la epidermis.

Representa aproximadamente el 90 % de sus células.

BADBEAR.MED

Produce queratina.

Renovación

La epidermis se renueva continuamente.

La clase establece aproximadamente 30 días para el recambio.

Estratos

Basal → Espinoso → Granuloso → Lúcido → Córneo.

Piel gruesa

El estrato lúcido se identifica especialmente en palmas y plantas.

Desmosomas

Unen queratinocitos entre sí.

Hemidesmosomas

Unen queratinocitos basales con la membrana basal.

Basal

Estrato germinativo y proliferativo.

Espinoso

5–10 capas de queratinocitos con abundantes desmosomas.

Granuloso

Aumenta la queratina y desaparecen progresivamente los organelos.

Córneo

Está formado por corneocitos ricos en queratina y sin núcleo.

Melanocito

Está en el estrato basal.

Produce melanina.

Melanina

Participa en pigmentación y fotoprotección.

Langerhans

Relacionadas con inmunidad.

Participan en dermatitis alérgica de contacto.

Merkel

Relacionadas con tacto.

Superficie cutánea

BADBEAR.MED

Los dermatoglifos forman las huellas dactilares.

Penetración cutánea

Puede producirse:

entre corneocitos,

a través de corneocitos,

o por vías anexiales.

66. REPASO RAZONADO DEL TEMA

Si tuviéramos que reconstruir toda la epidermis sin memorizar una lista, bastaría con seguir la historia de un queratinocito.

El queratinocito **nace en el estrato basal**, donde existe capacidad proliferativa.

Después asciende hacia el **estrato espinoso**, donde permanece fuertemente unido a otras células mediante desmosomas.

Posteriormente alcanza el **estrato granuloso**, donde se aplanan, aumenta la cantidad de queratina y comienza a perder su maquinaria celular.

En las regiones de piel gruesa atraviesa posteriormente el **estrato lúcido**.

Finalmente llega al **estrato córneo**, donde ya se ha convertido en un corneocito altamente queratinizado y sin núcleo.

Ese corneocito forma parte de la barrera superficial y finalmente será eliminado mediante descamación.

Mientras todo este proceso ocurre, los **melanocitos** distribuyen pigmento, las **células de Langerhans** participan en la inmunidad y las **células de Merkel** intervienen en la sensibilidad táctil.

Por eso la epidermis debe entenderse como un tejido en renovación continua, funcionalmente complejo y estrechamente relacionado con la dermis.

Sí. A partir de ahora eso queda como una regla fija del cuaderno.

En cada tema voy a poner varias **“BADBEAR.MED FIJA:”** distribuidas justo donde aparezca un dato realmente importante: conceptos que suelen preguntar, diferencias que generan confusión, relaciones clínicas, datos que ayudan a reconocer una lesión o enfermedad, mecanismos clave y puntos que conviene memorizar.

No las dejaré solo para el final. Irán apareciendo durante el desarrollo, por ejemplo:

BADBEAR.MED FIJA:

Desmosoma = unión queratinocito–queratinocito.

Hemidesmosoma = unión queratinocito basal–membrana basal.

O: BADBEAR.MED FIJA:

La epidermis es **avascular**; se nutre por difusión desde la dermis.

O: **BADBEAR.MED FIJA:**

El estrato lúcido se observa principalmente en **piel gruesa: palmas y plantas**.

Y al final de cada tema habrá también un bloque de **BADBEAR.MED FIJA – REPASO DE ALTA RENTABILIDAD**, reuniendo las perlas más importantes del capítulo.

Eso hará que el cuaderno no sea solo explicativo, sino también muy útil para repasar antes del examen.

Clase 3

Enlace del video original: [Clase 3 Acné y rosácea](#)

Material audiovisual en el canal de [badbear.med](#)

FUENTE 3: ENFERMEDADES VIRALES DE LA PIEL

Lesiones clave que debes reconocer

HERPES SIMPLE

Vesículas agrupadas sobre base eritematosa ("racimo de uvas")



Herpes simple labial (HSV-1)
Vesículas agrupadas en bermellón.



Herpes simple genital (HSV-2)
Vesículas y erosiones agrupadas sobre base eritematosa.

HERPES ZÓSTER

Vesículas en dermatoma, unilaterales, muy dolorosas



Herpes zóster en dermatoma torácico
Vesículas agrupadas sobre base eritematosa, dispuestas en banda.

VERRUGAS POR VPH

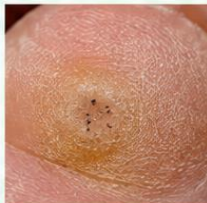
Pápulas o placas hiperqueratósicas, rugosas



Verruga vulgar
Superficie rugosa e hiperqueratósica.



Verrugas planas
Pápulas aplanadas, color piel.



Verruga plantar
Hiperqueratosis con puntos negros (vasos trombosados).



Condiloma acuminado
Lesión exofítica en "coliflor".

MOLUSCO CONTAGIOSO

Pápulas perladas, umbilicadas



Molusco contagioso
Pápulas nacaradas con umbilicación central.



Molusco contagioso múltiple
Lesiones múltiples en tronco de un niño.

**BADBEAR.MED
FIJA:**

- **Herpes simple** = vesículas agrupadas en base eritematosa (racimo de uvas).
- **Herpes zóster** = vesículas en dermatoma + dolor neurítico.
- **VPH** = verrugas (vulgar, plana, plantar, condiloma).
- **Molusco contagioso** = pápula perlada umbilicada.

PARTE 3. ACNÉ Y ROSÁCEA

TEMA 1. ACNÉ

1. Concepto general

El acné es una **enfermedad inflamatoria crónica** que compromete principalmente la **unidad pilosebácea**. Este concepto es fundamental: no debe considerarse simplemente una infección de la piel.

Para que aparezca acné deben intervenir varios factores que actúan simultáneamente sobre el folículo piloso y la glándula sebácea. El resultado final es la aparición de lesiones de diferente naturaleza: seborrea, comedones, pápulas, pústulas, nódulos, quistes y posteriormente cicatrices.

Además de las lesiones cutáneas, el acné puede producir un impacto psicológico y social considerable.

BADBEAR.MED FIJA:

El acné es una enfermedad inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea. NO debe entenderse como una enfermedad infecciosa primaria.

2. Unidad pilosebácea

La estructura anatómica fundamental involucrada en el acné es la **unidad pilosebácea**.

Está constituida por:

folículo piloso + glándula sebácea + conducto folicular.

Una región particularmente importante es el **infundíbulo folicular**, que corresponde a la porción superior del folículo y posee una configuración semejante a un embudo.

La glándula sebácea contiene **sebocitos**, células encargadas de producir sebo. En esta unidad también viven diferentes microorganismos que forman parte de la microbiota cutánea. Entre ellos adquiere importancia **Cutibacterium acnes**.

3. Papel de los andrógenos

La glándula sebácea es sensible a los **andrógenos**.

Esto explica en buena parte por qué el acné suele aparecer o empeorar durante la adolescencia, cuando aumenta el estímulo hormonal sobre las unidades pilosebáceas.

Los sebocitos poseen receptores para diferentes andrógenos.

Entre los mencionados en la clase se encuentran:

DHEA, testosterona, dihidrotestosterona y otros precursores androgénicos.

La **dihidrotestosterona** posee una actividad androgénica especialmente potente.

Un punto importante es que para presentar acné **no necesariamente deben existir concentraciones sanguíneas elevadas de andrógenos**. Puede existir una mayor sensibilidad de la unidad pilosebácea al estímulo hormonal.

BADBEAR.MED FIJA:

Acné ≠ necesariamente hiperandrogenemia.

El problema puede estar en la **respuesta de la glándula sebácea a los andrógenos**, no necesariamente en una elevación sérica de estos.

4. Fisiopatología del acné

La fisiopatología debe entenderse como la interacción de varios mecanismos.

Podemos organizarla en cinco grandes componentes:

predisposición hereditaria → estímulo androgénico → aumento/señalización sebácea → hiperqueratinización folicular → participación de C. acnes + inflamación.

5. Predisposición hereditaria

Existe una importante influencia genética.

La transcripción describe una expresión hereditaria variable y señala mayor probabilidad de acné cuando existe antecedente familiar.

La genética puede influir sobre:

la actividad sebácea, la respuesta hormonal, la queratinización del folículo y la intensidad de la respuesta inflamatoria.

6. Estímulo de la glándula sebácea

Los andrógenos estimulan directamente a los **sebocitos**.

Esto favorece una mayor actividad de la glándula sebácea y, en consecuencia, una mayor producción de sebo.

Por esta razón, la **seborrea** constituye una característica muy frecuente en los pacientes con acné.

La transcripción recalca además que las formas más persistentes y graves tienden a observarse con mayor frecuencia en varones.

7. Hiperqueratinización del infundíbulo folicular

Uno de los mecanismos centrales es la **queratinización anormal del infundíbulo folicular**.

Las células queratinizadas comienzan a acumularse dentro del conducto.

Esto dificulta progresivamente la salida normal del sebo hacia la superficie.

El contenido sebáceo queda retenido.

Así se forma inicialmente una obstrucción microscópica que puede evolucionar hacia un **microcomedón**.

La disminución del ácido linoleico y las alteraciones de la composición del sebo también se relacionan con este proceso de hiperqueratinización.

Secuencia fundamental

hiperqueratinización



obstrucción del infundíbulo



retención de sebo



microcomedón



comedón clínicamente visible

BADBEAR.MED FIJA:

El microcomedón es consecuencia de la obstrucción folicular producida por hiperqueratinización.

8. Cutibacterium acnes

Cutibacterium acnes forma parte de la microbiota de la unidad pilosebácea.

Su importancia en el acné no consiste simplemente en comportarse como una bacteria invasora.

Puede formar **biopelículas**, favorecer la hiperqueratinización folicular y participar en la formación de microcomedones.

La biopelícula proporciona un microambiente organizado donde el microorganismo puede mantenerse y contribuir a la persistencia del proceso.

9. Inflamación

Cuando el proceso progresa puede producirse lesión de la pared folicular.

El contenido sebáceo y otros componentes entran en contacto con la dermis.

Esto desencadena una respuesta inflamatoria.

Participan:

interleucinas, moléculas de adhesión, monocitos y diferentes mediadores de la inmunidad.

El resultado clínico puede ser la transformación de una lesión inicialmente comedónica en:

pápula → pústula → nódulo → quiste.

Cuando la inflamación es intensa y profunda aumenta también el riesgo de cicatrización permanente.

BADBEAR.MED FIJA:

A mayor profundidad e intensidad de la inflamación, mayor riesgo de cicatriz.

10. Relación con hiperandrogenismo femenino

Cuando una mujer presenta acné acompañado de otras manifestaciones de hiperandrogenismo debe considerarse la posibilidad de un trastorno hormonal asociado.

La clase menciona el síndrome de ovario poliquístico, asociado con manifestaciones como: hirsutismo, acné, obesidad abdominal, alopecia androgenética y alteraciones ováricas.

Esto no significa que toda mujer con acné tenga síndrome de ovario poliquístico.

El dato relevante es la **asociación de signos clínicos de hiperandrogenismo**.

BADBEAR.MED FIJA:

Acné + hirsutismo + alopecia androgenética + alteraciones metabólicas/menstruales → pensar en hiperandrogenismo asociado.

11. Tétrada de oclusión folicular

El acné puede relacionarse con otras enfermedades en las que existe oclusión e inflamación folicular.

La clase agrupa cuatro entidades:

Componente Entidad

- | | |
|---|---|
| 1 | Acné conglobata |
| 2 | Celulitis disecante del cuero cabelludo |
| 3 | Hidradenitis supurativa |
| 4 | Quiste pilonidal |

La celulitis disecante puede destruir el folículo piloso y originar **alopecia cicatricial**.

La hidradenitis supurativa afecta especialmente grandes pliegues como axilas e ingles y es fundamentalmente una enfermedad inflamatoria.

BADBEAR.MED FIJA:

Tétrada de oclusión folicular: acné conglobata + hidradenitis supurativa + celulitis disecante + quiste pilonidal.

Es una asociación de alta rentabilidad para examen.

12. Acné inducido por fármacos

Existen medicamentos capaces de desencadenar erupciones acneiformes.

La clase menciona:

hormonas, vitaminas, sustancias halogenadas, antiepilépticos, tuberculostáticos, psicofármacos, antimicrobianos y corticoides.

Una característica importante de las erupciones medicamentosas acneiformes es que frecuentemente son **monomorfas**.

Es decir, predominan lesiones muy similares entre sí.

Esto contrasta con el acné vulgar clásico, que suele ser **polimorfo**.

BADBEAR.MED FIJA:

Acné vulgar → generalmente POLIMORFO.

Erupción acneiforme por fármacos → frecuentemente MONOMORFA.

13. Característica clínica fundamental: polimorfismo

Una de las claves diagnósticas del acné es el **polimorfismo lesional**.

En una misma región pueden coexistir:

máculas, comedones, pápulas, pústulas, nódulos, quistes y cicatrices.

Por eso no debe esperarse que todas las lesiones sean iguales.

14. Localización

Las regiones más características son:

cara, tórax y espalda.

Estas zonas contienen abundantes unidades pilosebáceas.

El compromiso extrafacial y especialmente el compromiso importante de espalda se observa con mayor frecuencia en varones.

15. Clasificación de las lesiones

Las lesiones pueden agruparse inicialmente en:

Lesiones no inflamatorias

Principalmente los **comedones**.

Lesiones inflamatorias

Pápulas, pústulas, nódulos y quistes.

Esta distinción tiene importancia porque refleja el grado de inflamación existente.

16. Comedón

El **comedón** constituye la lesión más característica del acné.

Sin embargo, la clase recalca que **no es patognomónico**, porque también puede encontrarse en otras enfermedades.

Existen dos formas principales.

17. Comedón abierto

Corresponde al conocido clínicamente como:

“punto negro”.

Existe una comunicación del contenido folicular con la superficie.

La apariencia oscura permite reconocerlo fácilmente.

18. Comedón cerrado

El conducto permanece cubierto por epidermis.

Clínicamente aparece como una pequeña elevación blanquecina o del color de la piel.

Tanto comedones abiertos como cerrados pueden coexistir.

BADBEAR.MED FIJA:

Lesión característica del acné = COMEDÓN.

Pero:

comedón ≠ lesión patognomónica.

19. Manipulación de los comedones

Muchos pacientes intentan perforarlos, **exprimirlos** o retirarlos manualmente.

Esta manipulación puede incrementar la inflamación local.

Por ello puede facilitar:

irritación, eritema, hiperpigmentación y eventualmente cicatrices.

20. Formas clínicas del acné

La presentación puede variar desde formas predominantemente comedónicas hasta cuadros inflamatorios graves.

En términos prácticos podemos reconocer:

acné comedónico



acné papulopustuloso



acné noduloquístico



formas graves: acné conglobata / acné fulminans

No todos los pacientes necesariamente siguen esta secuencia.

21. Acné comedónico

Predominan comedones abiertos y cerrados.

Cuando existen **macrocomedones**, la clase señala que el cuadro puede ser más persistente y rebelde al tratamiento.

22. Acné papulopustuloso

En este cuadro predominan lesiones inflamatorias:

pápulas + pústulas.

Puede existir gran cantidad de lesiones y, si no se controla adecuadamente, aparecer posteriormente:

hiperpigmentación residual y cicatrices, especialmente atróficas.

23. Acné noduloquístico

Representa una forma grave.

Predominan:

nódulos y quistes profundos.

Debido a la profundidad del proceso inflamatorio, existe un riesgo considerable de cicatrices permanentes.

Incluso con tratamiento pueden quedar lesiones residuales.

BADBEAR.MED FIJA:

Nódulos/quistes = inflamación profunda = alto riesgo de cicatriz.

24. Acné fulminans

Es una forma muy infrecuente y grave.

La clase destaca la existencia de importante compromiso inflamatorio e inmunológico.

Debe reconocerse como una forma excepcional dentro del espectro clínico.

25. Acné conglobata

El **acné conglobata** corresponde a una de las formas más severas.

Existen múltiples nódulos y quistes profundos que pueden comunicarse entre sí en la dermis.

Clínicamente pueden observarse simultáneamente:

eritema, pápulas, pústulas, costras, exudado, comedones, nódulos y quistes.

El término “conglobata” ayuda a recordar la tendencia de las lesiones profundas a agruparse y comunicarse.

BADBEAR.MED FIJA:

Acné conglobata = forma muy grave, con nódulos y quistes profundos que pueden comunicarse.

26. Secuelas del acné

El acné puede dejar diferentes lesiones residuales:

hiperpigmentación

cicatrices atróficas

cicatrices hipertróficas

queloides.

La espalda y región mandibular pueden presentar cicatrices elevadas cuando la inflamación ha sido intensa.

27. Cicatrices atróficas

Son depresiones cutáneas secundarias a pérdida de tejido durante el proceso inflamatorio y reparativo.

Entre ellas la clase menciona las denominadas cicatrices en:

“picahielo”.

Estas cicatrices profundas son particularmente difíciles de corregir completamente.

28. Impacto psicosocial

El acné no debe evaluarse únicamente por el número de lesiones.

Puede alterar significativamente:

la autoestima, la función social y el bienestar emocional.

La transcripción menciona asociación con ansiedad y depresión.

Por ello la gravedad dermatológica y la repercusión psicológica no siempre son equivalentes.

Un paciente con relativamente pocas lesiones puede experimentar un impacto emocional considerable.

BADBEAR.MED FIJA:

En acné, evaluar piel y calidad de vida.

La gravedad clínica no siempre refleja el sufrimiento psicológico.

29. Formas especiales

Acné neonatal

Se manifiesta mediante lesiones monomorfas, fundamentalmente pápulas eritematosas.

La clase destaca que muchas veces presenta resolución espontánea durante las primeras semanas.

30. Acné cosmético

Puede aparecer después del uso de productos capaces de obstruir la salida folicular.

La transcripción menciona productos con componentes oclusivos como la vaselina.

Las lesiones tienden a ser **monomorfas**, principalmente papulares.

31. Acné mecánico

Se desarrolla en zonas sometidas repetidamente a:

fricción, presión o roce.

La clase utiliza como ejemplo el roce del cuello de la camisa.

32. Acné por fármacos

Puede aparecer asociado a diferentes medicamentos.

Las lesiones suelen ser monomorfas.

La transcripción menciona especialmente corticosteroides y vitamina B12 entre los ejemplos desarrollados.

33. Diagnóstico diferencial

El acné puede confundirse con diferentes dermatosis faciales.

Entre las entidades revisadas en clase se encuentran:

rosácea, dermatitis seborreica, foliculitis de la barba, elastosis con quistes y comedones, quistes de milium, dermatitis periorificial y angiofibromas.

La identificación del **comedón**, la edad, la distribución y el patrón polimorfo ayudan a orientar el diagnóstico.

34. Tratamiento tópico del acné

Cuando existen lesiones limitadas pueden emplearse diferentes tratamientos tópicos.

Entre los mencionados están:

peróxido de benzoilo, ácido salicílico, ácido azelaico, alfa-hidroxiácidos, antibióticos tópicos y retinoides tópicos.

Los retinoides son especialmente importantes por su acción sobre la queratinización folicular.

35. Tratamiento sistémico

Cuando el proceso es más inflamatorio o extenso pueden emplearse tratamientos sistémicos.

La clase desarrolla especialmente:

tetraciclinas

e

isotretinoína.

Entre las tetraciclinas menciona minociclina, limeciclina y doxiciclina.

Su efecto se orienta, entre otros mecanismos, hacia la participación de C. acnes y la inflamación.

36. Isotretinoína

La isotretinoína ocupa un lugar central en el tratamiento sistémico.

La clase la considera la “**piedra angular**” porque actúa sobre varios de los mecanismos fisiopatológicos del acné.

Uno de sus aspectos más importantes es su **teratogenicidad**.

En mujeres en edad fértil requiere medidas estrictas para prevenir embarazo.

También es necesario vigilar efectos adversos y, cuando corresponda, evaluar función hepática.

BADBEAR.MED FIJA:

Isotretinoína = muy eficaz, pero TERATOGENICA.

Este es uno de los datos que no debe olvidarse.

37. Tratamiento hormonal

En mujeres seleccionadas pueden utilizarse tratamientos hormonales.

La clase desarrolla particularmente:

acetato de ciproterona

y

espironolactona.

Ambos pueden interferir con la señal androgénica.

La espironolactona, además de ser un antagonista de la aldosterona y diurético ahorrador de potasio, posee actividad antiandrogénica mediante bloqueo de receptores.

38. Tratamiento de las cicatrices

Una vez establecidas las cicatrices, su corrección puede ser compleja.

La clase revisa diferentes procedimientos, entre ellos:

subcisión, ácido hialurónico, láser CO₂, radiofrecuencia, peelings químicos, microneedling, dermoabrasión y técnicas con punch.

La **subcisión** busca romper tractos fibrosos que mantienen deprimida una cicatriz atrófica.

El objetivo es permitir que la superficie deprimida se eleve parcialmente.

BADBEAR.MED FIJA:

Lo mejor para las cicatrices del acné es prevenirlas tratando tempranamente el acné inflamatorio profundo.

Una cicatriz establecida es mucho más difícil de corregir que una lesión activa.

TEMA 2. ROSÁCEA

39. Concepto general

La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta fundamentalmente la región facial.

A diferencia del acné juvenil, aparece típicamente en personas de mayor edad, frecuentemente **después de los 30 años**.

Su manifestación básica es el **eritema centrofacial persistente**, al cual pueden asociarse:

telangiectasias, pápulas, pústulas, flushing, ardor, prurito, sequedad, edema, cambios fimatosos y afectación ocular.

BADBEAR.MED FIJA:

Rosácea = adulto >30 años + eritema centrofacial persistente ± telangiectasias ± pápulas/pústulas.

40. Epidemiología

La rosácea es particularmente evidente en personas con fototipos claros, aunque también puede presentarse en fototipos III y IV.

Es más frecuente en mujeres, aproximadamente con una relación mujer:hombre de 3:1 señalada en la clase.

Sin embargo, cuando aparece en varones puede presentar formas más graves.

41. Factores desencadenantes

La rosácea presenta numerosos factores capaces de desencadenar o agravar el eritema.

Entre los destacados se encuentran:

radiación solar, calor, cambios bruscos de temperatura, alimentos muy calientes o muy fríos, alcohol, ejercicio, estrés y diferentes productos cosméticos.

BADBEAR.MED FIJA:

El SOL es uno de los grandes enemigos de la rosácea.

La fotoeducación forma parte del tratamiento.

42. Fisiopatología de la rosácea

La rosácea presenta una fisiopatología compleja donde participan mecanismos:

inflamatorios, vasculares, inmunológicos y neurosensoriales.

La radiación ultravioleta, especies reactivas de oxígeno, factores de crecimiento, receptores tipo Toll, calicreínas, metaloproteinasas, catelicidinas y receptores de potencial transitorio participan en una cascada que finalmente favorece:

inflamación + angiogénesis.

La angiogénesis y la dilatación vascular ayudan a comprender clínicamente:
el eritema y las telangiectasias.

43. Catelicidinas

La clase desarrolla particularmente una catelicidina con actividad antimicrobiana e inmunomoduladora.

Estas moléculas participan en:

reclutamiento celular, regulación inmunológica, reparación tisular y angiogénesis.

Una alteración en estos sistemas contribuye al estado inflamatorio crónico de la rosácea.

44. Piel sensible

Los pacientes con rosácea frecuentemente presentan **piel sensible**.

Existe una reactividad excesiva frente a estímulos externos e internos.

Participan:

alteración de la capa córnea, disfunción neurosensorial y cambios en canales de potencial receptor transitorio.

Por ello productos perfectamente tolerados por otras personas pueden producir:

ardor, irritación, eritema o empeoramiento de la rosácea.

45. Exposoma

El concepto de **exposoma** hace referencia al conjunto de exposiciones ambientales y personales acumuladas a lo largo de la vida.

En rosácea pueden influir:

radiación ultravioleta, temperatura, humedad, polución, estrés, falta de sueño y microbiota.

Este concepto ayuda a comprender por qué el comportamiento clínico puede variar considerablemente de un paciente a otro.

46. Clasificación clínica

La clase menciona diferentes maneras de clasificarla.

Entre las formas reconocibles encontramos:

Forma	Manifestación dominante
Eritemato-telangiectásica	Eritema y telangiectasias

Papulopustulosa	Pápulas y pústulas
Fimatosas	Engrosamiento tisular, como rinoftoma
Ocular	Compromiso ocular

También puede describirse simplemente como leve, moderada o severa.

47. Rosácea eritemato-telangiectásica

Predominan:

eritema centrofacial persistente + telangiectasias.

Las telangiectasias corresponden a pequeños vasos superficiales visibles.

Pueden tratarse mediante procedimientos dirigidos a los vasos, como técnicas de electrocirugía o láser mencionadas en la clase.

48. Rosácea papulopustulosa

Además del eritema aparecen:

pápulas y pústulas.

Esta presentación puede confundirse con acné.

Aquí aparece una diferencia de enorme importancia:

ACNÉ

presenta comedones.

ROSÁCEA

el patrón típico se basa en eritema centrofacial, telangiectasias, pápulas y pústulas.

BADBEAR.MED FIJA:

Acné vs rosácea: BUSCA COMEDONES.

La presencia de comedones favorece el diagnóstico de acné.

49. Rosácea granulomatosa

Es una presentación poco frecuente.

Predominan lesiones papulares y nodulares con patrón granulomatoso.

50. Rosácea fimatosa

En formas avanzadas puede desarrollarse hipertrofia y engrosamiento de determinadas regiones.

La forma nasal recibe el nombre de:

rinofima.

La clase la presenta como una manifestación avanzada de la enfermedad.

BADBEAR.MED FIJA:

Rinofima = manifestación fimatosa de rosácea, típicamente nasal.

51. Rosácea ocular

La enfermedad puede comprometer estructuras oculares.

Puede existir:

eritema conjuntival, irritación, ojo rojo e inflamación palpebral.

Cuando existe afectación ocular, la evaluación oftalmológica adquiere importancia.

BADBEAR.MED FIJA:

Rosácea + síntomas oculares → considerar rosácea ocular y evaluación oftalmológica.

52. Rosácea extrafacial

La localización predominante es facial.

Sin embargo, la clase señala que excepcionalmente puede existir compromiso extrafacial.

53. Rosácea infantil

Es infrecuente, pero puede presentarse.

La clase menciona además asociación con determinadas comorbilidades, incluyendo migraña.

54. Demodex y rosácea

Durante mucho tiempo se discutió intensamente la participación de **Demodex folliculorum** y **Demodex brevis** en la rosácea.

La clase recalca que pueden participar en la fisiopatología, pero **no deben considerarse el único factor determinante.**

La demodicosis ocular puede producir:

secreciones en la base de las pestañas, prurito, lagrimeo e hiperemia.

55. Diagnóstico diferencial con dermatitis seborreica

La dermatitis seborreica también puede afectar la región centrofacial.

Puede producir:

eritema, pápulas y descamación.

Por ello puede confundirse con rosácea.

La presencia de descamación más característica orienta hacia dermatitis seborreica, mientras que el eritema persistente, flushing y telangiectasias favorecen rosácea.

56. Corticoides y rosácea

Este es uno de los puntos clínicos más importantes de esta sección.

Los corticoides tópicos o sistémicos pueden producir una aparente mejoría inicial.

Sin embargo, posteriormente puede aparecer un **fenómeno de rebote** con empeoramiento importante de la rosácea.

BADBEAR.MED FIJA:

Corticoides pueden empeorar la rosácea y producir rebote.

No confundir mejoría transitoria con control real de la enfermedad.

57. Medidas generales

El manejo de la rosácea comienza con educación del paciente.

Debe reconocerse qué factores desencadenan el cuadro.

Especial importancia tiene:

fotoprotección adecuada.

También debe evitarse el uso indiscriminado de cosméticos irritantes.

La piel de estos pacientes es particularmente reactiva, por lo que no necesariamente un producto “más potente” o “de mayor calidad” será mejor tolerado.

58. Tratamiento tópico de la rosácea

Entre las opciones mencionadas se encuentran:

ácido azelaico, metronidazol tópico, antibióticos tópicos, tacrolimus y algunos retinoides utilizados con precaución por su potencial irritante.

El **metronidazol tópico** constituye una de las alternativas frecuentemente utilizadas en la clase.

La concentración y duración deben ajustarse a la tolerancia del paciente.

59. Tratamiento sistémico

Las tetraciclinas pueden emplearse principalmente por su efecto **antiinflamatorio**, no simplemente como antibióticos.

La clase también menciona:

isotretinoína a dosis bajas

en determinadas formas de rosácea.

60. Flushing y propranolol

El propranolol bloquea receptores betaadrenérgicos y puede utilizarse en determinados pacientes para disminuir episodios de flushing.

La respuesta no necesariamente es uniforme.

61. ACNÉ VS ROSÁCEA

Este cuadro debe dominarse porque es un diagnóstico diferencial muy frecuente.

Característica	ACNÉ	ROSÁCEA
Edad típica	Adolescencia/adulto joven	Frecuentemente >30 años
Unidad principal	Pilosebácea	Inflamatoria/vascular facial
Comedones	Sí, característicos	No constituyen lesión típica
Seborrea	Muy frecuente	No es el elemento dominante
Eritema centrofacial persistente	Puede existir inflamación	Característico
Telangiectasias	No predominantes	Frecuentes
Pápulas	Sí	Sí
Pústulas	Sí	Sí
Nódulos/quistes	Pueden aparecer	No son la manifestación clásica
Flushing	No característico	Muy característico
Rinofima	No	Puede aparecer
Afectación ocular	No típica	Puede existir
Patrón	Frecuentemente polimorfo	Predominio inflamatorio/vascular

BADBEAR.MED FIJA:

Frente a un paciente con “granitos” en la cara, no diagnostiques acné automáticamente.

Primero pregúntate:

¿Hay comedones?

Si hay comedones → favorece **ACNÉ**.

Si hay eritema centrofacial persistente + telangiectasias + flushing ± pápulas/pústulas → favorece **ROSÁCEA**.

BADBEAR.MED FIJA — REPASO DE ALTA RENTABILIDAD

1. Acné = enfermedad inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea.
2. No debe considerarse una infección primaria.
3. Los cuatro mecanismos fundamentales son: actividad sebácea/androgénica + hiperqueratinización folicular + C. acnes + inflamación.
4. No todos los pacientes con acné presentan hiperandrogenemia.
5. El comedón es la lesión característica del acné, pero NO es patognomónico.
6. Acné vulgar = generalmente polimorfo.
7. Erupción acneiforme por fármacos = frecuentemente monomorfa.
8. Nódulos y quistes implican inflamación profunda y mayor riesgo de cicatriz.
9. Acné conglobata = forma muy grave con lesiones profundas y comunicantes.
10. Isotretinoína = tratamiento sistémico fundamental; recordar siempre su teratogenicidad.
11. Tétrada de oclusión folicular = acné conglobata + hidradenitis supurativa + celulitis disecante + quiste pilonidal.
12. Rosácea = adulto, típicamente >30 años, con eritema centrofacial persistente.
13. Telangiectasias y flushing orientan fuertemente hacia rosácea.
14. Rosácea NO presenta típicamente comedones.
15. Sol, calor, cambios térmicos, alcohol, ejercicio y estrés pueden exacerbar rosácea.
16. Rinofima = forma fimatosa de rosácea.
17. Rosácea ocular puede requerir evaluación oftalmológica.
18. Los corticoides pueden mejorar transitoriamente la rosácea pero posteriormente producir rebote y empeoramiento.
19. En rosácea la tetraciclina puede actuar principalmente como antiinflamatorio.
20. La mejor pregunta para diferenciar acné de rosácea cuando existen pápulas y pústulas faciales es: “¿hay comedones?”

Video original: [Clase 4 Enfermedades Inflamatorias de la Piel](#)

Material audiovisual en [Badbear.med](#)

FUENTE 4: INFECCIONES BACTERIANAS DE LA PIEL

Lesiones clave que debes reconocer

BADBEAR.MED

IMPÉTIGO NO BULLOSO

Costras melicéricas



- Costras melicéricas (color miel)
- Común en niños
- Frecuente en cara (nariz, peribucal)
- Agente: Staphylococcus aureus / Streptococcus pyogenes

IMPÉTIGO BULLOSO

Ampollas frágiles



- Ampollas flácidas de contenido claro
- Se rompen fácilmente
- Dejan erosiones con collarete descamativo
- Más frecuente en recién nacidos y niños
- Agente: Staphylococcus aureus (productor de toxina exfoliativa)

ECTIMA

Úlceras con costras gruesas



- Úlcera más profunda que el impétigo
- Costras gruesas, de aspecto necrótico
- Deja cicatriz
- Más frecuente en extremidades
- Agente: Streptococcus pyogenes (± Staphylococcus aureus)

FOLICULITIS

Pústulas foliculares



- Pústulas centradas en folículos pilosos
- Eritema perifolicular
- Frecuente en zonas con vello
- Agente: Staphylococcus aureus
- Puede ser superficial o profunda

FORÚNCULO

Nódulo doloroso con pus



- Nódulo eritematoso, doloroso
- Centro con pus (necrosis)
- Evoluciona a drenaje espontáneo
- Frecuente en nuca, espalda, muslos, glúteos
- Agente: Staphylococcus aureus
- Puede ser único o múltiple (forunculosis)

CELULITIS vs ERISPELA

Placas eritematosas extensas



Celulitis

- Bordes mal definidos
- Compromiso más profundo (dermis e hipodermis)
- Frecuente en extremidades

Erisipela

- Bordes bien definidos
- Compromiso superficial (dermis)
- Inicio brusco, fiebre frecuente

**BADBEAR.MED
FIJA:**

- **Impétigo** = costras melicéricas (niños).
- **Impétigo buloso** = ampollas flácidas (S. aureus, toxina exfoliativa).
- **Ectima** = úlcera profunda que deja cicatriz.
- **Foliculitis** = pústulas en folículos pilosos.

- **Forúnculo** = nódulo doloroso con pus.
- **Celulitis** = placa eritematosa difusa, profunda.
- **Erisipela** = placa eritematosa con bordes definidos, superficial.
- Piensa en S. aureus y S. pyogenes.

CLASE 4. ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA PIEL

En esta clase se desarrollan tres grandes enfermedades inflamatorias cutáneas:

1. **Dermatitis de contacto**
2. **Dermatitis atópica**
3. **Dermatitis seborreica**

Las tres tienen un elemento común: pueden manifestarse clínicamente mediante **ecema**. Por eso, antes de estudiar cada enfermedad por separado, es indispensable entender exactamente qué significa este término.

TEMA 1. ECEMA

1. Concepto

El término **ecema** describe una reacción inflamatoria de la piel caracterizada principalmente por:

- prurito;
- eritema;
- edema;
- vesículas;
- exudación;
- costras;
- descamación;
- y, cuando el proceso se hace crónico, liquenificación.

El ecema no corresponde a una sola lesión elemental. Es una **combinación de lesiones** que cambia dependiendo del momento evolutivo en el que se encuentre la enfermedad. Por esta razón se considera **polimorfo**.

BADBEAR.MED FIJA:

ECEMA = lesión inflamatoria PRURIGINOSA y POLIMORFA.

No esperes encontrar una única lesión.

Puede haber al mismo tiempo:

eritema + pápulas + vesículas + exudado + costras + escamas.

2. Evolución del ecema

El aspecto clínico del ecema cambia con el tiempo.

Podemos dividirlo en:

- agudo;
- subagudo;
- crónico.

Esta clasificación resulta muy útil porque permite interpretar rápidamente el aspecto de la piel.

3. Ecema agudo

En la fase aguda predomina una respuesta inflamatoria intensa.

La piel puede encontrarse:

- eritematosa;
- edematosa;
- húmeda;
- macerada;
- con pápulas;
- con vesículas;
- con exudación;
- con formación posterior de costras.

Las vesículas pueden romperse y liberar líquido, razón por la cual la superficie puede observarse mojada o exudativa.

Esquema

ERITEMA



EDEMA



VESÍCULAS



ruptura



EXUDADO



COSTRAS

BADBEAR.MED FIJA:

Si observas una lesión:

roja + húmeda + vesicular + exudativa = piensa en ECEMA AGUDO.

4. Ecema subagudo

Representa una fase intermedia entre el proceso agudo y el crónico.

Pueden observarse:

- pápulas;
- erosiones;
- costras;
- escamas;
- inicio de cambios liquenificados.

En otras palabras, la lesión ya no es tan húmeda como en la fase aguda, pero todavía no presenta toda la arquitectura engrosada típica del ecema crónico.

5. Ecema crónico

Cuando el prurito persiste durante mucho tiempo, el paciente se rasca repetidamente.

Este rascado continuo produce modificaciones estructurales en la piel.

La principal es la **liquenificación**.

La piel se vuelve:

- gruesa;
- áspera;
- hiperpigmentada;
- escamosa;
- con líneas cutáneas muy marcadas;
- con excoiaciones;
- incluso con fisuras.

BADBEAR.MED FIJA:

LIQUENIFICACIÓN = signo de cronicidad.

Es consecuencia principalmente del:

PRURITO → RASCADO CRÓNICO → ENGROSAMIENTO CUTÁNEO.

6. Histopatología del ecema: espongiosis

Una alteración histológica característica del ecema es la **espongiosis**.

La espongiosis corresponde a la acumulación de líquido entre los queratinocitos de la epidermis.

El edema intercelular separa parcialmente a las células y produce un aspecto semejante al de una esponja.

BADBEAR.MED FIJA:

ECEMA → histología característica: ESPONGIOSIS.

Espangiosis = **edema intercelular epidérmico.**

7. La biopsia no necesariamente identifica la causa del ecema

La espangiosis puede aparecer en distintas enfermedades ecematosas.

Por ello, una biopsia puede demostrar un **patrón ecematoso**, pero no necesariamente distinguir por sí sola entre:

- dermatitis de contacto;
- dermatitis atópica;
- dermatitis seborreica.

Para diferenciarlas adquieren gran importancia:

la historia clínica + localización + edad + evolución + factores desencadenantes.

TEMA 2. DERMATITIS DE CONTACTO

La dermatitis de contacto se divide fundamentalmente en:

- 1. Dermatitis de contacto irritativa**
- 2. Dermatitis de contacto alérgica**

Clínicamente pueden parecer similares, pero su mecanismo es completamente diferente.

TEMA 2A. DERMATITIS DE CONTACTO IRRITATIVA

8. Concepto

La dermatitis de contacto irritativa es una reacción inflamatoria producida por el **daño directo de una sustancia o agente sobre la piel.**

No necesita una respuesta alérgica específica.

El agente posee suficiente capacidad irritante como para alterar directamente la barrera cutánea.

Un ejemplo sencillo es el contacto con **lejía concentrada.**

El daño ocurre por la capacidad irritativa propia de la sustancia y no porque la persona sea alérgica a ella.

BADBEAR.MED FIJA:

Dermatitis irritativa = daño DIRECTO.

NO necesita sensibilización previa.

9. Factores que determinan la intensidad del daño

La gravedad depende fundamentalmente de:

- concentración del irritante;
- tiempo de contacto;
- cantidad;
- superficie expuesta;
- estado previo de la barrera cutánea.

Por ejemplo, una solución concentrada de lejía posee mayor capacidad irritativa que la misma sustancia ampliamente diluida.

10. Principales irritantes

Entre los agentes mencionados se encuentran:

- ácidos fuertes;
- álcalis fuertes;
- disolventes;
- pinturas;
- detergentes;
- limpiadores;
- desinfectantes.

Estos agentes alteran la barrera de la piel y particularmente el manto protector superficial.

11. Irritantes físicos

No solamente las sustancias químicas producen dermatitis irritativa.

También pueden hacerlo factores físicos como:

- fricción;
- microtraumatismos repetitivos;
- calor;
- frío;
- cambios bruscos de temperatura.

Incluso el contacto frecuente con:

- agua;
- polvo;
- tierra

puede favorecer irritación en personas expuestas repetidamente.

12. Patogenia

El agente irritante altera directamente la barrera cutánea.

Los queratinocitos lesionados liberan mediadores proinflamatorios.

Posteriormente se desarrolla una respuesta inflamatoria local.

La diferencia fundamental con la dermatitis alérgica es que aquí **el mecanismo inicial no depende de una sensibilización inmunológica específica.**

13. Distribución de las lesiones

Una característica muy importante es que la lesión suele localizarse exactamente en la región donde ocurrió el contacto.

Por ejemplo:

si las manos manipulan repetidamente un detergente irritante, las lesiones aparecen principalmente en las manos.

BADBEAR.MED FIJA:

Dermatitis irritativa: lesión limitada principalmente a la zona de CONTACTO.

14. Forma aguda

Cuando el irritante es potente, la respuesta puede aparecer rápidamente.

Pueden observarse:

- eritema;
- edema;
- vesículas;
- ampollas;
- exudación;
- maceración;
- dolor.

En algunas lesiones agudas puede predominar incluso el **dolor urente** sobre el prurito.

BADBEAR.MED FIJA:

En dermatitis irritativa aguda puede predominar:

ARDOR / DOLOR > PRURITO.

15. Irritación aguda retardada

No todos los irritantes generan una respuesta inmediata.

Determinados agentes pueden necesitar varias horas antes de que aparezca la reacción clínica.

La clase denomina este patrón **irritación aguda retardada**.

16. Forma crónica

Cuando la exposición al irritante es débil pero repetida, el daño puede acumularse progresivamente.

Aparecen:

- xerosis;
- hiperqueratosis;
- liquenificación;
- escamas;
- fisuras;
- prurito.

Las fisuras pueden ser especialmente dolorosas cuando comprometen manos y dedos.

17. Dermatitis irritativa ocupacional

Muchas formas crónicas están relacionadas con actividades laborales.

Entre los trabajadores mencionados encontramos:

- carpinteros;
- mecánicos;
- pintores;
- personas que manipulan limpiadores;
- trabajadores expuestos a sustancias químicas.

La anamnesis ocupacional es indispensable.

18. Alcohol y sobreuso de productos de higiene

La clase destaca el aumento de dermatitis irritativa asociado al uso repetido de:

- alcohol líquido;
- alcohol gel;
- productos desinfectantes.

El uso excesivo altera progresivamente la barrera cutánea.

También pueden existir casos en niños relacionados con contacto repetido con productos como plastilina o slime.

19. Importancia de la anamnesis

En una dermatitis de manos debemos preguntar:

- ocupación;
- productos que utiliza;
- detergentes;
- jabones;
- desinfectantes;
- pinturas;
- solventes;
- frecuencia de lavado;
- uso de guantes;
- exposición a frío o calor.

Porque mientras continúe el contacto con el irritante, el tratamiento será poco eficaz.

TEMA 2B. DERMATITIS DE CONTACTO ALÉRGICA

20. Concepto

La dermatitis de contacto alérgica es una reacción inflamatoria producida por un **alérgeno** en una persona previamente sensibilizada.

El mecanismo corresponde a una:

hipersensibilidad tipo IV o retardada.

BADBEAR.MED FIJA:

Dermatitis alérgica de contacto = HIPERSENSIBILIDAD TIPO IV.

Necesita **sensibilización previa**.

21. ¿Por qué aparece después de años utilizando un producto?

Esta es una pregunta típica del paciente:

“¿Por qué ahora me da alergia si siempre lo he usado?”

La explicación es que durante exposiciones previas puede desarrollarse progresivamente la **sensibilización**.

Después de esta fase, un nuevo contacto con el mismo alérgeno desencadena la respuesta inflamatoria.

22. Mecanismo inmunológico

El proceso puede entenderse en dos etapas.

Primera exposición: sensibilización

El alérgeno atraviesa la epidermis.



es captado por células dendríticas epidérmicas.



estas células procesan el antígeno.



migran a ganglios linfáticos.



presentan el antígeno a linfocitos T.



se generan linfocitos T sensibilizados.

23. Nueva exposición

Cuando el paciente vuelve a entrar en contacto con el mismo alérgeno:

linfocitos T sensibilizados



migran hacia la piel



liberan citocinas



se genera inflamación



aparece el ecema.

BADBEAR.MED FIJA:

Primera exposición → sensibiliza.

Reexposición → desencadena el ecema.

24. Factores que facilitan sensibilización

Una barrera cutánea deteriorada permite mayor penetración de sustancias.

Factores que pueden favorecerla:

- piel seca;
- falta de hidratación;
- humedad;
- alteración del manto ácido;
- atopía previa.

25. Níquel

El **níquel** constituye uno de los alérgenos clásicos de dermatitis de contacto.

Puede encontrarse en:

- aretes;
- collares;
- cadenas;
- hebillas;
- correas;
- accesorios metálicos.

26. Dermatitis por aretes

Cuando existe sensibilización al níquel, el contacto con un arete puede generar:

- edema;
- eritema;

- prurito;
- exudación;
- ecema del lóbulo auricular.

La localización de la lesión orienta rápidamente hacia el alérgeno responsable.

27. Dermatitis por hebilla de cinturón

En varones puede observarse dermatitis localizada en la región infraumbilical.

El área coincide exactamente con la zona donde la hebilla metálica entra en contacto con la piel.

Si contiene níquel, puede desencadenar un ecema alérgico.

BADBEAR.MED FIJA:

Ecema infraumbilical bien localizado → piensa en níquel de hebilla/correa.

28. Localización como pista etiológica

La distribución permite sospechar el agente.

Párpados

Cosméticos, colirios y productos aplicados en pestañas.

Cuero cabelludo

Tintes.

Cuello

Collares y cadenas.

Región infraumbilical

Hebilla del cinturón.

Manos

Productos laborales, detergentes, productos químicos.

29. Alérgenos aerotransportados

Algunas sustancias pueden llegar a la piel a través del aire:

- polvos;
- solventes;
- sustancias volátiles.

Por ello la anamnesis debe incluir exposiciones que el paciente quizá no considere importantes.

30. Irritativa vs alérgica

Característica	Irritativa	Alérgica
Mecanismo	Daño directo	Inmunológico
Sensibilización previa	No necesaria	Sí
Hipersensibilidad IV	No	Sí
Depende de concentración	Mucho	Menos determinante
Puede ocurrir en cualquier persona	Sí, si irritante suficiente	Solo sensibilizados
Inicio	Puede ser inmediato	Tras sensibilización
Localización	Principalmente contacto	Contacto; puede extenderse
Ejemplo clásico	Lejía	Níquel

BADBEAR.MED FIJA:

IRRITATIVA = sustancia daña directamente.

ALÉRGICA = sistema inmune reconoce un alérgeno previamente conocido.

TEMA 3. DERMATITIS ATÓPICA

31. Concepto

La dermatitis atópica es una **enfermedad inflamatoria crónica y recurrente** caracterizada principalmente por:

- xerosis;
- prurito;
- ecema;
- predisposición personal o familiar a enfermedades atópicas.

Es particularmente frecuente en la infancia.

32. Atopía

El concepto de atopía incluye una predisposición a desarrollar enfermedades como:

- dermatitis atópica;

- asma;
- rinitis alérgica;
- conjuntivitis alérgica;
- urticaria en algunos pacientes.

Los antecedentes familiares constituyen una pista diagnóstica importante.

33. Alteración de la barrera cutánea

Uno de los elementos fundamentales es la incapacidad de la piel para mantener adecuadamente el agua.

La disminución de proteínas relacionadas con la hidratación cutánea conduce a:

pérdida de agua → xerosis → alteración de barrera → mayor sensibilidad cutánea.

34. Xerosis y prurito

La piel seca es una de las características fundamentales.

La relación clínica es muy sencilla:

mayor xerosis → mayor prurito.

El rascado empeora el daño de la barrera y produce más inflamación.

Se establece entonces un círculo:

XEROSIS



PRURITO



RASCADO



LESIÓN CUTÁNEA



MAYOR INFLAMACIÓN



MÁS PRURITO

BADBEAR.MED FIJA:

La XEROSIS es una característica cardinal de la dermatitis atópica.

35. Importancia de la hidratación

La hidratación adecuada es una medida fundamental.

La clase destaca particularmente la aplicación de hidratantes después del baño, cuando la piel todavía conserva humedad.

Esto permite mejorar el mantenimiento del agua en la superficie cutánea.

36. Inmunoglobulina E

En determinados pacientes atópicos puede encontrarse aumento de **IgE**.

Sin embargo, clínicamente debe interpretarse junto con los antecedentes y manifestaciones de atopía.

La enfermedad no debe diagnosticarse únicamente por un valor de laboratorio.

37. Característica clínica principal

El síntoma dominante es:

PRURITO.

Puede ser intenso y persistente.

La enfermedad presenta períodos de:

exacerbación → mejoría → nueva exacerbación.

Por eso se trata de una enfermedad de comportamiento crónico y recurrente.

38. Distribución según la edad

La localización de las lesiones cambia de manera muy característica dependiendo de la edad.

Este es uno de los puntos más importantes para diagnóstico.

39. Dermatitis atópica del lactante

Se considera principalmente en niños pequeños, especialmente desde los primeros meses hasta aproximadamente los 2 años.

Las zonas mencionadas como características son:

- mejillas;
- región frontal;
- cuero cabelludo;

- mentón;
- cuello;
- superficies extensoras;
- glúteos.

40. Respeto centrofacial

Uno de los signos especialmente señalados es que en el lactante suele existir **respeto relativo de la región centrofacial**, particularmente alrededor de la nariz.

Las mejillas pueden estar intensamente afectadas mientras determinadas zonas próximas a la nariz permanecen relativamente libres.

BADBEAR.MED FIJA:

Dermatitis atópica del lactante: MEJILLAS afectadas + región nasolabial relativamente respetada.

Esto será muy útil para diferenciarla de la dermatitis seborreica.

41. Aspecto de las lesiones en el lactante

Pueden aparecer:

- eritema;
- pápulas;
- vesículas;
- costras;
- escamas;
- excoriaciones.

La piel suele llamar la atención por su marcada **resequedad**.

42. Niño de 2 a 12 años

Con la edad cambia la distribución.

Las lesiones se localizan principalmente en:

- pliegues antecubitales;
- pliegues poplíteos;
- flexuras de muñecas;
- flexuras de pies;

- cuello;
- determinadas regiones faciales.

A esta edad el rascado ya es más importante, por lo que aumentan:

- excoriaciones;
- liquenificación;
- hiperpigmentación.

BADBEAR.MED FIJA:

Dermatitis atópica infantil/adolescente → FLEXURAS.

Piensa inmediatamente en:

antecubital + poplítea.

43. Pliegue de Dennie-Morgan

En pacientes atópicos puede aparecer un pliegue marcado debajo del párpado inferior.

Se denomina **línea o pliegue de Dennie-Morgan**.

Puede asociarse con:

- eccema palpebral;
- frotamiento ocular;
- hiperpigmentación periocular.

BADBEAR.MED FIJA:

Dennie-Morgan = signo asociado a ATOPÍA.

44. Hiperpigmentación periocular

El rascado y la inflamación repetida alrededor de los ojos pueden producir hiperpigmentación postinflamatoria.

Por ello algunos pacientes consultan por “ojeras” persistentes.

La historia de:

asma, rinitis, conjuntivitis o dermatitis atópica

puede orientar hacia el origen atópico.

45. Dermatitis atópica del adulto

En adultos predominan:

- lesiones liquenificadas;
- excoriaciones;
- fisuras;
- xerosis intensa;
- compromiso de flexuras;
- manos;
- pies.

El prurito continúa siendo el síntoma principal.

46. Eritrodermia

Las formas graves pueden llegar a comprometer una proporción muy extensa de la superficie corporal.

La clase menciona eritrodermia cuando existe eritema de más del **80 % de la superficie corporal**.

47. Diagnóstico diferencial de lesiones en manos

Cuando existen placas ecematosas en las manos pueden considerarse:

- dermatitis atópica;
- dermatitis de contacto;
- psoriasis.

La distribución puede ayudar.

La clase señala que la dermatitis de contacto compromete frecuentemente palma y pulpejos, mientras la dermatitis atópica puede observarse en el dorso y otras áreas asociadas.

TEMA 4. DERMATITIS SEBORREICA

48. Concepto general

La dermatitis seborreica es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente que afecta principalmente regiones donde existe abundante actividad sebácea.

Una localización clásica es la **región centrofacial**.

49. Características generales

Suele producir:

- eritema;
- descamación;
- prurito generalmente leve;
- recurrencias.

Muchas personas consultan principalmente por el aspecto estético de las lesiones.

50. Malassezia

La etiología no se considera completamente definida, pero se reconoce la asociación con **Malassezia**, una levadura comensal de la piel.

En determinados pacientes existe aumento de su participación y mayor respuesta inflamatoria.

BADBEAR.MED FIJA:

Dermatitis seborreica NO es una enfermedad contagiosa.

Malassezia forma parte de la flora cutánea; el problema no es “contagiarse del hongo”, sino el desequilibrio y la respuesta inflamatoria del huésped.

51. Factores predisponentes

Entre los factores mencionados se encuentran:

- piel grasa;
 - antecedentes familiares;
 - estrés;
 - cansancio;
 - alteraciones nutricionales;
 - inmunosupresión;
 - infección por VIH;
 - enfermedad de Parkinson;
 - demencia;
 - esquizofrenia;
 - alcoholismo.
-

52. Factores exógenos

También pueden influir:

- ambientes cálidos;

- humedad;
- climas extremos;
- productos faciales oleosos;
- inmunosupresión;
- corticoides;
- jabones agresivos.

53. Clínica

Las lesiones típicas son:

placas eritematosas bien delimitadas

cubiertas por:

escamas blanquecinas o amarillentas.

El aspecto amarillento y algo grasoso es especialmente característico en determinadas localizaciones.

54. Localización en adultos

Las principales regiones son:

- cuero cabelludo;
- línea de implantación del cabello;
- cejas;
- entrecejo;
- surcos nasogenianos;
- región paranasal;
- orejas;
- barba;
- región medioesternal;
- espalda central;
- ombligo;
- región genital.

BADBEAR.MED FIJA:

Dermatitis seborreica = distribución SEBORREICA.

Piensa en:

CUERO CABELLUDO + CEJAS + SURCOS NASOGENIANOS + OREJAS + ESTERNÓN.

55. Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente **clínico**.

Se basa en:

- morfología;
- localización;
- evolución;
- recurrencias.

La biopsia queda reservada para situaciones atípicas o dudosas.

56. Dermatitis seborreica del lactante

En lactantes puede aparecer desde muy temprana edad.

La lesión característica en el cuero cabelludo es la llamada:

costra láctea.

Se presenta como placas:

- blanquecinas;
 - amarillentas;
 - grasosas;
 - adherentes.
-

57. Otras localizaciones en el lactante

También puede comprometer:

- cejas;
- región nasogeniana;
- orejas;
- nuca;
- pliegues cervicales;
- axilas;
- ingles;

- zona del pañal.

58. Diferencia fundamental con dermatitis atópica

Este es uno de los puntos más importantes de toda la clase.

En dermatitis atópica del lactante:

la región nasolabial suele respetarse relativamente.

En dermatitis seborreica:

los surcos nasogenianos se afectan.

BADBEAR.MED FIJA:

LACTANTE CON ECEMA FACIAL

Mejillas rojas + nasolabial respetado → DERMATITIS ATÓPICA.

Surco nasogeniano comprometido + escama amarillenta/grasosa → DERMATITIS SEBORREICA.

59. Dermatitis seborreica del adulto

En el adulto predomina la distribución central:

- cuero cabelludo;
- cejas;
- entrecejo;
- surcos nasogenianos;
- orejas;
- barba;
- pecho;
- espalda.

60. Escamas

Las escamas pueden ser:

- blanquecinas;
- amarillentas;
- relativamente fáciles de desprender.

Esta característica puede ayudar en el diagnóstico diferencial con otras dermatosis escamosas.

61. Diagnóstico diferencial con psoriasis

Cuando existe compromiso del cuero cabelludo debe considerarse psoriasis.

La historia de lesiones en:

- codos;
- rodillas;
- otras áreas típicas

puede ayudar.

La clase señala que las escamas seborreicas suelen desprenderse con mayor facilidad.

62. Estrés y dermatitis seborreica

El estrés psicológico es un desencadenante especialmente importante.

Los pacientes suelen describir:

estrés → exacerbación → mejoría → nuevo brote.

BADBEAR.MED FIJA:

Dermatitis seborreica = enfermedad recurrente muy sensible al ESTRÉS.

TEMA 5. TRATAMIENTO GENERAL DE LAS DERMATITIS

63. Corticoides tópicos

Los corticoides tópicos pueden utilizarse en las tres enfermedades desarrolladas.

La potencia depende de:

- edad;
 - localización;
 - grosor de la piel;
 - gravedad;
 - grado de liquenificación.
-

64. Dermatitis atópica

En lactantes y niños pequeños se mencionan corticoides de baja potencia.

Entre los ejemplos de la clase:

- hidrocortisona;

- desonida;
- prednicarbato.

Cuando las lesiones son más gruesas pueden utilizarse potencias mayores según edad y localización.

65. Dermatitis de contacto

Las manos poseen una piel gruesa, especialmente las palmas.

Por ello pueden necesitarse corticoides tópicos de mayor potencia en lesiones crónicas y liquenificadas.

La clase menciona:

- clobetasol;
 - betametasona;
 - triamcinolona.
-

66. Tratamientos acompañantes

Dependiendo del aspecto de la lesión pueden agregarse productos destinados a mejorar la barrera o disminuir hiperqueratosis.

Se mencionan:

Urea

Por su capacidad hidratante.

Ácido salicílico

Cuando existe descamación o hiperqueratosis importante.

67. Dermatitis seborreica: tratamiento antifúngico

Debido a la participación de *Malassezia* pueden utilizarse antifúngicos.

La clase menciona:

- ketoconazol;
- piroctona olamina;
- ciclopirox.

En situaciones seleccionadas y cuadros severos pueden utilizarse tratamientos sistémicos.

68. Enfermedades crónicas y recurrentes

La dermatitis atópica y la dermatitis seborreica suelen comportarse mediante:

BROTE → CONTROL → BROTE → CONTROL.

No significa necesariamente que el tratamiento haya fracasado.

Forman parte de enfermedades de curso recurrente.

La dermatitis de contacto, en cambio, depende fundamentalmente de la persistencia del contacto con:

- irritante;
- alérgeno.

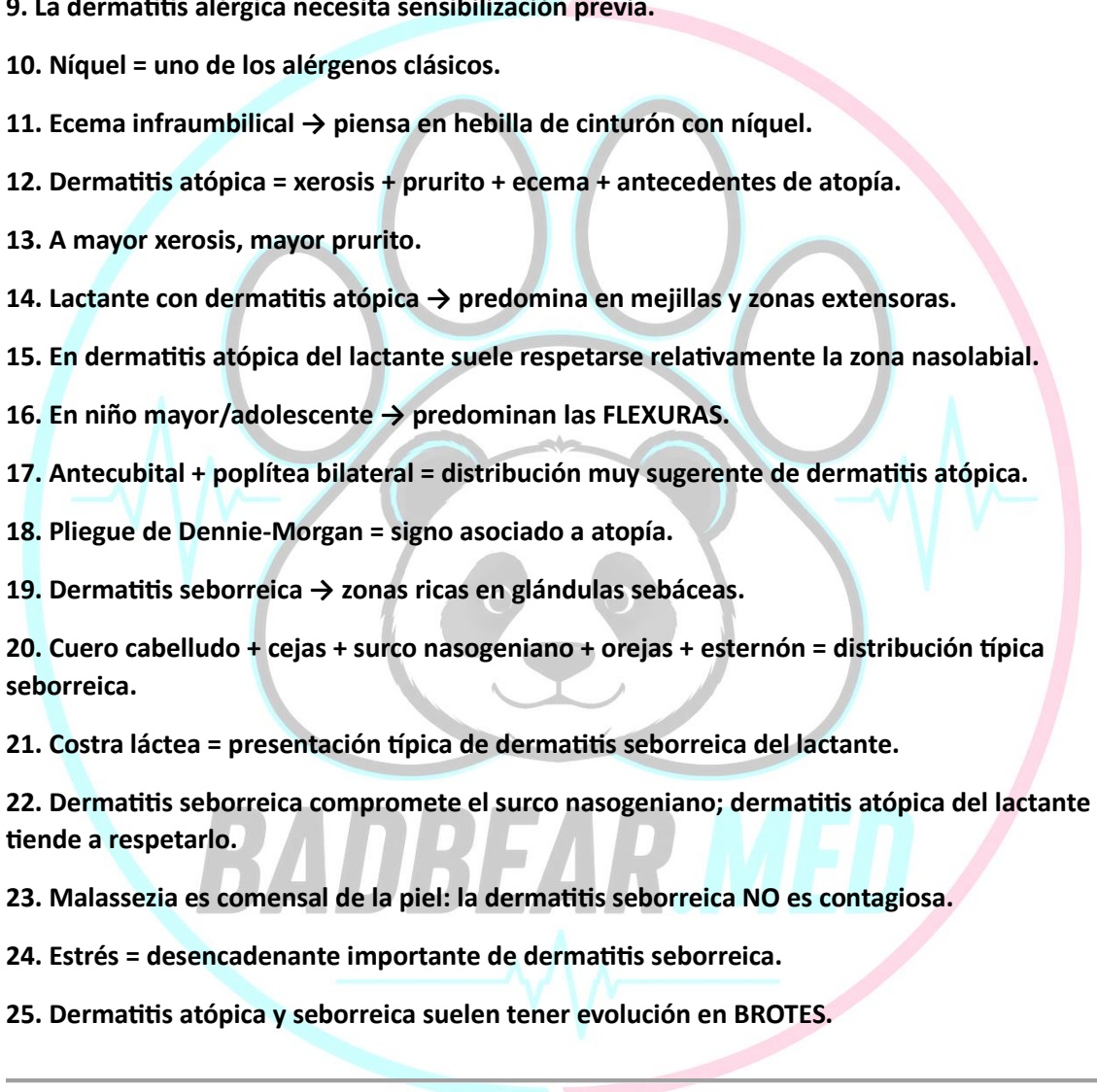
CUADRO COMPARATIVO FINAL

Característica	Contacto irritativa	Contacto alérgica	Atópica	Seborreica
Mecanismo principal	Daño directo	Hipersensibilidad IV	Alteración de barrera + atopía	Inflamatorio + sebo/Malassezia
Sensibilización previa	No	Sí	No aplica	No
Prurito	Variable	Frecuente	Muy importante	Leve-moderado
Dolor/ardor	Puede predominar en aguda	Menos típico	No dominante	Poco frecuente
Xerosis	Puede aparecer	Puede aparecer	Característica	No predominante
Lesión aguda	Vesículas/exudado	Vesículas/exudado	Ecema	Eritema/escama
Lesión crónica	Liquenificación/fisuras	Liquenificación	Liquenificación	Escamas
Distribución	Zona de contacto	Zona del alérgeno	Depende de edad	Zonas seborreicas
Ejemplo clásico	Detergente/lejía	Níquel	Flexuras	Surco nasogeniano
Histología eccematosa	Espongiosis	Espongiosis	Espongiosis	Puede mostrar patrón eccematoso

BADBEAR.MED FIJA — REPASO DE ALTA RENTABILIDAD

1. Ecema = reacción inflamatoria pruriginosa y polimorfa.

2. Ecema agudo = eritema + edema + vesículas + exudado.

- 
3. **Ecema crónico = liquenificación + hiperqueratosis + fisuras + excoiaciones.**
 4. **Histología característica del ecema = ESPONGIOSIS.**
 5. **Liquenificación = consecuencia del rascado crónico.**
 6. **Dermatitis de contacto irritativa = daño directo, no necesita sensibilización.**
 7. **En la dermatitis irritativa aguda puede predominar el dolor o ardor.**
 8. **Dermatitis de contacto alérgica = hipersensibilidad tipo IV.**
 9. **La dermatitis alérgica necesita sensibilización previa.**
 10. **Níquel = uno de los alérgenos clásicos.**
 11. **Ecema infraumbilical → piensa en hebilla de cinturón con níquel.**
 12. **Dermatitis atópica = xerosis + prurito + ecema + antecedentes de atopía.**
 13. **A mayor xerosis, mayor prurito.**
 14. **Lactante con dermatitis atópica → predomina en mejillas y zonas extensoras.**
 15. **En dermatitis atópica del lactante suele respetarse relativamente la zona nasolabial.**
 16. **En niño mayor/adolescente → predominan las FLEXURAS.**
 17. **Antecubital + poplítea bilateral = distribución muy sugerente de dermatitis atópica.**
 18. **Pliegue de Dennie-Morgan = signo asociado a atopía.**
 19. **Dermatitis seborreica → zonas ricas en glándulas sebáceas.**
 20. **Cuero cabelludo + cejas + surco nasogeniano + orejas + esternón = distribución típica seborreica.**
 21. **Costra láctea = presentación típica de dermatitis seborreica del lactante.**
 22. **Dermatitis seborreica compromete el surco nasogeniano; dermatitis atópica del lactante tiende a respetarlo.**
 23. **Malassezia es comensal de la piel: la dermatitis seborreica NO es contagiosa.**
 24. **Estrés = desencadenante importante de dermatitis seborreica.**
 25. **Dermatitis atópica y seborreica suelen tener evolución en BROTES.**

ESQUEMA MENTAL PARA NO CONFUNDIRLAS

Si el paciente tiene un ECEMA:

Primero pregúntate:

¿Hubo contacto con algo?

Sí.

Entonces:

¿El producto es irritante para cualquiera?

→ dermatitis de contacto **IRRITATIVA**.

¿Necesitó sensibilización previa y ahora reacciona al producto?

→ dermatitis de contacto **ALÉRGICA**.

¿Tiene piel muy seca, mucho prurito y antecedentes de asma/rinitis?

→ **DERMATITIS ATÓPICA**.

En lactantes:

mejillas + extensoras + nasolabial respetado.

En niños mayores:

flexuras antecubitales y poplíteas.

¿Tiene eritema y escamas en cuero cabelludo, cejas, nariz u orejas?

→ **DERMATITIS SEBORREICA**.

Busca:

surco nasogeniano afectado + escama blanquecina/amarillenta + relación con estrés.

Ese razonamiento permite diferenciar rápidamente las cuatro grandes presentaciones estudiadas en esta clase.



BADBEAR.MED

Clase 5:

Video original: [Clase 5 Enfermedades Parasitarias de la Piel](#)

Material audiovisual en [Badbear.med](#)

FUENTE 5: ACCIONES CUTÁNEAS PRODUCIDAS POR VIRUS

Lesiones clave que debes reconocer

BADBEAR.MED

HERPES SIMPLE (HSV-1 / HSV-2)

Vesículas agrupadas sobre base eritematosa



- Vesículas agrupadas ("racimo de uvas")
- Pródromo: ardor, dolor, quemazón
- Localización: orolabial (HSV-1), genital (HSV-2)
- Recurrencias frecuentes
- Puede haber transmisión asintomática

HERPES ZÓSTER (VZV)

Vesículas en distribución dermatómica



- Vesículas agrupadas sobre base eritematosa
- Distribución en dermatoma (unilateral)
- Dolor neurítico intenso (antes de las lesiones)
- Más frecuente en adultos mayores
- Complicación: neuralgia posherpética

VERRUGAS (VPH)

Pápulas hiperqueratósicas



- Verruga vulgar (mano)
- Verruga plantar (vasos trombados)
- Verrugas planas (cara)
- Pápulas o placas hiperqueratósicas, rugosas
- Pueden presentar puntos negros (vasos trombados)
- Autoinoculación frecuente (rascado, trauma)
- Diferentes genotipos (ej. 1, 2, 3, 6, 11, 16, 18)
- Mayor riesgo y lesiones extensas en inmunosuprimidos

CONDILOMAS ACUMINADOS

Verrugas genitales por VPH (6 y 11)



- Lesiones exofíticas en "coliflor"
- Localización: genital y perianal
- Transmisión principalmente sexual
- Pueden confluir en placas
- En inmunosuprimidos pueden ser extensos
- Lesiones atípicas, sangrantes o resistentes → biopsia

MOLUSCO CONTAGIOSO

Pápulas perladas umbilicadas (Poxvirus)



- Pápulas perladas, nacaradas, con umbilicación central
- Localización: tronco, extremidades, cara, genitales
- Más frecuente en niños (autolimitado)
- Transmisión por contacto directo
- Numerosas lesiones en inmunosuprimidos (VIH)
- Tratamiento: curetaje, crioterapia, queratolíticos

COMPARA LAS LESIONES



BADBEAR.MED
FIJA:

- Herpes simple = vesículas agrupadas + ardor, recurrencias.
- Herpes zóster = vesículas en dermatoma + dolor intenso.
- VPH = verrugas (pápulas/placas hiperqueratósicas).
- Condiloma acuminado = verruga genital en "coliflor".
- Molusco contagioso = pápula perlada umbilicada.
- Las formas extensas, atípicas o recurrentes deben hacerte pensar en inmunosupresión.

CLASE 5. ENFERMEDADES PARASITARIAS DE LA PIEL

Las parasitosis cutáneas comprenden diferentes enfermedades producidas por artrópodos u otros parásitos capaces de vivir sobre la superficie cutánea o penetrar determinadas estructuras de la piel. En esta clase se mencionan inicialmente varias entidades, como escabiosis, pediculosis, tungiasis y larva migrans; sin embargo, el desarrollo de la sesión se concentra fundamentalmente en **escabiosis y las diferentes formas de pediculosis**.

TEMA 1. ESCABIOSIS

1. Concepto general

La **escabiosis**, también denominada **sarna** o **acarosis**, es una ectoparasitosis cutánea transmisible producida por el ácaro **Sarcoptes scabiei** adaptado al ser humano.

El parásito desarrolla una parte fundamental de su ciclo dentro del **estrato córneo**, donde la hembra forma túneles y deposita sus huevos. La interacción entre el ácaro, sus productos y la respuesta inmunológica del huésped explica las principales manifestaciones clínicas, especialmente el **prurito intenso**.

BADBEAR.MED FIJA:

Escabiosis = *Sarcoptes scabiei* + estrato córneo + prurito intenso, típicamente nocturno.

2. Importancia epidemiológica

La escabiosis presenta distribución mundial.

Su propagación aumenta especialmente en circunstancias que favorecen el contacto estrecho entre personas, como:

- hacinamiento;
- pobreza;
- condiciones sanitarias deficientes;
- refugios;
- aglomeraciones poblacionales;
- convivencia estrecha;
- instituciones donde numerosas personas permanecen juntas.

La enfermedad puede mantenerse de forma endémica en poblaciones vulnerables.

No debe entenderse exclusivamente como una enfermedad relacionada con “falta de higiene”. El elemento epidemiológico fundamental es la **transmisión mediante contacto estrecho con una persona infestada**, aunque determinadas condiciones sociales facilitan claramente su propagación.

3. Reservorio y ciclo

La clase describe un ciclo **monoxénico**, es decir, desarrollado principalmente en el ser humano.

El ser humano funciona como reservorio para la variedad humana del ácaro.

También existen ácaros relacionados con animales; sin embargo, el cuadro humano característico se relaciona con el *Sarcoptes* adaptado al hombre.

4. Mecanismos de transmisión

Existen dos grandes vías.

Transmisión directa

Se produce principalmente por:

contacto piel con piel mantenido.

Puede ocurrir durante:

- convivencia estrecha;
- contacto físico prolongado;
- relaciones sexuales;
- contacto cercano entre miembros de una familia.

Transmisión indirecta

Puede producirse mediante **fómites**, especialmente:

- ropa;
- ropa de cama;
- prendas personales;
- otros objetos que han estado en contacto estrecho con una persona infestada.

La transcripción señala que el ácaro puede permanecer fuera de la piel durante un período de hasta aproximadamente **72 horas**, razón por la cual la ropa tiene importancia epidemiológica.

BADBEAR.MED FIJA:

Escabiosis se transmite principalmente por contacto directo prolongado.

Los fómites cobran especial importancia cuando existe una gran carga parasitaria, como en la sarna costrosa.

5. Período de incubación y aparición del prurito

En una persona que nunca ha estado infestada previamente, el prurito no necesariamente aparece inmediatamente.

La clase señala un período aproximado de varias semanas antes de que se manifiesten los síntomas.

La explicación está relacionada con el tiempo necesario para que el huésped desarrolle la respuesta de hipersensibilidad frente al ácaro y sus productos.

En una **reinfestación**, en cambio, los síntomas pueden aparecer mucho más rápidamente porque el sistema inmunológico ya ha sido previamente sensibilizado.

Esquema

Primera infestación

ácaro



sensibilización inmunológica



semanas



prurito

Reinfestación

memoria inmunológica



respuesta rápida



prurito precoz

BADBEAR.MED FIJA:

Primera escabiosis → prurito puede tardar semanas.

Reinfestación → prurito aparece mucho más rápido.

6. Morfología del parásito

El ácaro presenta **dimorfismo sexual**.

La hembra es de mayor tamaño que el macho.

El cuerpo es:

- redondeado u ovalado;
- no segmentado;
- aplanado dorsoventralmente;
- con cuatro pares de patas en las formas adultas.

Estas características le permiten desplazarse por las estructuras superficiales de la piel y desarrollar los túneles característicos.

7. Ciclo biológico de *Sarcoptes scabiei*

Comprender el ciclo explica varias manifestaciones clínicas y también la necesidad de determinados esquemas terapéuticos repetidos.

Después de la cópula en la superficie cutánea:

1. el macho muere;
2. la hembra penetra el estrato córneo;
3. forma un túnel;
4. deposita huevos mientras avanza;
5. los huevos eclosionan;
6. aparecen larvas;
7. las larvas emergen hacia la superficie;

8. se transforman en ninfas;
9. posteriormente evolucionan hasta adultos.

8. Hembra y formación del surco

La hembra fecundada es la responsable de penetrar el estrato córneo.

Mientras avanza va excavando el denominado:

surco acarino.

Dentro de este trayecto deposita progresivamente sus huevos.

La transcripción menciona una producción aproximada de varios huevos diarios y decenas durante su vida reproductiva.

Por eso el surco no es simplemente una lesión inflamatoria: representa el **trayecto real del ácaro dentro del estrato córneo.**

BADBEAR.MED FIJA:

SURCO ACARINO = túnel excavado por la hembra de Sarcoptes en el estrato córneo.

Es una lesión directamente relacionada con la presencia del parásito.

9. Huevos, larvas y ninfas

Los huevos depositados en el túnel eclosionan.

De ellos emergen **larvas hexápodas**, es decir, formas juveniles con tres pares de patas.

Posteriormente evolucionan hacia **ninfas octópodas**, que presentan cuatro pares de patas, y finalmente se convierten en adultos.

BADBEAR.MED FIJA:

Larva = hexápoda.

Ninfa/adulto = octópodos.

10. Histopatología

La transcripción describe diferentes alteraciones histológicas.

Una de las mencionadas es la **paraqueratosis.**

La paraqueratosis significa:

persistencia de núcleos en células del estrato córneo.

Normalmente las células completamente cornificadas pierden sus núcleos al alcanzar el estrato córneo.

También pueden encontrarse infiltrados inflamatorios y cambios inmunológicos en la piel comprometida.

BADBEAR.MED FIJA:

PARAQUERATOSIS = núcleos retenidos en el estrato córneo.

No confundir con hiperqueratosis, que se refiere al aumento del grosor del estrato córneo.

11. Manifestación cardinal: prurito

El síntoma más importante de la escabiosis es:

PRURITO

Suele ser muy intenso y aumenta especialmente durante la **noche**.

Este patrón nocturno es una de las características que debe hacer sospechar la enfermedad.

BADBEAR.MED FIJA:

PRURITO NOCTURNO INTENSO + familiares con prurito = ESCABIOSIS hasta demostrar lo contrario.

12. ¿Por qué produce tanto prurito?

Una parte importante de las lesiones no se produce simplemente porque el ácaro “muerda” la piel.

Existe una respuesta de **hipersensibilidad** frente a:

- el ácaro;
- sus huevos;
- sus secreciones;
- sus productos.

Esto explica la aparición de numerosas pápulas pruriginosas incluso en lugares donde no necesariamente encontramos físicamente al parásito.

13. Lesiones de la escabiosis

La clase organiza las lesiones en tres grandes categorías:

1. **lesiones directas;**
2. **lesiones indirectas;**
3. **nódulos acarinos.**

Esta clasificación es muy útil para comprender el examen dermatológico.

14. Lesiones directas

Las lesiones directas corresponden a estructuras relacionadas físicamente con el ácaro.

Las dos más importantes desarrolladas son:

- surco acarino;
- vesícula perlada.

15. Surco acarino

Es el trayecto que realiza la hembra dentro del estrato córneo.

Puede observarse como una pequeña línea superficial.

Representa uno de los signos más característicos de la enfermedad.

16. Vesícula perlada

En relación con el extremo de estos trayectos puede observarse una pequeña vesícula brillante.

La transcripción la denomina **vesícula perlada** y la relaciona con el lugar donde puede encontrarse directamente el parásito.

Este punto es particularmente importante para el examen parasitológico.

BADBEAR.MED FIJA:

Si quieres demostrar el ácaro en el examen directo, busca una lesión DIRECTA, especialmente el surco o la vesícula perlada.

No raspes cualquier pápula.

17. Lesiones indirectas

Las lesiones indirectas aparecen como consecuencia de la respuesta de hipersensibilidad del huésped.

Predominan:

- pápulas eritematosas;
- prurito intenso;
- distribución relativamente simétrica.

A diferencia del surco, aquí no necesariamente encontraremos el parásito dentro de cada lesión.

BADBEAR.MED FIJA:

Pápulas pruriginosas de escabiosis = muchas son reacciones de hipersensibilidad, no lugares donde esté físicamente el ácaro.

18. Distribución característica

La clase señala predilección por diferentes pliegues y regiones:

- espacios interdigitales;
- muñecas;
- regiones flexurales;
- región periumbilical;
- región interglútea;
- cara interna de muslos;
- axilas;
- región genital.

Los espacios interdigitales constituyen una zona que debe revisarse siempre.

BADBEAR.MED FIJA:

Ante sospecha de sarna, **mira entre los dedos.**

No basta con observar espalda o abdomen.

19. Nódulos acarinos

Son lesiones sólidas, profundas y pruriginosas.

La clase destaca especialmente su aparición en la región genital:

Varón

- escroto;
- pene.

Mujer

- región genital externa.

También pueden aparecer, con menor frecuencia, en otras localizaciones.

BADBEAR.MED FIJA:

Nódulo genital muy pruriginoso + clínica compatible = pensar en nódulo acarino.

20. Escabiosis del adulto

En el adulto inmunocompetente, la distribución tiende a seguir patrones relativamente característicos.

La clase resalta que determinadas regiones suelen respetarse en comparación con el lactante, mientras los espacios interdigitales, muñecas, pliegues y región genital adquieren mayor importancia.

21. Escabiosis del lactante

En los lactantes el patrón puede ser mucho más extenso.

La afectación puede comprometer prácticamente toda la superficie corporal y presentar numerosas:

- pápulas;
- vesículas;
- pústulas;
- lesiones costrosas.

La clase enfatiza que las regiones normalmente menos afectadas en adultos pueden estar comprometidas en los niños pequeños.

BADBEAR.MED FIJA:

Escabiosis del lactante = distribución mucho más extensa.

No utilices exactamente el patrón del adulto para descartarla.

22. Sobreinfección bacteriana

El prurito intenso produce rascado.

El rascado ocasiona:

excoriación → ruptura de barrera → entrada bacteriana → impetiginización.

Este fenómeno es particularmente frecuente en niños.

Por ello, una escabiosis puede presentarse inicialmente con un aspecto confuso debido a:

- costras;
- exudación;
- pústulas;
- infección bacteriana secundaria.

23. Sarna noruega o escabiosis costrosa

En pacientes con alteraciones importantes de la respuesta inmunológica puede desarrollarse una forma de **superinfestación**.

La clase la denomina **sarna noruega**.

Se caracteriza por:

- enorme carga parasitaria;
- placas hiperqueratósicas;
- enfermedad extensa;
- gran capacidad de transmisión;
- prurito que puede ser escaso o incluso estar ausente.

BADBEAR.MED FIJA:

Sarna costrosa/noruega: MUCHOS ácaros + hiperqueratosis + inmunosupresión.

Y un detalle muy importante:

puede NO presentar el intenso prurito de la escabiosis clásica.

24. ¿Por qué es epidemiológicamente peligrosa la sarna costrosa?

Las placas hiperqueratósicas contienen una enorme cantidad de parásitos.

Al desprenderse escamas, los ácaros pueden contaminar:

- ropa;
- sábanas;
- superficies;
- objetos cercanos.

Por ello la capacidad de contagio es mucho mayor.

25. Diagnóstico clínico

El diagnóstico se basa en dos grandes componentes:

Datos clínicos

- prurito;
- predominio nocturno;
- distribución característica;
- surcos;
- vesículas;

- pápulas;
- nódulos.

Datos epidemiológicos

- otros miembros de la familia con prurito;
- contacto estrecho con infestados;
- brotes en instituciones;
- convivencia con personas sintomáticas.

BADBEAR.MED FIJA:

No estudies escabiosis como una enfermedad de **un solo paciente**.

Muchas veces el diagnóstico aparece cuando preguntas:

“¿Alguien más en su casa tiene picazón?”

26. Examen directo

Cuando existe duda puede realizarse un examen parasitológico directo.

La muestra debe obtenerse de una lesión donde exista probabilidad de encontrar el parásito.

La clase insiste en buscar especialmente:

vesícula perlada / zona asociada al surco.

La muestra se obtiene mediante raspado, se coloca en una lámina y se procesa con **hidróxido de potasio al 10 %** para observación microscópica.

Puede encontrarse:

- ácaro completo;
 - fragmentos;
 - otras estructuras parasitarias.
-

27. Error diagnóstico frecuente

Raspar una pápula secundaria a hipersensibilidad puede dar un resultado negativo porque esa lesión no necesariamente contiene al ácaro.

BADBEAR.MED FIJA:

Examen directo de escabiosis: importa tanto CÓMO tomas la muestra como DÓNDE la tomas.

28. Principios generales del tratamiento

El tratamiento no debe limitarse a “dar una crema”.

Debe considerar:

- edad;
- embarazo;
- inmunosupresión;
- extensión;
- contactos;
- sobreinfección;
- costo;
- posibilidad de reinfestación.

Además, determinados esquemas de fármacos mencionados en la transcripción presentan variaciones y deben entenderse como los **esquemas explicados en clase**, no como sustitutos de una guía terapéutica actual para uso clínico.

29. Permetrina

La clase menciona la **permetrina al 5 %** como uno de los principales tratamientos tópicos de la escabiosis.

Se destaca su utilización en:

- niños pequeños;
- gestantes.

BADBEAR.MED FIJA:

PERMETRINA 5 % = fármaco fundamental en escabiosis.

En la clase se destaca especialmente por su utilidad en **niños y gestantes**.

30. Benzoato de bencilo

La transcripción revisa concentraciones diferentes según edad y describe la necesidad de tratamientos repetidos debido a que no todas las formas evolutivas del parásito responden de la misma manera.

El concepto que interesa comprender es:

un tratamiento puede eliminar formas susceptibles pero dejar otras etapas del ciclo → se necesita una nueva aplicación cuando estas evolucionan.

BADBEAR.MED FIJA:

El motivo de repetir un tratamiento escabídico es **romper el ciclo biológico**, no simplemente “porque la primera dosis fue débil”.

31. Lindano

La transcripción menciona el hexacloruro de gamma-benceno o **lindano** y resalta su potencial **neurotóxico**.

Por esa razón se señala evitarlo en:

- niños pequeños;
- gestantes.

BADBEAR.MED FIJA:

Lindano → recordar NEUROTOXICIDAD.

32. Azufre

La vaselina azufrada constituye una alternativa antigua y de bajo costo.

Su principal inconveniente práctico descrito en la clase es su apariencia y menor aceptabilidad cosmética.

Puede tener utilidad cuando se requiere tratar grupos numerosos con limitaciones económicas.

33. Crotamitón e ivermectina

La clase también menciona:

- crotamitón;
- ivermectina;
- otros antiparasitarios.

Los esquemas exactos descritos en la transcripción son variables, por lo que para el cuaderno es más importante recordar que existen **alternativas tópicas y sistémicas** cuya elección depende del paciente, extensión y situación clínica.

34. Tratamiento de contactos

Este es uno de los puntos más importantes de la escabiosis.

Tratar únicamente al paciente índice **puede fracasar si los** contactos continúan infestados.

Debe investigarse:

- familia;
- convivientes;
- parejas;
- contactos cercanos;

- otros casos en instituciones.

BADBEAR.MED FIJA:

Escabiosis: tratar al paciente sin controlar contactos = alto riesgo de reinfestación.

35. Manejo de ropa y ropa de cama

Deben considerarse:

- ropa personal;
- sábanas;
- toallas;
- ropa de cama.

La clase recomienda lavado, preferentemente con ciclos calientes, y adecuado secado.

Esto cobra especial importancia en casos con gran carga parasitaria.

TEMA 2. PEDICULOSIS

36. Concepto

La pediculosis es una ectoparasitosis producida por piojos.

La clase diferencia tres grandes variedades según su localización:

1. **pediculosis capitis;**
 2. **pediculosis corporis;**
 3. **pediculosis pubis.**
-

37. Diferencia fundamental con Sarcoptes

Existe una diferencia biológica sencilla pero útil:

Sarcoptes

se relaciona con el estrato córneo.

Piojo

es **hematófago**, es decir, se alimenta de sangre.

BADBEAR.MED FIJA:

PIOJO = hematófago.

TEMA 2A. PEDICULOSIS CAPITIS

38. Agente y población afectada

La pediculosis capitis afecta el **cuero cabelludo**.

Puede presentarse en adultos, pero es especialmente frecuente en niños.

39. Transmisión

Puede transmitirse mediante:

Contacto directo

cabeza con cabeza o contacto cercano.

Contacto indirecto

mediante objetos como:

- peines;
 - cepillos;
 - sombreros;
 - artículos personales.
-

40. Manifestación principal

El síntoma predominante es:

PRURITO DEL CUERO CABELLUDO.

Las regiones especialmente señaladas son:

- retroauricular;
- nuca;
- occipital.

BADBEAR.MED FIJA:

Niño con prurito de nuca + retroauricular + occipital → busca LIENDRES.

41. Liendres

Las liendres corresponden a huevos adheridos firmemente al tallo piloso.

No se encuentran simplemente apoyadas sobre el cabello.

Se adhieren mediante una sustancia semejante a un cemento, razón por la cual no se desprenden fácilmente.

42. Diagnóstico clínico

Muchas veces es difícil identificar al piojo adulto porque puede existir un número relativamente pequeño.

Por ello el diagnóstico se realiza frecuentemente mediante la identificación de:

LIENDRES adheridas al cabello.

BADBEAR.MED FIJA:

En pediculosis capitis, muchas veces es más fácil encontrar LIENDRES que piojos adultos.

43. Complicaciones por rascado

El prurito produce rascado continuo.

Esto puede generar:

- excoriaciones;
- costras hemorrágicas;
- placas eccematosas;
- impetiginización;
- infección bacteriana secundaria.

44. Adenopatía occipital

Cuando existe sobreinfección bacteriana del cuero cabelludo puede aparecer reactividad ganglionar, especialmente:

adenopatía occipital.

BADBEAR.MED FIJA:

Niño con impétigo/lesiones costrosas occipitales + adenopatía occipital → revisar pediculosis capitis.

45. Tratamiento

La clase menciona diferentes pediculicidas, incluyendo:

- permetrina;
- malatión;
- benzoato de bencilo;
- lindano;
- piretroides.

De todos ellos, posteriormente se destaca especialmente el uso frecuente de **permetrina**.

46. Eliminación de liendres

Además de eliminar los parásitos vivos, deben retirarse las liendres adheridas.

La clase explica que puede utilizarse un peine fino después de intentar disminuir la adherencia de la sustancia cementante.

El concepto clínico más importante es:

PEDICULICIDA mata al parásito + peinado fino ayuda a retirar liendres.

47. Prevención en escolares

Las medidas preventivas incluyen:

- no compartir peines;
 - no compartir cepillos;
 - no compartir toallas;
 - no compartir sombreros;
 - identificación precoz;
 - tratamiento adecuado;
 - control de otros casos cuando existen brotes.
-

TEMA 2B. PEDICULOSIS CORPORIS

48. Característica fundamental

La pediculosis corporis tiene una particularidad importante:

el piojo suele vivir principalmente en:

costuras y pliegues de la ropa.

Sale hacia la piel para alimentarse de sangre y posteriormente retorna a la ropa.

BADBEAR.MED FIJA:

Pediculosis corporis: BUSCA EL PIOJO EN LA ROPA, especialmente en COSTURAS.

No solamente sobre la piel.

49. Factores epidemiológicos

Puede afectar a cualquier persona, pero se observa con mayor facilidad en situaciones en que existe:

- poco cambio de ropa;
- hacinamiento;
- dificultades de higiene;
- personas sin vivienda estable;
- convivencia estrecha.

50. Distribución

Las lesiones pueden aparecer especialmente en:

- cuello;
- tronco;
- cintura;
- glúteos;
- ingles;
- zonas sometidas a presión de la ropa.

51. Clínica

Las picaduras producen:

- pequeñas pápulas eritematosas;
- prurito intenso;
- excoriaciones.

El rascado repetitivo produce posteriormente cambios secundarios.

52. Melanodermia pediculósica

En infestaciones crónicas y extensas, el rascado persistente y la inflamación pueden generar áreas de pigmentación marrón o bronceada.

La clase denomina este cuadro:

melanodermia pediculósica

o

“enfermedad de los vagabundos”.

BADBEAR.MED FIJA:

Pediculosis corporis crónica → hiperpigmentación bronceada = melanodermia pediculósica.

53. Sobreinfección

Nuevamente aparece el mismo mecanismo:

prurito → rascado → erosión → infección bacteriana.

La enfermedad crónica también puede generar liquenificación.

54. Diagnóstico diferencial

La clase menciona principalmente:

- escabiosis;
 - dermatitis herpetiforme;
 - forunculosis.
-

55. Tratamiento y control ambiental

El tratamiento debe incluir dos elementos:

Paciente

Uso de un pediculicida apropiado.

Ambiente

Desinfección o lavado cuidadoso de:

- ropa;
 - sábanas;
 - cama;
 - prendas en contacto con el paciente.
-

BADBEAR.MED FIJA:

Pediculosis corporis: si solo tratas la piel y no manejas la ROPA, el tratamiento queda incompleto.

TEMA 2C. PEDICULOSIS PUBIS

56. Agente

La pediculosis pubis es producida por **Pthirus pubis**, conocido popularmente como:

ladilla.

Afecta principalmente el vello púbico.

57. Transmisión

La vía más importante señalada es:

contacto sexual.

También puede existir transmisión por fómites, especialmente ropa de cama contaminada.

BADBEAR.MED FIJA:

Pediculosis pubis = pensar en transmisión sexual.

Por eso el manejo no termina en matar al piojo.

58. Prurito genital

La manifestación predominante es:

prurito genital intenso y progresivo.

La infestación puede extenderse a otras regiones con pelo grueso, como:

- abdomen;
 - tórax;
 - axilas.
-

59. Hallazgos en ropa interior

La clase describe pequeños puntos oscuros observados por algunos pacientes en la ropa interior.

Se relacionan con pequeños restos hemorrágicos producidos por los sitios donde el ectoparásito se alimentó de sangre.

60. Hallazgo del parásito

Al examen pueden encontrarse:

- pápulas excoriadas;
- liendres;
- parásitos adheridos cerca de la base del pelo.

Por su color pueden confundirse visualmente con pequeños puntos marrones sobre la región pilosa.

61. Máculas cerúleas

Una lesión clásica descrita son las:

máculas cerúleas.

Son manchas azul-grisáceas relacionadas con pequeños fenómenos hemorrágicos secundarios a la alimentación del parásito.

BADBEAR.MED FIJA:

Pediculosis pubis + máculas azul-grisáceas = MÁCULAS CERÚLEAS.

Perla clásica de examen.

62. Complicaciones

El rascado puede producir:

- excoriaciones;
- impetiginización;
- adenopatías regionales.

63. Tratamiento de la pareja

Debido a su frecuente transmisión sexual, la clase insiste en:

tratamiento simultáneo de la pareja y contactos sexuales relevantes.

BADBEAR.MED FIJA:

Pediculosis pubis: tratar paciente + pareja/contactos sexuales.

64. Compromiso de pestañas

Pthirus pubis puede excepcionalmente alcanzar las pestañas.

Cuando esto ocurre no deben aplicarse indiscriminadamente productos irritantes cerca del ojo.

La clase menciona medidas locales específicas para este compromiso.

La idea que debe retenerse es:

ectoparásito en pestañas = manejo diferente debido al riesgo ocular.

65. Lavado de ropa

También deben lavarse:

- ropa interior;
- sábanas;

- toallas.

La clase recomienda agua caliente para disminuir el riesgo de persistencia y transmisión.

66. Búsqueda de otras infecciones de transmisión sexual

Este es uno de los datos clínicos más importantes de esta sección.

Cuando se diagnostica pediculosis pubis, la transcripción recomienda investigar otras infecciones de transmisión sexual mediante:

- historia clínica;
- examen genital;
- pruebas pertinentes.

Se mencionan particularmente evaluación para **VIH y sífilis** en pacientes con exposición sexual de riesgo.

BADBEAR.MED FIJA:

Pediculosis pubis → evaluar riesgo de OTRAS ITS.

No porque la ladilla produzca VIH o sífilis, sino porque comparten el **contexto epidemiológico de transmisión sexual**.

67. Diagnóstico diferencial de las tres pediculosis

La clase resume algunos diferenciales importantes.

Pediculosis capitis

→ dermatitis seborreica.

Pediculosis corporis

→ escabiosis.

Pediculosis pubis

→ eccema y otras dermatosis genitales.

CUADRO COMPARATIVO: ESCABIOSIS VS PEDICULOSIS

Característica	Escabiosis	Pediculosis
Tipo de parásito	Ácaro	Piojo
Agente principal	<i>Sarcoptes scabiei</i>	<i>Pediculus/Pthirus</i>
Alimentación relevante	Relación con estrato córneo	Sangre

Característica	Escabiosis	Pediculosis
Síntoma principal	Prurito	Prurito
Patrón característico	Nocturno	Depende de localización
Lesión característica	Surco acarino	Liendre/parásito
Transmisión	Contacto estrecho	Contacto/fómites según variedad
Sobreinfección	Frecuente por rascado	Frecuente por rascado
Tratamiento de contactos	Muy importante	Importante
Control de ropa	Importante	Especialmente importante en corporis
Variante grave	Sarna costrosa	—

CUADRO COMPARATIVO DE PEDICULOSIS

Tipo	Sitio principal	Hallazgo clave	Dato importante
Capitis	Cuero cabelludo	Liendres	Nuca/retroauricular
Corporis	Tronco, áreas bajo ropa	Piojo en costuras	Melanodermia crónica
Pubis	Vello púbico	Ladilla/liendres	ITS asociadas
Pestañas	Pestañas	Parásito adherido	Manejo ocular especial

BADBEAR.MED FIJA — REPASO DE ALTA RENTABILIDAD

1. Escabiosis = *Sarcoptes scabiei*.
2. El ácaro habita y excava en el estrato córneo.
3. La hembra fecundada produce el surco acarino.
4. Prurito intenso **NOCTURNO** = dato clásico de escabiosis.
5. Primera infestación → prurito puede tardar semanas.
6. Reinfestación → prurito aparece mucho antes por sensibilización previa.
7. Surco acarino = lesión directa producida por el ácaro.
8. Pápulas pruriginosas = muchas corresponden a reacción de hipersensibilidad.
9. Espacios interdigitales y muñecas son regiones que siempre deben revisarse.
10. Nódulos acarinos pueden localizarse en genitales.
11. Lactantes pueden presentar compromiso cutáneo mucho más extenso que los adultos.
12. Sarna noruega/costrosa = inmunosupresión + enorme carga parasitaria + hiperqueratosis.

13. La sarna costrosa puede presentar poco o ningún prurito.
14. Examen directo: la muestra debe obtenerse de una lesión donde pueda encontrarse el ácaro; no de cualquier pápula.
15. Escabiosis: investigar y manejar contactos para evitar reinfestación.
16. Permetrina 5 % = escabicida fundamental mencionado en la clase.
17. Lindano = recordar riesgo de NEUROTOXICIDAD.
18. Rascado intenso → impetiginización bacteriana secundaria.
19. Pediculosis = ectoparasitosis por piojos hematófagos.
20. Pediculosis capitis: prurito especialmente retroauricular, nuca y occipital.
21. Liendres están firmemente adheridas al tallo piloso.
22. En capitis muchas veces es más fácil diagnosticar por las LIENDRES que por encontrar el adulto.
23. Impetiginización occipital + adenopatía occipital en niño → revisar pediculosis capitis.
24. Pediculosis corporis: el piojo vive principalmente en COSTURAS DE LA ROPA.
25. Pediculosis corporis crónica → melanodermia pediculósica.
26. Pediculosis pubis = Pthirus pubis o "ladilla".
27. Pediculosis pubis se relaciona principalmente con contacto sexual.
28. Máculas cerúleas azul-grisáceas = hallazgo clásico de pediculosis pubis.
29. Pediculosis pubis → tratar a pareja/contactos sexuales.
30. Pediculosis pubis → valorar otras ITS, particularmente cuando existe exposición sexual de riesgo.

RAZONAMIENTO CLÍNICO RÁPIDO

Paciente con prurito intenso

Primero pregúntate:

¿Empeora muchísimo por la noche?

Sí.

¿Tiene pápulas entre los dedos, muñecas, abdomen o genitales?

Sí.

¿Otros familiares también se rascan?

Sí.

→ PIENSA EN ESCABIOSIS.

Niño que se rasca mucho la cabeza

Revisa:

nuca + región retroauricular + occipital.

Después busca estructuras firmemente adheridas al cabello.

→ **LIENDRES = PEDICULOSIS CAPITIS.**

Paciente con prurito en tronco y mala higiene/cambio infrecuente de ropa

Revisa:

costuras y pliegues de la ropa.

→ **PEDICULOSIS CORPORIS.**

Adulto con prurito genital intenso

Busca:

- liendres;
- ladillas adheridas al vello;
- excoriaciones;
- máculas azul-grisáceas.

→ **PEDICULOSIS PUBIS.**

Y luego recuerda:

evaluar pareja/contactos sexuales + riesgo de otras ITS.

IDEA CENTRAL DE TODA LA CLASE

Las parasitosis cutáneas estudiadas aquí producen mucho prurito, pero **el patrón del prurito y la localización permiten diferenciarlas:**

Escabiosis

→ prurito nocturno + surcos + pliegues + convivientes afectados.

Pediculosis capitis

→ cuero cabelludo + nuca/retroauricular + liendres.

Pediculosis corporis

→ tronco + costuras de ropa.

Pediculosis pubis

→ genitales + transmisión sexual + máculas cerúleas.

Y en todas debe recordarse una consecuencia común:

PRURITO → RASCADO → EXCORIACIÓN → SOBREINFECCIÓN BACTERIANA.

Ese mecanismo explica por qué algunas parasitosis terminan consultando no solamente por picazón, sino por costras, exudación, impétigo y adenopatías regionales.

Clase 6:

Video original: [Clase 6 Enfermedades Bacterianas de la Piel](#)

Material audiovisual en [Badbear.med](#)

FUENTE 6: INFECCIONES BACTERIANAS DE LA PIEL
Principales lesiones que debes reconocer

BADBEAR.MED

IMPÉTIGO NO BULLOSO  • Costras "melicéricas" (color miel) • Lesiones superficiales, erosivas • Frecuente en niños • Agente principal: <i>Staphylococcus aureus</i> • Muy contagioso (autoinoculación)	IMPÉTIGO BULLOSO  • Ampollas flácidas con contenido seroso • Se rompen dejando erosiones con collarete • Producido por toxinas de <i>Staphylococcus aureus</i> • Más frecuente en niños • Menos costras que el no bulloso	ECTIMA  • Úlcera profunda con costra gruesa • Afecta epidermis y dermis • Más frecuente en extremidades • Puede dejar cicatriz • Generalmente por <i>Streptococcus pyogenes</i> • Más frecuente en contextos de menor higiene
CELULITIS  • Placa eritematosa, caliente, dolorosa y mal delimitada • Compromete dermis profunda y tejido subcutáneo • Frecuente en extremidades inferiores • Agentes: <i>Streptococcus</i> (más frecuente) • <i>Staphylococcus</i> • Puede acompañarse de fiebre y compromiso general	ERISPELA  • Placa eritematosa, brillante, bien delimitada • Compromete dermis superficial y linfáticos • Frecuente en extremidades inferiores y cara • Agente principal: <i>Streptococcus pyogenes</i> • Puede acompañarse de fiebre y adenopatías regionales	FOLICULITIS  • Pápulas y pústulas centradas en folículos pilosos • Puede ser superficial o profunda • Agente más frecuente: <i>Staphylococcus aureus</i> • Factores de riesgo: fricción, depilación, oclusión • En casos extensos o recurrentes, pensar en portador nasal

BADBEAR.MED FIJA:

- Costra color miel = impétigo.
- Ampolla flácida = impétigo bulloso.
- Úlcera profunda = ectima.
- Placa roja mal delimitada = celulitis.
- Placa roja bien delimitada = erisipela.
- Pústulas en folículos = foliculitis.
- Siempre piensa en el agente más frecuente: *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes*. Evalúa factores de riesgo y contexto del paciente.

CLASE 6. ENFERMEDADES BACTERIANAS DE LA PIEL

Las infecciones bacterianas cutáneas pueden comprometer diferentes niveles de la piel. Algunas permanecen limitadas a la epidermis, otras penetran hacia la dermis y otras se originan alrededor del folículo piloso y progresan hacia tejidos más profundos.

Una manera útil de organizar esta clase es pensar **qué estructura está comprometida y hasta qué profundidad llega la infección**:

Impétigo

→ infección predominantemente superficial.

Ectima

→ infección más profunda, con compromiso dérmico y ulceración.

Foliculitis

→ infección superficial del folículo piloso.

Forúnculo

→ infección profunda de todo el folículo y tejidos vecinos.

Ántrax o carbunco

→ agrupación de varios folículos infectados/forúnculos.

Síndrome de piel escaldada estafilocócica

→ enfermedad mediada por toxinas exfoliativas de *Staphylococcus aureus*.

TEMA 1. IMPÉTIGO

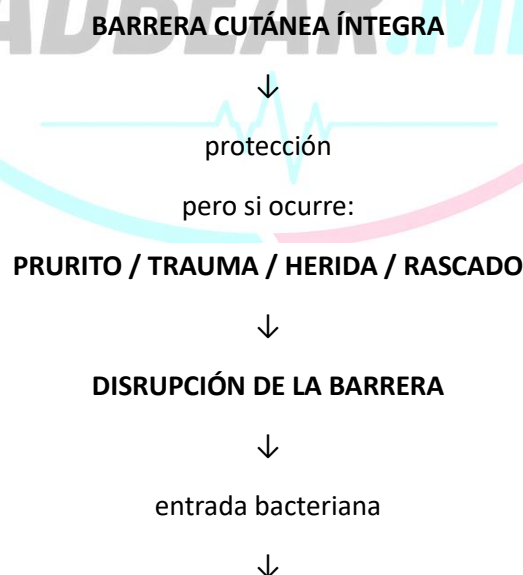
1. Concepto general

El impétigo es una infección bacteriana superficial de la piel que aparece con especial frecuencia en la población pediátrica.

Una característica importante es que muchas veces existe previamente una **alteración de la barrera cutánea**.

La piel normal funciona como una barrera que dificulta el ingreso de microorganismos. Cuando esa barrera se rompe debido a rascado, traumatismo, heridas o dermatosis previas, las bacterias encuentran una puerta de entrada y pueden iniciar el proceso infeccioso.

Por tanto, el razonamiento inicial puede entenderse así:



IMPETIGINIZACIÓN

2. Factores que favorecen el impétigo

La clase menciona diferentes situaciones que facilitan este tipo de infección.

Entre ellas se encuentran:

- dermatitis atópica;
- piel reactiva;
- prurito intenso;
- rascado;
- traumatismos;
- heridas;
- deportes de contacto;
- contacto directo piel con piel;
- colonización abundante por *Staphylococcus aureus*.

3. Dermatitis atópica e impetiginización

Este punto conecta directamente con la clase anterior.

Un paciente con dermatitis atópica presenta:

xerosis + prurito + rascado + alteración de la barrera.

Si el niño se rasca repetidamente, produce pequeñas soluciones de continuidad.

Entonces:

DERMATITIS ATÓPICA



prurito



rascado



excoriaciones



entrada bacteriana



DERMATITIS ATÓPICA IMPETIGINIZADA

BADBEAR.MED FIJA:

Toda dermatosis pruriginosa que produce rascado puede convertirse en una puerta de entrada bacteriana.

Por eso el antecedente de una lesión previa es importante cuando evaluamos un impétigo.

4. Portadores de *Staphylococcus aureus*

Existen pacientes que presentan colonización más abundante por *Staphylococcus aureus*.

La clase señala especialmente regiones como:

- nariz;
- faringe;
- axilas;
- región perineal.

Una mayor colonización puede aumentar el riesgo de desarrollar infecciones cutáneas.

Este concepto será especialmente importante cuando estudiemos posteriormente las **foliculitis y forunculosis recurrentes**.

BADBEAR.MED FIJA:

Infecciones estafilocócicas recurrentes → pensar también en colonización por *S. aureus*.

5. Formas principales de impétigo

La clase diferencia fundamentalmente:

Impétigo no ampollar

También denominado impétigo vulgar.

Impétigo ampollar

Caracterizado por formación de ampollas debido a toxinas exfoliativas.

Aunque pertenecen a la misma familia de infecciones cutáneas, sus mecanismos y presentación clínica presentan diferencias importantes.

6. Impétigo no ampollar

Es la forma que se observa con mayor frecuencia.

Predomina especialmente en niños pequeños, particularmente durante la etapa preescolar.

Suele existir previamente alguna alteración de la superficie cutánea:

- rascado;
- erosión;
- traumatismo;
- heridas;
- otras dermatosis.

7. Lesiones iniciales

Las lesiones pueden comenzar como:

- máculas eritematosas;
- pápulas;
- pequeñas vesículas;
- pústulas.

Estas lesiones tienen una evolución rápida.

El contenido se rompe y posteriormente se seca sobre la superficie.

El resultado es la formación de la lesión clásica del impétigo:

COSTRA MELICÉRICA

8. Costra melicérica

La palabra **melicérica** hace referencia al aspecto semejante a la miel.

Son costras:

- amarillentas;
- doradas;
- de apariencia semejante al color miel.

La clase insiste repetidamente en esta característica porque constituye uno de los hallazgos clínicos más útiles para reconocer el impétigo.

BADBEAR.MED FIJA:

IMPÉTIGO → COSTRA MELICÉRICA COLOR MIEL.

Esta es una de las asociaciones dermatológicas que debes reconocer inmediatamente en una imagen de examen.

9. Evolución de la lesión

Puede pensarse como una secuencia:

ERITEMA



VESÍCULA / PÚSTULA



ruptura



salida de contenido



secado



COSTRA AMARILLENTA MELICÉRICA

En muchas ocasiones el paciente llega cuando la vesícula ya desapareció.
Por ello el médico no necesariamente observará la lesión inicial con líquido.
Lo que encontrará será principalmente la **costra**.

10. Localización del impétigo no ampollar

La distribución característica es **periorificial**.

La clase menciona especialmente:

- alrededor de la nariz;
- alrededor de la boca;
- orejas;
- región perianal.

La distribución alrededor de nariz y boca es particularmente característica en niños.

BADBEAR.MED FIJA:

Niño + lesión perinasal/perioral + costra amarilla color miel = IMPÉTIGO.

11. Autoinoculación

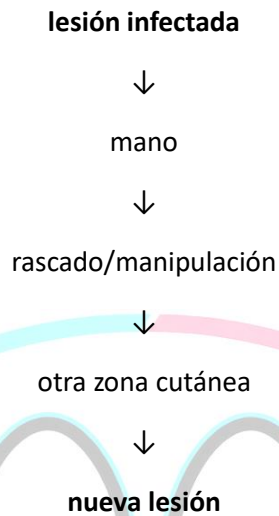
Los niños manipulan las lesiones.

Se rascan.

Después tocan otra zona de la piel.

Así pueden transportar el microorganismo desde una lesión hacia otra región.

El proceso puede representarse:



La clase describe esta capacidad de dispersión por manipulación.

12. Impétigo ampollar

El impétigo ampollar es particularmente importante por su mecanismo fisiopatológico.

A diferencia del impétigo no ampollar, las ampollas pueden aparecer sobre una piel aparentemente intacta.

Se observa especialmente en:

- lactantes;
- neonatos;
- niños pequeños.

13. Mecanismo del impétigo ampollar

La enfermedad está relacionada con toxinas exfoliativas producidas por *Staphylococcus aureus*.

La clase menciona:

toxina exfoliativa A

y

toxina exfoliativa B.

Estas toxinas actúan sobre estructuras que permiten mantener unidos a los queratinocitos.

14. Desmosomas y desmogleína 1

Recordemos lo aprendido en anatomía de la epidermis:

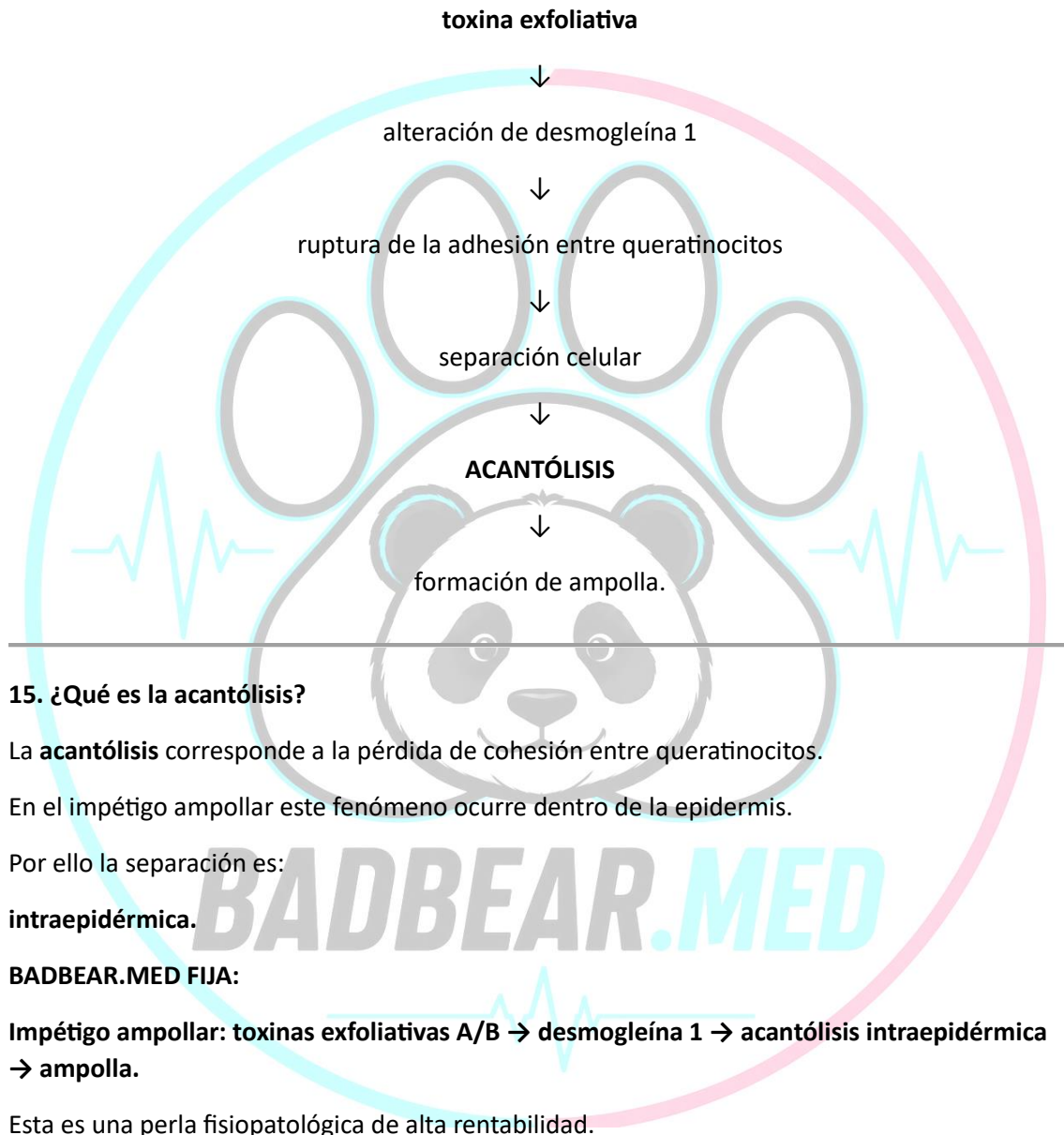
DESMOSOMA = unión queratinocito–queratinocito.

Una proteína importante de estas estructuras es la:

desmogleína 1.

Las toxinas exfoliativas lesionan este sistema de adhesión.

Entonces:



16. Relación con pénfigo

La clase hace una conexión conceptual importante.

En otras enfermedades ampollares, como el pénfigo, también se estudian proteínas de la familia de las desmogleínas.

Por tanto, la desmogleína no debe memorizarse como un dato aislado del impétigo.

Es una estructura fundamental para comprender múltiples enfermedades ampollares.

17. Clínica del impétigo ampollar

Predominan lesiones con contenido líquido de mayor tamaño:

- vesículas grandes;
- ampollas.

Estas lesiones pueden diseminarse rápidamente, especialmente en lactantes y neonatos.

La localización puede incluir regiones:

intertriginosas o de pliegues.

18. No ampollar vs ampollar

Característica	Impétigo no ampollar	Impétigo ampollar
Frecuencia	Más frecuente	Menos frecuente
Edad destacada	Preescolares	Lactantes/neonatos
Lesiones	Vesículas/pústulas pequeñas	Ampollas más grandes
Costra melicérica	Muy característica	Puede aparecer tras ruptura
Localización típica	Periorificial	Pliegues/intertriginoso
Mecanismo tóxico	No es el punto principal desarrollado	Toxinas exfoliativas A/B
Desmogleína 1	—	Comprometida
Acantólisis	—	Sí

BADBEAR.MED FIJA:

Impétigo no ampollar = forma MÁS FRECUENTE.

Impétigo ampollar = lactante/neonato + toxina exfoliativa + desmogleína 1.

19. Estado general

En muchos pacientes el estado general se encuentra relativamente conservado.

Puede existir:

- linfadenopatía;
- antecedente de fiebre;
- diarrea en algunos cuadros descritos.

Sin embargo, la infección permanece habitualmente limitada a la piel.

20. Diagnóstico del impétigo

El diagnóstico es fundamentalmente:

CLÍNICO.

No se necesita rutinariamente:

- biopsia;
- cultivo;
- grandes estudios de laboratorio.

La morfología y la historia clínica suelen ser suficientes.

21. ¿Cuándo considerar estudios adicionales?

La clase plantea estudios cuando:

- no existe respuesta al tratamiento habitual;
- existen manifestaciones atípicas;
- aparece compromiso sistémico;
- existe desnutrición;
- existen comorbilidades importantes.

En estas situaciones puede ser necesario estudiar mejor al paciente.

22. Tratamiento tópico

Cuando el paciente es saludable, tiene pocas lesiones y existe buena posibilidad de cumplir adecuadamente los cuidados, la clase plantea tratamiento tópico.

Menciona:

- mupirocina al 2 %;
- ácido fusídico al 2 %.

Además deben realizarse medidas locales de higiene.

23. Cuidados locales

No basta con colocar un antibiótico.

También se debe:

- limpiar las lesiones;

- mantener higiene adecuada;
- realizar baño regular;
- retirar cuidadosamente las costras;
- evitar productos innecesariamente agresivos.

BADBEAR.MED FIJA:

Impétigo localizado y paciente estable → manejo tópico + higiene local puede ser suficiente.

24. Signos de alarma

En niños pequeños debe explicarse a los familiares que vigilen síntomas como:

- fiebre;
- hiporexia;
- somnolencia;
- deterioro general.

Estos datos obligan a reevaluar si el proceso continúa siendo simplemente una infección cutánea localizada.

25. Glomerulonefritis

La clase menciona que determinadas infecciones relacionadas con *Streptococcus pyogenes* pueden asociarse posteriormente con **glomerulonefritis**.

También enfatiza que administrar antibióticos de forma profiláctica no garantiza prevenir esta complicación.

BADBEAR.MED FIJA:

Impétigo estreptocócico → recordar asociación con glomerulonefritis.

TEMA 2. ECTIMA

26. Concepto

El **ectima** puede entenderse como una infección bacteriana más profunda.

La clase lo presenta como una forma profunda relacionada con el impétigo no ampollar.

La diferencia anatómica fundamental es:

IMPÉTIGO → compromiso predominantemente superficial/epidérmico.

ECTIMA → epidermis + DERMIS.

Al alcanzar la dermis aparece una lesión mucho más profunda:

ÚLCERA.

BADBEAR.MED FIJA:

ECTIMA = infección profunda que forma ÚLCERA.

27. Papel de Streptococcus pyogenes

La clase señala principalmente a:

Streptococcus pyogenes.

También pueden existir lesiones previamente dañadas que posteriormente se infectan.

Entre los antecedentes mencionados se encuentran:

- picaduras de insectos;
 - lesiones por rascado;
 - traumatismos.
-

28. Evolución clínica

La lesión puede comenzar como:

- vesícula;
- pústula.

Después progresa hacia una lesión más profunda.

Se forma una:

costra hemorrágica.

Cuando la costra se retira aparece:

úlceras en sacabocado

con base:

- purulenta;
 - hemática;
 - en ocasiones necrótica.
-

29. Úlcera en sacabocado

La expresión “en sacabocado” indica que la lesión presenta bordes relativamente bien definidos y un defecto profundo, como si se hubiese retirado una pequeña porción de tejido.

Es una forma útil de reconocer el ectima frente al impétigo puramente superficial.

BADBEAR.MED FIJA:

Ectima: costra gruesa/hemorrágica; al retirarla → ÚLCERA EN SACABOCADO con base purulenta.

30. Número y distribución

La clase señala que generalmente no existen grandes cantidades de lesiones.

Predominan especialmente en:

miembros inferiores.

31. Factores predisponentes

Entre los factores asociados se mencionan:

- infancia o juventud;
 - traumatismos;
 - picaduras;
 - linfedema;
 - alteraciones linfáticas;
 - higiene deficiente;
 - inmunosupresión;
 - condiciones sociales desfavorables.
-

32. Sobreinfección

Aunque *Streptococcus pyogenes* ocupa un lugar importante, las lesiones también pueden sobreinfectarse con:

Staphylococcus aureus.

33. Complicaciones

La clase señala que son poco frecuentes:

- síntomas sistémicos importantes;
- bacteriemia;
- celulitis;
- compromiso óseo.

Por tanto, el paciente típico continúa presentando un proceso fundamentalmente cutáneo.

34. Diagnóstico

El diagnóstico del ectima es principalmente clínico.

Puede realizarse cultivo del material purulento cuando sea necesario.

La biopsia puede ser útil si existen diagnósticos alternativos importantes.

35. Diagnóstico diferencial

Entre las entidades señaladas aparecen:

- ectima gangrenoso;
- vasculitis cutánea;
- vasculopatías ulcerativas.

En estos casos la biopsia adquiere mayor importancia.

36. Tratamiento

La decisión entre tratamiento tópico y sistémico depende de:

- número de lesiones;
- estado inmunológico;
- extensión;
- posibilidad de realizar cuidados locales;
- condiciones generales del paciente.

En pacientes incompetentes con pocas lesiones puede utilizarse manejo tópico.

Cuando existen múltiples lesiones, inmunosupresión o malas condiciones para realizar las curaciones, la clase plantea tratamiento sistémico.

37. Antibióticos sistémicos mencionados

La clase menciona:

- cefalexina;
- dicloxacilina.

Pero insiste también en la necesidad de valorar la adherencia al tratamiento y mantener adecuadas medidas de higiene.

IMPÉTIGO VS ECTIMA

Característica	Impétigo	Ectima
Profundidad	Superficial	Más profundo
Epidermis	Sí	Sí
Dermis	No predominante	Sí
Lesión típica	Costra melicérica	Úlcera
Costra	Amarilla/miel	Hemorrágica
Al retirar costra	Erosión superficial	Úlcera en sacabocado
Localización destacada	Periorifical	Extremidades inferiores

BADBEAR.MED FIJA:

IMPÉTIGO = COSTRA.

ECTIMA = ÚLCERA.

Esta diferencia te ayuda mucho en imágenes clínicas.

TEMA 3. FOLICULITIS

38. Concepto

La foliculitis corresponde a una infección predominantemente **superficial del folículo piloso**.

Debe recordarse que el folículo forma parte de la unidad pilosebácea junto con la glándula sebácea.

39. Profundidad

La diferencia fundamental respecto al forúnculo es la profundidad.

Foliculitis

Infección superficial del folículo.

Forúnculo

Infección profunda del folículo y tejidos circundantes.

Ántrax/carbunco

Compromiso de varios folículos profundos.

Esta progresión será una de las claves de toda la clase.

40. Principal microorganismo mencionado

El microorganismo más importante desarrollado en la clase es:

Staphylococcus aureus.

41. Factores predisponentes

La foliculitis se favorece por condiciones que producen:

oclusión + humedad + maceración.

Entre los ejemplos:

- hiperhidrosis;
 - sudoración intensa;
 - productos muy oleosos;
 - cosméticos grasos;
 - ambientes calientes;
 - ambientes húmedos.
-

42. Afeitado y depilación

Uno de los desencadenantes más comunes señalados es el afeitado.

Varones

Predomina en:

- barba;
- bigote;
- cuello.

Mujeres

Puede aparecer especialmente después de depilación o rasurado de:

- miembros inferiores.

El paciente suele describir:

“Cada vez que me afeito o depilo aparecen granitos, me pica y salen pústulas.”

BADBEAR.MED FIJA:

Pústulas centradas en pelo después de afeitar/depilar → pensar en FOLICULITIS.

43. Corticoides y cremas combinadas

El uso indiscriminado de cremas que contienen combinaciones de:

- corticoide;
- antimicótico;
- antibacteriano

puede alterar la piel y predisponer a determinadas infecciones.

La clase llama la atención sobre el uso frecuente de estas cremas polivalentes sin una indicación diagnóstica clara.

44. Otros factores predisponentes

También aparecen:

- dermatitis atópica;
- inmunosupresión;
- diabetes.

La presencia de foliculitis recurrente obliga a investigar si existe algún factor que esté favoreciendo repetidamente la infección.

BADBEAR.MED FIJA:

Foliculitis/forunculosis recurrente → busca factores predisponentes, especialmente diabetes o inmunosupresión.

45. Distribución

Las regiones mencionadas con mayor frecuencia son:

- barba;
- cuero cabelludo;
- tórax;
- espalda;
- axilas;
- glúteos.

46. Lesión elemental

La lesión característica es una:

pústula folicular.

Puede existir además:

- pápula;

- eritema alrededor;
- costra;
- prurito;
- sensibilidad local.

Cuando se observa detenidamente, puede identificarse un pelo en el centro de la lesión.

47. Impétigo de Bockhart

La clase menciona una forma superficial denominada:

impétigo de Bockhart.

Se caracteriza por:

- pústulas pequeñas;
- aproximadamente 1–4 mm;
- pápulas costrosas;
- halo eritematoso;
- tendencia a agruparse;
- curación sin cicatriz.

Se observa especialmente en niños.

48. Sicosis de la barba

También se desarrolla la **sicosis de la barba**, relacionada con foliculitis más profunda y manipulación repetida.

El paciente toca, presiona y manipula las lesiones.

Esto puede aumentar la inflamación y hacer que las lesiones pasen de pequeñas pápulas hacia lesiones más grandes y profundas.

En formas profundas puede producirse:

cicatrización + pérdida permanente del pelo en la región comprometida.

49. Síntomas

La foliculitis superficial puede producir:

- prurito;
- sensibilidad;
- molestia local.

Cuando la infección se profundiza, el síntoma que adquiere mayor importancia es:

DOLOR.

BADBEAR.MED FIJA:

Superficial → prurito/molestia.

Profunda → DOLOR más intenso.

50. Diagnóstico

La foliculitis típica se diagnostica clínicamente.

Sin embargo, pueden solicitarse:

- Gram;
- cultivo;
- KOH;

cuando existen:

- cuadros atípicos;
 - inmunosupresión;
 - recurrencias;
 - ausencia de respuesta;
 - sospecha de etiología diferente.
-

51. Foliculitis por otros microorganismos

La clase recuerda que no todas las foliculitis necesariamente son bacterianas por *S. aureus*.

Se menciona la posibilidad de:

Malassezia

y también otros microorganismos en situaciones particulares.

Esto explica por qué un cuadro que no responde al tratamiento habitual debe ser reevaluado.

52. Diagnósticos diferenciales

Entre ellos:

- acné vulgar;
- rosácea;
- pseudofoliculitis de la barba;

- queratosis pilar;
- hidradenitis supurativa.

53. Tratamiento tópico

Para cuadros superficiales pueden utilizarse medidas locales.

La clase menciona:

- clorhexidina para limpieza;
- mupirocina;
- ácido fusídico;
- clindamicina tópica.

54. Tratamiento sistémico

Cuando las lesiones son:

- numerosas;
- persistentes;
- recurrentes;
- extensas;

puede plantearse tratamiento oral.

La clase menciona especialmente tetraciclinas y doxiciclina.

55. Foliculitis recurrente y diabetes

Este es un punto clínico especialmente importante.

Cuando un paciente presenta cuadros frecuentes de:

- foliculitis;
- forunculosis;

y no mejora adecuadamente, debe investigarse un factor predisponente.

La clase menciona específicamente que en algunos pacientes esto lleva al diagnóstico de **diabetes**, o puede indicar mal control de una diabetes ya conocida.

BADBEAR.MED FIJA:

Forunculosis/foliculitis recurrente → siempre pregunta por DIABETES y otras causas de inmunosupresión.

56. Descolonización

En pacientes con recurrencias frecuentes puede plantearse disminuir la colonización por *Staphylococcus aureus*.

La clase menciona esquemas con:

mupirocina

aplicada en diferentes zonas donde puede existir colonización, como:

- fosas nasales;
- región perianal;
- ombligo;
- otras regiones señaladas.

BADBEAR.MED FIJA:

Infección estafilocócica recurrente → pensar en DESCOLONIZACIÓN, no solamente en tratar cada nuevo brote.

TEMA 4. FORÚNCULO Y FORUNCULOSIS

57. Concepto

El **forúnculo** representa una infección más profunda del folículo piloso.

No se limita a la región superficial.

Compromete:

folículo profundo + tejido blando circundante.

58. De superficial a profundo

Podemos imaginar una progresión:

FOLICULITIS

infección superficial

↓

FORÚNCULO

folículo completo + tejido circundante

↓

CARBUNCO / ÁNTRAX

varios folículos profundos juntos.

BADBEAR.MED FIJA:

Foliculitis = superficial.

Forúnculo = profundo.

Carbunco/ántrax = múltiples forúnculos o folículos profundos comprometidos.

59. Microorganismo

Nuevamente el microorganismo más importante desarrollado es:

Staphylococcus aureus.

60. Clínica del forúnculo

El paciente puede presentar una lesión:

- eritematosa;
- dolorosa;
- caliente;
- inflamatoria;
- pustulosa;
- progresivamente mayor.

Con el paso de los días puede romperse espontáneamente y drenar:

- contenido seropurulento;
- material purulento;
- contenido serohemático.

Después del drenaje la sensación dolorosa puede disminuir.

61. Diferencia con foliculitis superficial

Una diferencia importante es la cicatrización.

La clase establece:

foliculitis superficial → normalmente no deja cicatriz.

forunculosis → puede dejar cicatriz.

ántrax/carbunco → puede dejar cicatriz.

BADBEAR.MED FIJA:

Si la infección folicular es suficientemente profunda para destruir tejido, puede dejar CICATRIZ.

TEMA 5. ÁNTRAX O CARBUNCO

62. Concepto

Cuando varios folículos pilosos y forúnculos vecinos se encuentran comprometidos y confluyen, se forma una lesión mucho más extensa denominada:

ántrax o carbunco.

63. Aspecto clínico

Puede presentarse como una:

- placa;
- masa inflamatoria;
- nódulo eritematoso;
- lesión muy dolorosa;
- lesión con múltiples sitios de supuración.

La profundidad es mayor que en la foliculitis simple.

64. Población afectada

La clase señala una mayor frecuencia de forunculosis en:

- adolescentes;
- adultos jóvenes.

También adquieren especial importancia pacientes con:

- inmunosupresión;
 - condiciones higiénicas deficientes;
 - hacinamiento.
-

65. Concepto de absceso

La clase introduce también el concepto clínico de **absceso**.

Si encontramos una lesión:

- localizada;
- caliente;
- eritematosa;

- muy dolorosa;
- fluctuante;

y al palpar se percibe contenido líquido o semilíquido, debe sospecharse una colección purulenta.

En esa situación:

el drenaje adquiere un papel fundamental.

BADBEAR.MED FIJA:

Lesión FLUCTUANTE + dolor + calor + eritema → pensar en colección/absceso → valorar DRENAJE.

66. Diagnóstico

El diagnóstico de:

- foliculitis;
- forúnculo;
- carbunco;

es fundamentalmente clínico.

En cuadros más importantes pueden solicitarse:

- cultivo;
- tinción de Gram;
- hemograma;
- velocidad de sedimentación;
- PCR.

Esto adquiere especial importancia cuando existe compromiso general o lesiones profundas.

67. Diagnósticos diferenciales

Entre los mencionados:

- quistes;
- acné quístico;
- hidradenitis supurativa/acné inverso.

68. Manejo

La conducta depende de:

- tamaño;
- profundidad;
- número de lesiones;
- localización;
- dolor;
- síntomas generales;
- inmunidad del paciente.

En lesiones profundas puede ser necesario:

incisión + drenaje.

La clase también señala tratamiento sistémico en formas más importantes.

69. Antibióticos mencionados

Dentro de los esquemas comentados aparecen:

- doxiciclina;
- sulfas;
- clindamicina.

La selección depende de las características del paciente y del cuadro clínico.

70. Recurrencias

Cuando los forúnculos aparecen repetidamente no basta con tratar cada lesión individual.

Hay que buscar:

- diabetes;
- inmunosupresión;
- colonización por *S. aureus*;
- factores ambientales;
- condiciones de higiene;
- otros factores predisponentes.

CUADRO COMPARATIVO: INFECCIÓN FOLICULAR

Característica	Foliculitis	Forúnculo	Ántrax/carbunco
Profundidad	Superficial	Profunda	Profunda y múltiple

Folículos	Uno o pequeños grupos superficiales	Un folículo completo	Varios folículos
Dolor	Leve/moderado	Importante	Muy importante
Pústula	Sí	Puede existir	Múltiples sitios de supuración
Tejido vecino	Poco compromiso	Sí	Extenso
Cicatriz	Generalmente no	Puede	Puede
Drenaje	Generalmente no	Puede necesitar	Frecuentemente importante

TEMA 6. SÍNDROME DE PIEL ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA

71. Concepto inicial

La última enfermedad que comienza a desarrollar esta transcripción es el:

SÍNDROME DE PIEL ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA

Es una enfermedad relacionada con toxinas producidas por **Staphylococcus aureus** y aparece principalmente en:

- neonatos;
- lactantes.

72. Mecanismo

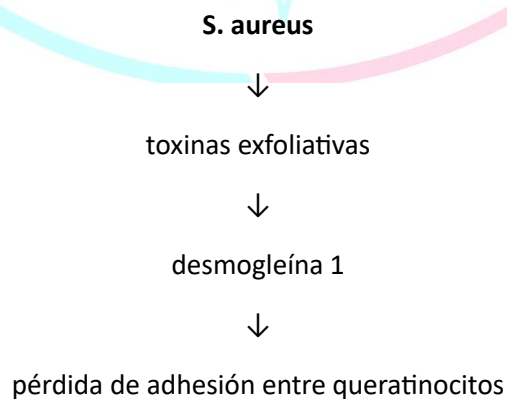
La clase vuelve a mencionar las:

toxinas exfoliativas A y B.

Estas toxinas se relacionan con:

desmogleína 1.

El mecanismo es similar conceptualmente al estudiado en el impétigo ampollar:





formación de ampollas.

73. Diferencia conceptual con impétigo ampollar

La clase introduce una diferencia fisiopatológica importante.

En el síndrome de piel escaldada existe **diseminación hematológica de la toxina**.

Esto significa que la toxina puede originarse en un foco determinado y posteriormente circular sistémicamente, produciendo lesiones cutáneas a distancia.

BADBEAR.MED FIJA:

Impétigo ampollar y síndrome de piel escaldada comparten:

S. aureus + toxinas exfoliativas A/B + desmogleína 1.

Pero en el síndrome de piel escaldada:

la TOXINA se disemina hematógicamente.

74. Factores de riesgo mencionados

La clase destaca particularmente:

- neonatalidad;
- lactancia;
- prematuridad;
- comorbilidades;
- condiciones del nacimiento.

75. Clínica inicial

El cuadro puede comenzar con:

- irritabilidad;
- fiebre;
- hipersensibilidad cutánea;
- eritema.

También pueden coexistir otros focos de infección como manifestaciones respiratorias u oculares descritas durante la clase.

76. Ampollas

Posteriormente aparecen:

ampollas flácidas, particularmente en:

- pliegues;
- regiones intertriginosas.

Nuevamente la explicación está relacionada con la pérdida de adhesión de los queratinocitos por acción de las toxinas exfoliativas.

77. Importancia de la detección precoz

A diferencia de muchas infecciones bacterianas superficiales, este cuadro puede asociarse con mayor compromiso general.

La clase señala la necesidad de reconocerlo rápidamente debido al riesgo de complicaciones sistémicas.

BADBEAR.MED FIJA:

Neonato/lactante + fiebre + eritema generalizado/hipersensibilidad + ampollas flácidas → pensar en síndrome de piel escaldada estafilocócica.

78. Importante sobre esta sección

La transcripción termina exactamente cuando comienza a explicar la evolución clínica posterior al eritema, alrededor de las primeras 48 horas.

Por ello, en este resumen dejamos el síndrome de piel escaldada hasta el punto realmente desarrollado en la clase:

- población afectada;
- diseminación de toxinas;
- toxinas A/B;
- desmogleína 1;
- formación de ampollas;
- eritema;
- fiebre;
- irritabilidad;
- necesidad de diagnóstico rápido.

No añadimos tratamiento ni evolución posterior porque esa parte no aparece en este archivo.

CUADRO MAESTRO DE PROFUNDIDAD DE LAS INFECCIONES

Enfermedad	Estructura principalmente comprometida	Lesión que debes recordar
Impétigo	Epidermis/superficial	Costra melicérica
Impétigo ampollar	Intraepidérmico	Ampolla
Ectima	Epidermis + dermis	Úlcera en sacabocado
Foliculitis	Folículo superficial	Pústula folicular
Forúnculo	Folículo profundo + tejido vecino	Nódulo doloroso
Ántrax/carbunco	Varios folículos profundos	Placa/nódulo supurativo
Piel escaldada estafilocócica	Separación epidérmica mediada por toxinas	Ampollas flácidas extensas

BADBEAR.MED FIJA — REPASO DE ALTA RENTABILIDAD

1. La alteración de la barrera cutánea facilita las infecciones bacterianas.
2. Dermatitis atópica + rascado → alto riesgo de impetiginización.
3. Staphylococcus aureus puede colonizar nariz, faringe, axilas y región perineal.
4. Impétigo no ampollar = forma más frecuente.
5. Costra MELICÉRICA color miel = hallazgo clásico del impétigo.
6. Impétigo no ampollar → distribución frecuentemente perinasal/perioral.
7. Impétigo ampollar → lactantes/neonatos.
8. Impétigo ampollar → toxinas exfoliativas A/B.
9. Toxinas exfoliativas → desmogleína 1 → pérdida de adhesión → acantólisis.
10. La separación del impétigo ampollar es intraepidérmica.
11. Diagnóstico de impétigo = fundamentalmente CLÍNICO.
12. Pocas lesiones en paciente estable → puede bastar tratamiento tópico + higiene local.
13. Impétigo relacionado con Streptococcus pyogenes → recordar glomerulonefritis.
14. Ectima = infección más profunda que alcanza DERMIS.
15. Ectima → costra hemorrágica que al retirarse deja ÚLCERA EN SACABOCADO.
16. Ectima se localiza frecuentemente en miembros inferiores.
17. Foliculitis = infección SUPERFICIAL del folículo piloso.
18. Pústula centrada en un pelo = pensar en foliculitis.
19. Afeitado, depilación, sudor, maceración y oclusión favorecen foliculitis.

20. Foliculitis recurrente → investigar diabetes/inmunosupresión.
21. Forúnculo = infección PROFUNDA del folículo + tejido circundante.
22. Carbunco/ántrax = compromiso de VARIOS folículos profundos.
23. Foliculitis superficial normalmente no deja cicatriz; forúnculos y carbuncos sí pueden hacerlo.
24. Dolor + calor + eritema + FLUCTUACIÓN → pensar en absceso.
25. Absceso con colección purulenta → valorar drenaje.
26. Infecciones estafilocócicas recurrentes → considerar colonización/descolonización.
27. Síndrome de piel escaldada → principalmente neonatos y lactantes.
28. Síndrome de piel escaldada = *S. aureus* + toxinas exfoliativas A/B + desmogleína 1.
29. En piel escaldada, la toxina se disemina por vía hematógena.
30. Lactante con fiebre, irritabilidad, piel eritematosa hipersensible y ampollas flácidas → pensar en síndrome de piel escaldada estafilocócica.

ESQUEMA PARA RESOLVER CASOS DE EXAMEN

Niño con costras amarillas alrededor de nariz y boca

Piensa:

COSTRA MELICÉRICA

↓

IMPÉTIGO NO AMPOLLAR.

Neonato con ampollas

Pregunta:

¿Son ampollas relacionadas con toxina exfoliativa?

↓

desmogleína 1

↓

piensa en:

IMPÉTIGO AMPOLLAR

o, si existe cuadro extenso/sistémico,

SÍNDROME DE PIEL ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA.

Paciente con costra hemorrágica en pierna

Retiras la costra y encuentras:

úlceras profundas en sacabocado + base purulenta



ECTIMA.

Paciente con pequeñas pústulas centradas en pelos



FOLICULITIS.

Si aparece después de afeitarse:



todavía más sugerente.

Lesión folicular grande, profunda y dolorosa



FORÚNCULO.

Varias lesiones profundas confluyen y forman una gran masa supurativa



ÁNTRAX / CARBUNCO.

IDEA CENTRAL DE ESTA CLASE

Para comprender las infecciones bacterianas cutáneas no memorices únicamente los nombres.

Pregúntate siempre:

¿QUÉ TAN PROFUNDA ES LA INFECCIÓN?

Superficie epidérmica

→ impétigo.

Dermis ulcerada

→ ectima.

Folículo superficial

→ foliculitis.

Folículo profundo

→ forúnculo.

Varios folículos profundos

→ carbunco.

Y si existen **ampollas por toxinas exfoliativas**, recuerda inmediatamente:

Staphylococcus aureus → **toxinas A/B** → **desmogleína 1** → **pérdida de cohesión entre queratinocitos**.

Clase 7:

Video original: [Enfermedades Virales de la Piel](#)

Material audiovisual en [Badbear.med](#)

CLASE 7. ENFERMEDADES VIRALES DE LA PIEL

1. Introducción

Las infecciones virales cutáneas presentan comportamientos muy diferentes dependiendo del virus responsable. Algunas producen cuadros agudos y autolimitados, mientras que otras tienen la capacidad de permanecer dentro del organismo y reactivarse posteriormente.

Este último comportamiento es particularmente importante en los virus de la familia **Herpesviridae**.

Una vez que determinados herpesvirus infectan al individuo, pueden permanecer en un estado de **latencia** durante años. Bajo determinadas circunstancias vuelven a activarse, generando nuevamente síntomas y lesiones cutáneas.

Por ello, para comprender adecuadamente estas enfermedades debemos diferenciar tres conceptos:

primoinfección

↓

primer contacto del organismo con el virus

latencia

↓

virus permanece sin producir manifestaciones clínicas evidentes

reactivación

↓

el virus vuelve a replicarse y reaparecen síntomas y lesiones.

BADBEAR.MED FIJA:

HERPES = PRIMOINFECCIÓN → LATENCIA → REACTIVACIÓN.

No debes pensar en el herpes como una infección que necesariamente desaparece por completo después del primer episodio.

TEMA 1. FAMILIA HERPESVIRIDAE

2. Clasificación general

La clase divide los herpesvirus humanos en tres grandes grupos:

Alfaherpesvirus

Incluyen los virus herpes más frecuentemente relacionados con las enfermedades dermatológicas desarrolladas en esta clase:

- herpes simple tipo 1;
- herpes simple tipo 2;
- virus varicela-zóster.

Betaherpesvirus

Se mencionan:

- citomegalovirus;
- herpesvirus 6;
- herpesvirus 7.

Gammaherpesvirus

Se mencionan principalmente:

- virus de Epstein-Barr;
- herpesvirus humano tipo 8, asociado al sarcoma de Kaposi.

La importancia práctica de esta clasificación radica en comprender que todos pertenecen a una misma gran familia, pero presentan tropismos y enfermedades diferentes.

3. Latencia de los herpesvirus

Una característica esencial de esta familia es la capacidad de permanecer latente.

Para los virus herpes simple y varicela-zóster, la clase destaca especialmente la persistencia en estructuras relacionadas con los **nervios sensitivos**.

En términos generales:

piel/mucosa



entrada del virus



replicación



migración por estructuras nerviosas



ganglio sensitivo



LATENCIA



factor desencadenante



reactivación



migración hacia periferia



nueva lesión cutánea.

4. Patogenia de la infección herpética

Después de la primoinfección, el virus ingresa a través de:

- piel;
- mucosas.

Se replica inicialmente y posteriormente migra hacia estructuras ganglionares.

En relación con los nervios sensitivos, el virus puede desplazarse siguiendo el axón hasta alcanzar ganglios relacionados con las raíces dorsales, donde permanece en estado de latencia.

Posteriormente, cuando ocurre una reactivación, reaparecen:

- pródromos;
- dolor;
- alteraciones sensitivas;
- lesiones cutáneas.

Una vez que el episodio clínico se resuelve, el virus vuelve al estado latente.

BADBEAR.MED FIJA:

Herpesvirus neurotrópicos: la lesión de piel es solo una parte del proceso; la latencia ocurre en estructuras nerviosas sensitivas.

Esto explica por qué pueden existir **recurrencias en regiones similares.**

5. Factores desencadenantes de reactivación

La clase menciona múltiples factores capaces de favorecer una reactivación:

- trauma físico;
- estrés emocional;
- inmunosupresión;
- enfermedades sistémicas;
- medicamentos inmunosupresores;
- exposición solar;
- calor;
- radiación ultravioleta;
- fiebre;
- radioterapia;
- procedimientos con láser;
- menstruación en algunas mujeres.

Uno de los factores especialmente importantes es la:

INMUNOSUPRESIÓN.

Los pacientes inmunosuprimidos pueden presentar:

- episodios más frecuentes;
- enfermedad más extensa;
- mayor duración;
- mayor intensidad clínica.

BADBEAR.MED FIJA:

Herpes recurrente, extenso, prolongado o atípico → piensa en inmunosupresión.

TEMA 2. HERPES SIMPLE

6. Virus herpes simple tipo 1 y tipo 2

Tradicionalmente se relaciona:

HSV-1

con enfermedad principalmente **orolabial**.

HSV-2

con enfermedad principalmente **genital**.

Sin embargo, la clase insiste en que esta separación no es absoluta.

HSV-1 puede encontrarse en lesiones genitales y HSV-2 puede encontrarse en localizaciones orales, debido a cambios en los patrones de contacto y comportamiento sexual.

BADBEAR.MED FIJA:

HSV-1 ≠ exclusivamente oral.

HSV-2 ≠ exclusivamente genital.

La localización orienta, pero no identifica por sí sola el tipo viral.

7. Transmisión

Para HSV-1 se destaca principalmente el contacto directo con:

- saliva;
- secreciones;
- lesiones infectadas.

Para HSV-2 se resalta la transmisión relacionada con:

- actividad sexual;
- contacto genital;
- número de parejas sexuales.

8. Transmisión asintomática

Un concepto muy importante es que la persona no necesariamente necesita presentar vesículas visibles para transmitir el virus.

Puede existir:

excreción viral asintomática.

Es decir, el virus puede encontrarse presente y transmitirse incluso en ausencia de lesiones clínicas evidentes.

BADBEAR.MED FIJA:

Ausencia de vesículas NO significa ausencia absoluta de capacidad de transmisión del herpes simple.

9. Lesión elemental característica

La lesión que debe asociarse inmediatamente con herpes simple es:

VESÍCULA.

Pero no suele presentarse como una vesícula aislada.

La imagen típica corresponde a:

múltiples vesículas agrupadas sobre una base eritematosa.

La clase utiliza la descripción clásica:

“RACIMO DE UVAS”.

BADBEAR.MED FIJA:

HERPES SIMPLE = VESÍCULAS AGRUPADAS sobre BASE ERITEMATOSA.

Piensa visualmente en un:

RACIMO DE UVAS.

10. Pródromos

Antes de que aparezcan las vesículas puede existir una fase prodrómica.

La clase menciona:

- malestar general;
- hiporexia o anorexia;
- fiebre o sensación de alza térmica;
- adenopatías;
- aumento de sensibilidad cutánea;
- ardor;
- quemazón;
- dolor urente.

Esta fase es clínicamente muy útil.

El paciente puede decir:

“Antes de que salieran las ampollitas, comenzó a arderme.”

Ese antecedente orienta mucho al diagnóstico.

11. Evolución de la lesión herpética

La secuencia puede organizarse así:

PRÓDROMO

ardor / dolor / hipersensibilidad



MÁCULA ERITEMATOSA



VESÍCULAS AGRUPADAS



ruptura



EROSIONES / ÚLCERAS SUPERFICIALES



costras



resolución.

12. Primoinfección vs recurrencia

La **primoinfección** suele ser más intensa.

Puede presentar:

- mayor dolor;
- síntomas generales;
- adenopatías;
- lesiones más numerosas;
- compromiso mucoso;
- mayor duración.

Las recurrencias suelen ser:

- más localizadas;
- menos sintomáticas;
- más cortas.

BADBEAR.MED FIJA:

Primer episodio de herpes = generalmente MÁS APARATOSO.

Recurrencias = generalmente MÁS CORTAS y MENOS SINTOMÁTICAS.

TEMA 2A. HERPES OROLABIAL

13. Localización

Las lesiones relacionadas principalmente con HSV-1 se localizan con frecuencia en:

- labios;
- boca;
- región facial;
- mucosa oral.

En recurrencias adquiere especial importancia el:

bermellón del labio.

14. Primoinfección orolabial

La primoinfección puede comprometer:

- encías;
- mucosa oral;
- labios;
- lengua;
- región faríngea.

En algunos pacientes puede acompañarse de:

- fiebre;
- dolor faríngeo;
- adenopatías.

15. Recurrencia labial

Después de quedar latente, el virus puede reactivarse.

Las recurrencias suelen localizarse principalmente alrededor del labio.

El paciente frecuentemente reconoce su propio patrón:

“Primero comienza a arderme o picarme; después aparecen las vesículas.”

Este pródromo puede anteceder pocas horas o días a las lesiones.

16. Factores relacionados con herpes labial recurrente

La clase enfatiza:

- exposición solar;

- calor;
- fiebre;
- estrés;
- procedimientos sobre la piel.

Por ello algunos pacientes presentan episodios recurrentes especialmente durante el verano.

TEMA 2B. HERPES GENITAL

17. Concepto

El herpes genital se relaciona principalmente con HSV-2, aunque HSV-1 también puede producir enfermedad genital.

La transmisión se encuentra estrechamente relacionada con el contacto sexual.

18. Clínica de primoinfección genital

Puede ser un cuadro muy doloroso.

La clase describe:

- dolor punzante;
- dolor lancinante;
- eritema;
- edema;
- aumento de volumen;
- vesículas;
- erosiones;
- úlceras;
- adenopatías;
- fiebre;
- mialgias;
- malestar general.

19. Herpes genital en mujeres

Puede existir edema marcado de:

- labios mayores;

- labios menores.

Las vesículas pueden romperse rápidamente, por lo que cuando la paciente llega a consulta quizá ya no se observen vesículas.

Lo que puede encontrarse son:

- erosiones;
- ulceraciones;
- maceración;
- dolor intenso.

BADBEAR.MED FIJA:

En herpes genital NO siempre verás vesículas.

Si ya se rompieron puedes encontrar:

EROSIONES o ÚLCERAS MUY DOLOROSAS.

La anamnesis del pródromo resulta fundamental.

20. Herpes simple vs impétigo alrededor de la boca

Esta comparación conecta la clase viral con la clase bacteriana anterior.

Herpes simple

- vesículas agrupadas;
- base eritematosa;
- distribución localizada;
- ardor/dolor previo.

Impétigo

- costras melicéricas;
- puede existir autoinoculación;
- lesiones pueden aparecer en diferentes zonas.

La clase enfatiza la importancia de preguntar **qué ocurrió antes de las lesiones.**

BADBEAR.MED FIJA:

Costra perioral no significa automáticamente impétigo.

Pregunta:

¿Antes hubo ardor/dolor y vesículas agrupadas?

Si sí → pensar en **herpes simple**.

21. Inmunosupresión y herpes simple

En pacientes inmunosuprimidos el cuadro puede ser:

- más intenso;
- más extenso;
- más prolongado;
- más doloroso;
- más susceptible a **sobreinfección**.

La clase menciona como ejemplos:

- VIH;
- diabetes;
- cirrosis;
- insuficiencia renal;
- enfermedades oncológicas.

22. Diagnóstico

El diagnóstico típico es principalmente:

CLÍNICO.

La combinación de:

pródromo + dolor/ardor + vesículas agrupadas sobre base eritematosa

suele orientar fuertemente.

23. Estudios mencionados en la clase

En situaciones atípicas, la clase menciona:

- anticuerpos IgM;
- anticuerpos IgG;
- PCR en contextos específicos;
- estudio del líquido cefalorraquídeo cuando existe compromiso neurológico.

También menciona la:

tinción de Tzanck.

24. Tinción de Tzanck

Se obtiene una muestra desde una vesícula.

Al microscopio pueden encontrarse:

células gigantes multinucleadas.

BADBEAR.MED FIJA:

Herpes + Tzanck → células gigantes multinucleadas.

25. Histopatología

En cuadros diseminados o atípicos, especialmente en inmunosuprimidos, puede realizarse biopsia.

La clase menciona:

- balonización de queratinocitos;
 - cuerpos de inclusión intracelulares;
 - compromiso intraepidérmico.
-

26. Tratamiento del herpes simple

La clase diferencia entre:

- primoinfección;
- recurrencias;
- enfermedad grave;
- compromiso neurológico;
- recurrencias muy frecuentes.

Se mencionan principalmente:

aciclovir

y

valaciclovir.

La recomendación conceptual más importante es iniciar el antiviral **lo más precozmente posible**, idealmente cerca de la aparición de las lesiones.

BADBEAR.MED FIJA:

En herpes, el tratamiento antiviral funciona mejor cuando se inicia precozmente.

27. Esquemas mencionados en clase

La transcripción menciona diferentes esquemas de aciclovir según localización, primoinfección o recurrencia.

Para el cuaderno conviene conservar el concepto terapéutico principal:

- aciclovir/valaciclovir;
- inicio temprano;
- mayor intensidad terapéutica en primoinfección o inmunosupresión;
- vía intravenosa en determinados cuadros graves o neurológicos.

Los esquemas exactos de dosis deben revisarse con la guía terapéutica utilizada en el curso antes de emplearlos clínicamente.

28. Tratamiento supresor

La clase plantea terapia supresora cuando existen recurrencias muy frecuentes, utilizando como referencia aproximadamente:

≥6 episodios al año.

BADBEAR.MED FIJA:

Herpes muy recurrente → considerar tratamiento SUPRESOR, no limitarse a tratar cada brote.

TEMA 3. HERPES ZÓSTER

29. Relación con varicela

El herpes zóster y la varicela son producidos por el mismo virus:

VIRUS VARICELA-ZÓSTER.

La primera infección produce:

VARICELA.

Después el virus permanece latente.

La reactivación produce:

HERPES ZÓSTER.

BADBEAR.MED FIJA:

Primoinfección por VZV = VARICELA.

Reactivación de VZV = HERPES ZÓSTER.

30. Latencia

Después de la varicela, el virus permanece en los:

ganglios sensitivos relacionados con raíces dorsales.

Cuando se reactiva, vuelve a desplazarse por el nervio correspondiente.

31. Dermatóma

El virus se desplaza siguiendo un nervio sensitivo.

La región cutánea inervada por ese segmento nervioso corresponde a un:

DERMATOMA.

Por ello las lesiones del herpes zóster adoptan una distribución característica, siguiendo el trayecto del nervio.

32. Dermatóma más frecuente señalado

La clase destaca especialmente el compromiso:

TORÁCICO.

Esto explica el aspecto clásico en forma de banda alrededor del tronco.

33. Pródromo doloroso

Una de las características más importantes del herpes zóster es que el dolor suele aparecer **antes de las lesiones.**

Puede sentirse como:

- ardor;
- quemazón;
- dolor lancinante;
- hipersensibilidad;
- dolor intenso incluso con el roce de la ropa.

BADBEAR.MED FIJA:

DOLOR NEURÍTICO INTENSO que precede a vesículas en un dermatoma = piensa en HERPES ZÓSTER.

34. Erupción cutánea

Después del prodromo aparecen:

- vesículas;

- ampollas;
 - agrupadas;
 - sobre base eritematosa;
 - siguiendo el dermatoma afectado.
-

35. Distribución

Puede aparecer en:

- tronco;
- cara;
- cuello;
- cuero cabelludo;
- extremidades.

Pero independientemente del lugar, la clave es observar el **trayecto dermatómico**.

36. Relación con línea media

El herpes zóster típico permanece localizado en el territorio correspondiente.

La clase utiliza como referencia la línea media para reconocer enfermedad localizada frente a formas diseminadas.

BADBEAR.MED FIJA:

Herpes zóster clásico = patrón DERMATÓMICO.

Si hay múltiples vesículas ampliamente fuera del dermatoma, piensa en forma **diseminada**.

37. Herpes zóster en inmunosuprimidos

En pacientes inmunocompetentes suele presentar evolución más favorable.

En inmunosuprimidos puede aparecer:

- mayor cantidad de lesiones;
- ampollas grandes;
- erosiones;
- úlceras;
- cicatrices;
- enfermedad más extensa;

- mayor dolor.

38. Herpes zóster diseminado

La clase establece como criterio práctico:

más de 20 vesículas fuera del dermatoma primario.

Y relaciona esta forma especialmente con pacientes inmunosuprimidos.

BADBEAR.MED FIJA:

>20 vesículas fuera del dermatoma inicial → HERPES ZÓSTER DISEMINADO, según el criterio utilizado en esta clase.

39. Complicación más importante desarrollada: neuralgia posherpética

La clase señala como complicación más frecuente:

NEURALGIA POSHERPÉTICA.

Se produce porque el compromiso inflamatorio del nervio puede persistir incluso después de que las lesiones cutáneas desaparecen.

40. ¿Qué siente el paciente con neuralgia posherpética?

Puede existir:

- dolor;
- quemazón;
- ardor;
- hipersensibilidad;
- dolor con estímulos mínimos;
- dolor persistente después de que las vesículas se han convertido en costras.

En pacientes mayores puede ser muy incapacitante.

La discusión final de la clase vuelve a insistir en que una de las razones para tratar el herpes zóster es intentar reducir el problema del dolor persistente.

BADBEAR.MED FIJA:

Herpes zóster: LA PIEL PUEDE CURAR ANTES QUE EL NERVI.

Si las costras desaparecieron pero el dolor continúa:

→ pensar en **neuralgia posherpética**.

41. Edad e inmunosenescencia

La enfermedad se observa con frecuencia en adultos mayores.

La clase relaciona este fenómeno con la:

inmunosenescencia, es decir, disminución progresiva de la eficiencia inmunológica asociada con la edad.

42. Herpes zóster facial

El compromiso facial requiere especial atención porque pueden verse afectadas estructuras relacionadas con:

- ojos;
- oídos;
- nervios craneales.

La clase también menciona complicaciones neurológicas y sistémicas en cuadros graves.

43. Cuadros atípicos y búsqueda de inmunosupresión

Durante las preguntas finales se comenta que un herpes zóster:

- muy extenso;
- diseminado;
- recurrente;
- persistente;
- severo;

puede hacer necesario investigar un estado de inmunosupresión subyacente, por ejemplo:

- VIH;
- enfermedad neoplásica no diagnosticada;
- otras causas de deterioro inmunológico.

BADBEAR.MED FIJA:

Herpes zóster atípico/diseminado → no te quedes solo con el diagnóstico dermatológico: busca inmunosupresión.

44. Tratamiento del herpes zóster

La clase menciona como antiviral principal:

aciclovir.

También resalta que las dosis utilizadas son mayores que las descritas para herpes simple. Además, el manejo debe incluir tratamiento adecuado del dolor.

45. Manejo del dolor

Entre los fármacos mencionados para dolor neuropático se encuentran:

- gabapentina;
- pregabalina;
- antidepresivos tricíclicos como amitriptilina en determinados casos.

En casos muy complejos o refractarios puede requerirse participación de Neurología.

HERPES SIMPLE VS HERPES ZÓSTER

Característica	Herpes simple	Herpes zóster
Lesión	Vesículas agrupadas	Vesículas agrupadas
Base	Eritematosa	Eritematosa
Distribución	Localizada	Dermatómica
Dolor prodrómico	Puede existir	Muy característico e intenso
Latencia	Ganglios sensitivos	Ganglios sensitivos
Recurrencia	Frecuente	Reactivación de VZV
Antecedente clave	Episodios previos	Varicela previa
Complicación destacada	—	Neuralgia posherpética
Diseminación	Inmunosupresión	Especialmente inmunosupresión

TEMA 4. INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

46. Concepto

El **virus del papiloma humano (VPH)** produce diferentes lesiones cutáneas y mucosas.

La manifestación dermatológica más característica es la:

VERRUGA.

La clase describe diferentes morfologías:

- verruga vulgar;
- verruga filiforme;

- verruga plana;
- verruga plantar;
- verruga genital.

47. Diversidad de genotipos

Se describen numerosos genotipos capaces de afectar:

- piel;
- mucosas.

Algunos se relacionan predominantemente con verrugas benignas y otros con lesiones de potencial oncogénico.

48. Genotipos de alto riesgo destacados

La clase recalca especialmente:

VPH 16 y 18.

Los relaciona con neoplasias de diferentes localizaciones anogenitales.

También menciona otros genotipos relacionados con lesiones oncogénicas, como 31, 33 y 35.

BADBEAR.MED FIJA:

VPH de alto riesgo que no debes olvidar: 16 y 18.

49. Transmisión

El VPH puede transmitirse mediante:

- contacto directo;
- contacto con superficies u objetos contaminados;
- contacto sexual en formas genitales.

Los microtraumatismos facilitan la entrada del virus.

50. Papel de los microtraumatismos

La piel dañada constituye una puerta de entrada.

Los factores mencionados incluyen:

- erosiones;
- fisuras;

- traumatismos;
- maceración;
- fricción.

El virus alcanza posteriormente las capas profundas de la epidermis y modifica los queratinocitos.

51. Autoinoculación

Una persona puede trasladar el virus desde una verruga hacia piel cercana mediante:

- rascado;
- manipulación;
- traumatismo;
- fricción.

Esto explica por qué una lesión inicialmente única puede evolucionar hacia múltiples verrugas.

BADBEAR.MED FIJA:

Verruga + manipulación/rascado → AUTOINOCULACIÓN → más verrugas.

52. Inmunosupresión

Los pacientes inmunosuprimidos presentan mayor riesgo de:

- verrugas extensas;
- persistencia;
- progresión rápida;
- lesiones de mayor tamaño;
- determinadas complicaciones neoplásicas.

La clase resalta especialmente pacientes con VIH y alteraciones inmunológicas importantes.

53. Genotipos mencionados según lesión

La clase relaciona:

- VPH 1 → verrugas palmoplantares;
- VPH 2 → verrugas vulgares;
- VPH 3 y 10 → verrugas planas;
- VPH 6 y 11 → verrugas genitales/condilomas;

- VPH 16 y 18 → lesiones de alto riesgo oncogénico.

TEMA 4A. VERRUGA VULGAR

54. Presentación

Es una de las formas más frecuentes.

Puede localizarse en distintas zonas, especialmente:

- manos;
- dedos;
- extremidades.

La lesión se describe como:

- pápula;
- placa;
- superficie rugosa;
- verrugosa;
- queratinizada.

55. Distribución lineal por traumatismo

Si el paciente se rasca una verruga y produce una excoriación, pueden aparecer nuevas lesiones siguiendo el trayecto de la lesión traumática.

Esto representa nuevamente la autoinoculación.

56. Verruga periungueal

Las verrugas localizadas alrededor de la uña requieren cuidado.

Pueden afectar estructuras próximas a la **matriz ungueal** y producir alteraciones en el crecimiento de la uña.

BADBEAR.MED FIJA:

Verruga periungueal → cuidado con la MATRIZ UNGUEAL.

Una lesión o tratamiento agresivo en esta región puede favorecer distrofia ungueal.

57. Vasos trombosados

Una característica especialmente útil en verrugas es la presencia de pequeños puntos:

- rojizos;

- oscuros;
- negros.

Representan pequeños **vasos trombosados**.

BADBEAR.MED FIJA:

PUNTOS NEGROS/ROJIZOS dentro de una lesión hiperqueratósica = vasos trombosados → piensa en VERRUGA.

TEMA 4B. VERRUGA FILIFORME

58. Características

Es una variante de verruga vulgar.

Aparece frecuentemente en la cara, especialmente:

- párpados;
- alrededor de los ojos;
- nariz;
- alrededor de labios.

Puede presentar prolongaciones delgadas y queratinizadas semejantes a pequeñas espículas.

59. Cuerno cutáneo

En algunas lesiones existe una acumulación importante de queratina formando una estructura semejante a un cuerno.

La clase enfatiza que el “cuerno” está constituido fundamentalmente por queratina.

Lo importante clínicamente es evaluar:

LA BASE.

Porque la lesión subyacente puede corresponder a diferentes enfermedades.

BADBEAR.MED FIJA:

CUERNO CUTÁNEO: el diagnóstico no está en la queratina; está en la BASE.

TEMA 4C. VERRUGAS PLANAS

60. Morfología

Se presentan como:

pápulas aplanadas.

Pueden ser:

- del color de la piel;
 - hipocrómicas;
 - discretamente eritematosas;
 - algo más oscuras dependiendo del fototipo.
-

61. Localización

Son frecuentes en:

- cara;
- brazos;
- manos.

La apariencia clínica puede variar considerablemente según el fototipo cutáneo.

TEMA 4D. VERRUGA PLANTAR

62. Factores predisponentes

La clase menciona:

- caminar descalzo;
 - playa;
 - microtraumatismos repetidos;
 - presión;
 - fricción.
-

63. Morfología

Se presenta como:

- pápula o placa hiperqueratósica;
- localizada en zona de apoyo;
- con pequeños puntos oscuros.

Estos puntos corresponden a los vasos trombosados anteriormente descritos.

64. Localizaciones frecuentes

Se mencionan:

- base del primer dedo;

- talón;
- arco anterior;
- otras zonas sometidas a presión.

65. Verruga plantar vs callo

Este es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes.

Verruga plantar

Puede presentar:

puntos negros o rojizos → vasos trombosados.

Callo

Predomina una:

placa hiperqueratósica amarillenta, sin los puntos vasculares típicos.

BADBEAR.MED FIJA:

Verruga plantar vs callo: BUSCA PUNTOS NEGROS.

Puntos negros/rojizos = **vasos trombosados → verruga.**

TEMA 4E. VERRUGAS GENITALES

66. Concepto

Las verrugas genitales representan una infección de transmisión sexual.

Pueden aparecer tanto en:

- piel;
- mucosas.

67. Evolución

Pueden comenzar como:

una pequeña pápula.

Con el tiempo pueden:

- aumentar de tamaño;
- confluir;
- formar placas;
- desarrollar tumoraciones exofíticas.

Cuando presentan la clásica configuración de:

“COLIFLOR”

se denominan:

CONDILOMAS ACUMINADOS.

BADBEAR.MED FIJA:

Verruga genital exofítica en “coliflor” = CONDILOMA ACUMINADO.

68. Localización

Pueden encontrarse en:

- genitales femeninos;
- genitales masculinos;
- región perianal.

La fricción facilita la propagación local.

69. Lesiones sospechosas

En pacientes inmunosuprimidos las lesiones pueden progresar más rápidamente.

La clase señala que una lesión:

- sangrante;
- granulomatosa;
- progresiva;
- resistente al tratamiento convencional;

debe ser estudiada mediante biopsia para descartar malignidad.

BADBEAR.MED FIJA:

Verruga genital que crece, sangra y no responde → BIOPSIA.

70. Tratamiento de las verrugas

La clase explica que el tratamiento se dirige fundamentalmente a:

DESTRUIR LA LESIÓN.

Entre las opciones mencionadas:

- sustancias queratolíticas;
- ácido salicílico;

- ácido láctico;
- ácido tricloroacético;
- crioterapia;
- electrocirugía;
- 5-fluorouracilo;
- imiquimod;
- otros procedimientos según localización.

La crioterapia ocupa un lugar especialmente destacado dentro de la exposición.

71. Crioterapia

Consiste en destruir la lesión mediante congelación.

La clase destaca como ventaja que:

- no produce el mismo tipo de sangrado;
 - permite destruir la lesión;
 - es uno de los métodos usados con frecuencia.
-

TEMA 5. POXVIRUS Y MOLUSCO CONTAGIOSO

72. Familia Poxviridae

La última parte de la clase introduce infecciones producidas por poxvirus.

Se mencionan distintas enfermedades relacionadas con diferentes mamíferos y se destaca posteriormente la infección que se observa con frecuencia en Dermatología:

MOLUSCO CONTAGIOSO.

73. Concepto de molusco contagioso

El molusco contagioso es una infección viral cutánea producida por un poxvirus específico del ser humano.

La clase diferencia su comportamiento según el paciente:

Niños

Generalmente:

- benigno;
- autolimitado.

Adultos

Las lesiones genitales pueden asociarse con transmisión sexual.

Inmunosuprimidos

Pueden aparecer:

- lesiones numerosas;
- diseminadas;
- atípicas;
- de mayor tamaño.

74. Transmisión

La transmisión se produce principalmente por:

contacto directo piel con piel.

75. Lesión elemental característica

La lesión fundamental es una:

PÁPULA.

Pero posee unas características muy particulares:

- perlada;
- nacarada;
- blanquecina o rosada;
- superficie lisa;
- **umbilicada en el centro.**

BADBEAR.MED FIJA:

MOLUSCO CONTAGIOSO = PÁPULA PERLADA/NACARADA + UMBILICACIÓN CENTRAL.

Esta es probablemente la asociación más importante del tema.

76. ¿Qué significa umbilicación?

Significa que existe una pequeña depresión en el centro de la pápula.

Puede observarse como:

- depresión clara;
- pequeña zona blanquecina;
- en algunas lesiones, una costra central.

77. Localizaciones

Se mencionan con frecuencia:

- pliegues;
- tronco;
- extremidades superiores;
- cara;
- región genital.

La distribución depende mucho de:

- edad;
- mecanismo de transmisión;
- estado inmunológico.

78. Molusco en niños

En los niños las lesiones pueden aparecer principalmente en:

- tronco;
- extremidades superiores;
- cara.

Muchas pueden resolverse espontáneamente.

79. Molusco en adultos

En adultos, cuando predomina la distribución genital, la clase lo relaciona principalmente con: **transmisión sexual.**

80. Molusco e inmunosupresión

Este es un punto de alta importancia clínica.

En pacientes inmunodeprimidos pueden observarse:

- numerosas lesiones;
- lesiones generalizadas;
- compromiso facial;
- lesiones atípicas;

- rápida diseminación.

La clase relaciona especialmente estos cuadros con pacientes con VIH avanzado.

BADBEAR.MED FIJA:

Molusco contagioso múltiple, gigante, facial o diseminado en adulto → busca INMUNOSUPRESIÓN.

81. Dermatitis por molusco

En pacientes con dermatitis atópica puede desarrollarse inflamación eccematosa asociada a las lesiones.

La clase denomina este fenómeno:

dermatitis por molusco.

82. Molusco genital en niños

La localización genital en un niño requiere una anamnesis muy cuidadosa.

La clase señala la importancia de evaluar:

- cuidadores;
- convivencia;
- forma de contacto;
- contexto familiar;

y considerar cuidadosamente la posibilidad de exposición inapropiada cuando el contexto clínico lo sugiera.

83. Tratamiento del molusco contagioso

El tratamiento consiste principalmente en la **destrucción o extracción de las lesiones**.

La clase considera especialmente efectivo:

CURETAJE.

84. Curetaje

Se utiliza una cureta para retirar la lesión.

Al hacerlo puede salir el contenido blanquecino característico.

El principal problema es que puede ser difícil de tolerar en niños pequeños.

85. Otras alternativas

La clase menciona:

- queratolíticos;
- ácido salicílico;
- ácido láctico;
- ácido retinoico;
- crioterapia;
- electrocauterización;
- láser.

La elección depende de:

- edad;
- número de lesiones;
- localización;
- tolerancia.

86. Múltiples moluscos

Cuando existen numerosas lesiones, especialmente en adultos, debe investigarse la posibilidad de:

inmunosupresión.

CUADRO COMPARATIVO DE LESIONES VIRALES

Enfermedad	Lesión que debes reconocer	Distribución clave
Herpes simple	Vesículas agrupadas	Orolabial/genital
Herpes zóster	Vesículas agrupadas dolorosas	Dermatoma
Verruga vulgar	Pápula/placa rugosa hiperqueratósica	Manos/dedos
Verruga plana	Pápula aplanada	Cara, manos, brazos
Verruga plantar	Placa hiperqueratósica + puntos negros	Planta
Condiloma acuminado	Masa verrugosa en coliflor	Genital/perianal
Molusco contagioso	Pápula perlada umbilicada	Variable, genital en adultos

HERPES SIMPLE VS ZÓSTER VS MOLUSCO VS VERRUGA

Herpes simple

Vesículas agrupadas

- ardor
- recurrencias localizadas.

Herpes zóster

Vesículas en dermatoma

- dolor neurítico intenso
- antecedente de varicela.

Molusco

Pápula perlada/nacarada

- depresión central.

Verruga

Pápula hiperqueratósica y rugosa

- vasos trombosados en algunas variantes.

BADBEAR.MED FIJA — REPASO DE ALTA RENTABILIDAD

1. Herpesvirus tienen capacidad de **LATENCIA y REACTIVACIÓN**.
2. HSV y VZV permanecen relacionados con ganglios sensitivos.
3. Estrés, fiebre, UV, trauma e inmunosupresión pueden reactivar herpes.
4. HSV-1 predomina clásicamente en región orolabial, pero puede producir herpes genital.
5. HSV-2 predomina clásicamente en genitales, pero la distribución no es absolutamente exclusiva.
6. Herpes simple = **VESÍCULAS AGRUPADAS** sobre base eritematosa.
7. Imagen clásica del herpes simple = “racimo de uvas”.
8. Ardor/quemazón antes de las vesículas = **pródromo herpético** importante.
9. Primoinfección herpética suele ser más intensa que una recurrencia.
10. Herpes genital puede llegar a consulta como erosiones o úlceras porque las vesículas ya se rompieron.
11. Tinción de Tzanck → células gigantes multinucleadas.
12. Herpes muy recurrente o diseminado → investigar inmunosupresión.
13. Varicela = primoinfección por virus varicela-zóster.

14. Herpes zóster = reactivación del virus varicela-zóster.
15. Herpes zóster sigue un DERMATOMA.
16. Dermatóma torácico = localización frecuente destacada en la clase.
17. Dolor urente/lancinante que precede a vesículas dermatómicas → herpes zóster.
18. Complicación destacada del zóster = NEURALGIA POSHERPÉTICA.
19. >20 vesículas fuera del dermatoma inicial = criterio utilizado en clase para zóster diseminado.
20. Zóster diseminado/atípico → buscar inmunosupresión.
21. VPH produce verrugas.
22. VPH 16 y 18 = genotipos de alto riesgo que deben memorizarse.
23. Microtraumas y maceración favorecen infección y autoinoculación por VPH.
24. Verruga vulgar = pápula/placa rugosa, verrugosa e hiperqueratósica.
25. Verruga periungueal puede comprometer matriz ungueal.
26. Puntos negros en verruga = VASOS TROMBOSADOS.
27. Verruga plantar vs callo → busca puntos negros/rojizos.
28. Verruga genital tipo coliflor = CONDILOMA ACUMINADO.
29. Verruga genital sangrante, progresiva y resistente al tratamiento → BIOPSIA.
30. Molusco contagioso = PÁPULA PERLADA/NACARADA UMBILICADA.
31. Molusco genital en adulto → considerar transmisión sexual.
32. Moluscos múltiples o diseminados en adulto → investigar inmunosupresión.
33. Curetaje = tratamiento especialmente efectivo del molusco mencionado en la clase.

RAZONAMIENTO CLÍNICO PARA EXAMEN

Caso 1

Paciente presenta ardor en el labio y 24 horas después aparecen múltiples pequeñas vesículas agrupadas sobre una base roja.

→ **HERPES SIMPLE.**

La clave:

vesículas agrupadas + pródromo urente.

Caso 2

Adulto mayor presenta dolor tipo quemazón intenso en un lado del tórax. Dos días después aparecen vesículas agrupadas siguiendo una banda desde la espalda hacia la región anterior.

→ **HERPES ZÓSTER.**

La clave:

dolor neurítico + distribución dermatómica.

Caso 3

Paciente con VIH presenta numerosas vesículas fuera del dermatoma inicial.

→ pensar en:

HERPES ZÓSTER DISEMINADO.

Y el segundo razonamiento debe ser:

inmunosupresión significativa.

Caso 4

Paciente presenta lesión hiperqueratósica plantar que parece un callo, pero al examinarla aparecen varios puntos negros.

→ **VERRUGA PLANTAR.**

Los puntos negros corresponden a:

vasos trombosados.

Caso 5

Paciente presenta múltiples tumoraciones verrugosas anogenitales con aspecto de coliflor.

→ **CONDILOMAS ACUMINADOS.**

Caso 6

Niño presenta múltiples pápulas pequeñas, brillantes, perladas y con una pequeña depresión en el centro.

→ **MOLUSCO CONTAGIOSO.**

La clave:

PÁPULA + NACARADA + UMBILICACIÓN CENTRAL.

IDEA CENTRAL DE LA CLASE

Las enfermedades virales de esta clase pueden diferenciarse rápidamente por su **lesión elemental y patrón de distribución**:

VESÍCULAS AGRUPADAS LOCALIZADAS

→ herpes simple.

VESÍCULAS AGRUPADAS + DERMATOMA + DOLOR

→ herpes zóster.

PÁPULA/PLACA RUGOSA E HIPERQUERATÓSICA

→ verruga por VPH.

PÁPULA PERLADA UMBILICADA

→ molusco contagioso.

Y hay una segunda pregunta que siempre debe acompañar el diagnóstico:

¿EL PACIENTE ESTÁ INMUNOSUPRIMIDO?

Porque tanto:

- herpes simple;
- herpes zóster;
- verrugas por VPH;
- molusco contagioso

pueden presentar formas mucho más extensas, persistentes o atípicas cuando existe deterioro de la inmunidad.

Clase 8: pendiente las clases

Clase 9: pendiente las clases

Clase 10: pendiente las clases

Clase 11: pendiente las clases

Clase 12: pendiente las clases

Clase 13: pendiente las clases

Clase 14: pendiente las clases

Clase 15: pendiente las clases

Clase 16: pendiente las clases

BADBEAR.MED

"La piel
también cuenta
historias" ♥



BADBEAR.MED

Aprende Medicina. Comprende la Ciencia. Domina la Clínica.

CIENCIA
DISCIPLINA
HUMANIDAD



WAJOMEA.GROUP

M E D I C I N A

DERMATOLOGÍA

CLÍNICA | DIAGNÓSTICO | PATOLOGÍA | TERAPÉUTICA

EDICIÓN ACADÉMICA 2026



LESIONES
ELEMENTALES



DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL



PATOLOGÍA
CUTÁNEA



TRATAMIENTO
ACTUALIZADO

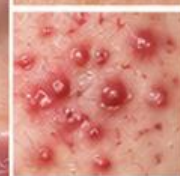


PROCEDIMIENTOS
DERMATOLÓGICOS

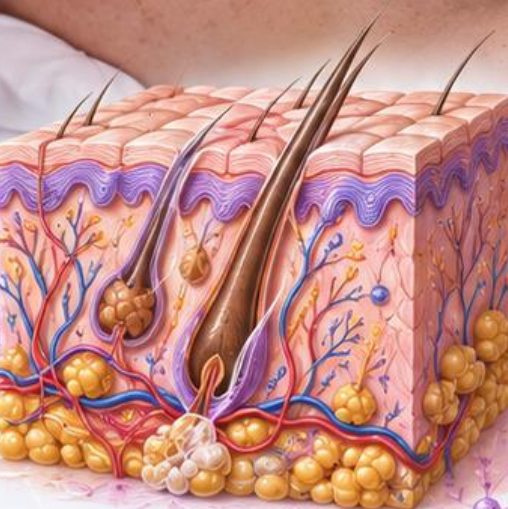
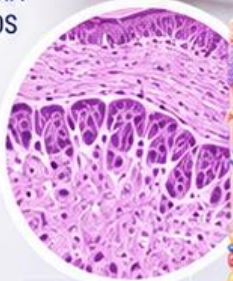


DERMATOLOGÍA
EN CONTEXTOS
ESPECIALES

"Más que piel,
personas" ♥



Observar
Analizar
Diagnosticar
Tratar
Educar
Prevenir



CONOCIMIENTO QUE TRASCIENDE



@badbear.med



@badbear.med



BADBEAR.MED



t.me/badbear_med



vk.com/badbear_med



facebook.com/badbear.med



onlyfans.com/badbear.med

DERMATOLOGÍA

MEDICINA

BADBEAR.MED



WAJOMEA.GROUP